

Manual de Governação Clínica

Serviço de Medicina Intensiva

Novembro/2024



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
LISBOA OCIDENTAL

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança Clínica	
Manual	

Âmbito da aplicação do Manual de Governança Clínica

Serviço de Medicina Intensiva da Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental e outras áreas de potencial influência deste.

Destinado a:

Médicos, Enfermeiros, Técnicos Auxiliares de Saúde, Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos do Serviço de Medicina Intensiva da Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental

Compromisso de Revisão e Atualização:

Este Manual será revisto, atualizado e avaliado a cada três anos, ou sempre.

Elaboração	Revisão	Aprovação	Próxima edição
Dr. Pedro Santos Dra. Gabriela Almeida	Dra. Marta Rebelo	Assinado por : António José Pereira Pais Martins Num. de Identificação: BI04475691 Data: 2024.11.15 10:30:48 Hora padrão de GMT  CHAVE MÓVEL rtins	06/2027
		Data: 01/10/2024	Página: 1/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

Índice

1- Introdução.....	3
2- Missão e Valores.....	4
2.1 Missão da ULSLO.....	4
3- Caracterização do Serviço de Medicina Intensiva	5
3.1- Estrutura	5
3.2- Missão do SMI.....	6
3.2- Princípios do SMI	6
3.3- Objetivos do SMI.....	7
3.4- Rede de Referência.....	10
4- Análise SWOT	11
5- Recursos Humanos e Físicos	12
5.1- Recursos Humanos	12
5.2- Recursos Físicos	13
6- Gestão de Risco.....	17
6.1- Metodologia	17
6.2- Escala de Riscos	18
6.3- Matriz de Riscos.....	18
6.4- Riscos por Áreas Assistenciais.....	38
6.5- Plano de Auditorias do SMI	39
7- Abreviaturas e Glossário.....	41
8- Anexos	42

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	2/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

1- Introdução

A Medicina Intensiva (MI) é uma área multidisciplinar das ciências médicas de prevenção, diagnóstico e tratamento de doentes graves com falência potencialmente reversível de uma ou mais funções vitais. O objetivo primordial da MI é suportar e recuperar funções vitais, através do tratamento da(s) doença(s) envolvidas, promovendo a recuperação dos doentes com a melhor qualidade de vida possível.

A governança clínica é um processo integrador, onde as organizações de saúde se responsabilizam pela melhoria contínua da qualidade dos seus serviços e pela salvaguarda dos cuidados prestados.

O Serviço de Medicina Intensiva (SMI) da Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental (ULSLO) foi criado institucionalmente em dezembro de 2021, passando a integrar as quatro unidades de cuidados intensivos do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental sob a mesma gestão clínica e organizando-as funcionalmente num único serviço. Este processo permitiu uma melhor gestão e partilha dos recursos disponíveis, pautada por uma estratégia comum, permitindo, ainda, a atribuição ao SMI-ULSLO de Idoneidade Formativa Total para a Formação Específica em Medicina Intensiva a 6 de setembro de 2022.

Com o presente documento descrevemos o propósito e a missão do SMI – ULSLO, apresentamos a sua organização interna, competências e processos assistenciais e incluímos os resultados dos processos de auditoria a alguns dos indicadores de qualidade e segurança utilizados.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	3/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

2- Missão e Valores

2.1 Missão da ULSLO

A Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental tem como missão prestar cuidados de saúde humanizados, com elevados níveis de qualidade e rigor técnico e científico e elevada diferenciação clínica, em articulação com as entidades integradas na rede de prestação de cuidados de saúde, promovendo a investigação, o ensino e a formação pré e pós graduada, a diferenciação e a realização profissional dos seus colaboradores.

Valores e Princípios da ULSLO

No exercício da sua atividade, a ULS rege-se, nomeadamente, pelos seguintes valores e princípios:

- Humanização e não discriminação;
- Respeito pela dignidade individual de cada pessoa;
- Excelência técnico-profissional;
- Ética e deontologia profissional;
- Atualização face aos avanços da investigação e da ciência;
- Promoção da multidisciplinaridade e do espírito de equipa;
- Promoção da saúde na comunidade;
- Sustentabilidade ambiental, económica e financeira.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	4/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

3- Caracterização do Serviço de Medicina Intensiva

3.1- Estrutura

O SMI integra diferentes valências, distribuídas pelos 3 hospitais da ULSLO (Figura 1):

- Unidades de Cuidados Intensivos/ Intermédios, UCI-1 e UCI-2 no HEM, UCI-3 e UCI-4 no HSFX.
- Equipas de Emergência Médica Intra-hospitalar, no HEM e no HSFX.
- Consulta de Follow-Up do Doente Crítico, no HEM e no HSFX.
- Circuito do Doente Crítico, no HSFX.
- Circuito do Doente Neurocrítico UML/HEM, no HEM.
- Consultadoria à UCI da Cirurgia Cardíaca, no HSC.

Serviço de Medicina Intensiva

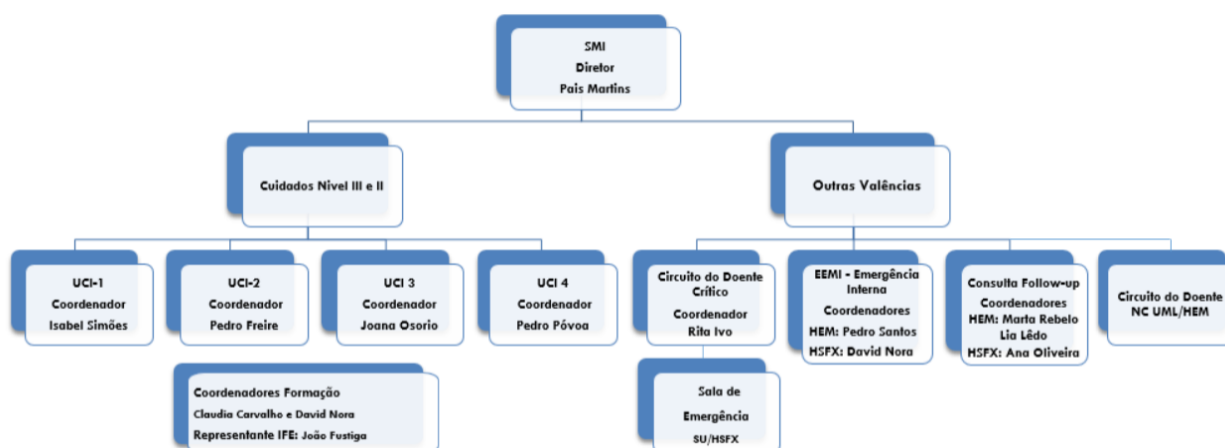


Figura 1- Organograma do Serviço de Medicina Intensiva da ULSLO

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	5/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

3.2- Missão do SMI

O SMI é uma estrutura orgânica integrada na Área do Doente Crítico da ULSLO, que presta assistência, ensino e investigação na área do doente crítico e emergente. Constitui ainda o Centro do Polo Ocidental de Referência em Medicina Intensiva da ARSLVT, num eixo que integra também os SMI do Hospital de Cascais, ULS Almada (Hospital Garcia de Orta), ULS Arrábida (Centro Hospitalar de Setúbal e ULS do Arco Ribeirinho (Centro Hospitalar Barreiro-Montijo).

A missão do SMI passa pela organização e coordenação dos recursos existentes na ULSLO, com vista à criação de áreas dirigidas à assistência clínica, investigação e formação pré e pós-graduada no campo do doente crítico, contribuindo desta forma para uma melhor prestação de cuidados, aliada a maior eficiência técnica e social e melhor qualificação e rentabilização das estruturas que utiliza.

O SMI tem ainda como objetivo a formação contínua dos seus profissionais, apostando na sua atualização profissional e científica, de modo a assegurar uma melhoria contínua dos serviços prestados.

3.2- Princípios do SMI

O SMI-ULSLO rege-se por princípios integrados na carta de direitos do doente internado:

Cuidado centrado no doente – tratar o doente com respeito pela dignidade humana e liberdade individual, nas suas convicções culturais, filosóficas e religiosas e com respeito pela sua privacidade.

Tratamento apropriado – prestar os cuidados apropriados com a melhor estratégia terapêutica que a situação clínica particular do doente justifique, no âmbito dos cuidados preventivos, curativos, de reabilitação, terminais e paliativos, respeitando a continuidade dos seus cuidados.

Cuidados informados – esclarecer o doente e/ou o seu cuidador de referência, tomando em conta a sua vontade, o cuidado com o seu sofrimento e conforto. Informar acerca da sua situação de saúde, dos serviços de saúde existentes, suas competências e níveis de cuidados; enquadrado no direito de confidencialidade e consentimento.

Eficiência – responder às necessidades de todos os nossos doentes, num tempo tão curto quanto possível e com racionalização de meios.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	6/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

3.3- Objetivos do SMI

3.3.1- Objetivos Estratégicos

Os objetivos do SMI passam por promover a resposta adequada às necessidades em Medicina Intensiva da população abrangida pela ULSLO, com o consequente aumento dos níveis de satisfação da população e incluem:

- Melhoria contínua dos níveis de qualidade e diferenciação científica e técnico-profissional, de acordo com o estado da arte e as boas práticas clínicas.
- Melhoria contínua do equipamento técnico do Serviço.
- Aumentar os níveis de Recursos Humanos do serviço até atingir um ratio adequado à população atendida.
- Promover a capacidade de captação de profissionais motivados e diferenciados com níveis de eficiência e satisfação elevados.
- Promover a humanização de cuidados e o trabalho em equipa.
- Atingir as metas e objetivos contratualizados no contrato-programa.
- Promover a realização de protocolos clínicos baseados na evidência científica mais recente.
- Promover a adesão às normas de orientação clínica em vigor.
- Responder ao tratamento do doente crítico em todo o perímetro das instituições hospitalares que compõem a ULSLO (utilizando para tal as suas valências de *Outreach*: CDC, EEMI, Consultadoria).
- Promover a participação ativa, conducente à atualização científica dos Profissionais do SMI, em reuniões científicas nacionais e internacionais.
- Participar em estudos multicêntricos nacionais e internacionais na área dos cuidados intensivos.
- Manter a nossa colaboração em ensaios clínicos multicêntricos e consolidar a apresentação de trabalhos científicos em Reuniões Científicas Nacionais e Internacionais e a publicação de artigos científicos.
- Certificação do Serviço de Medicina Intensiva pelo modelo ACSA.
- Melhoria contínua e racional do controle de custos mantendo a eficácia.
- Melhorar a qualidade dos registos eletrónicos, com integração das diferentes plataformas utilizadas, sem perda da informação.
- Obtenção da idoneidade total do Serviço para a formação complementar em Medicina Intensiva;

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	7/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

- Manter-se como um dos serviços de referência para Estágios de curta/média duração de médicos no período de formação complementar em outras Especialidades, de Internos do Ano Comum, de estudantes de Medicina, de Enfermeiros, de estudantes de Enfermagem, de estudantes de Fisioterapia, e de estudantes dos cursos profissionalizantes em Técnicos Auxiliares de Saúde.
- Avaliação da satisfação dos utentes/familiares com a elaboração e avaliação dos resultados de questionários de satisfação adaptados à atividade do Serviço.
- Implementação do Plano de Ação com vista à melhoria contínua.
- Elaboração e implementação de um processo de monitorização e gestão do risco.
- Monitorização, avaliação dos resultados da aplicação, através de auditoria interna aos principais indicadores de qualidade e segurança.

3.3.2- Objetivos de Qualidade

Indicadores de qualidade são sistemas de controlo no contexto da gestão da qualidade médica. Não são um fim em si, mas um instrumento de acompanhamento e medição do desempenho da UCI, para garantir a qualidade do serviço prestado e ajudar na tomada de decisões nas áreas com potencial de melhoria. Após a definição de quais os indicadores a serem medidos, e quais as metas para cada um de acordo com o estado da arte, eles são auditados e difundidos com o objetivo de se definirem estratégias de melhoria.

O SMI define e audita indicadores de qualidade em diferentes contextos:

- Indicadores de produção / efetividade
- Indicadores de qualidade, no contexto do cumprimento das Normas de Orientação Clínicas (NOC) emitidas pela Direção Geral de Saúde (DGS)
- Indicadores de qualidade, no contexto da avaliação da implementação dos Processos Assistenciais Integrados definidos para o Serviço de Medicina Intensiva
- Indicadores de qualidade, no contexto de avaliação do Processo Clínico do doente
- Indicadores de segurança, no contexto do cumprimento das Normas de Orientação Clínicas (NOC) emitidas pela Direção Geral de Saúde (DGS)
- Indicadores de comunicação com o doente, que fazem parte da auditoria ao Processo Clínico do doente

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	8/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

De seguida explicam-se os diferentes itens avaliados e em que contexto e anexam-se, no final do manual, os resultados das auditorias internas mais recentes (referentes ao ano anterior da realização do manual).

3.3.2.1- Indicadores de Produção / Efetividade

O SMI realiza o acompanhamento e avaliação anual global dos seguintes parâmetros, divulgando-os em reunião de serviço e estando consultáveis na área dedicada ao SMI da intranet da ULSLO.

Os objetivos definidos pelo SMI para cada indicador são em concordância com a contratualização realizada com a administração da ULSLO, valores da literatura internacional e/ou NOC da DGS.

Linha de Produção	Proposta Inicial de Meta para 2024					Contraproposta do serviço			
	2022	2023	Var % 23/22	Meta 2024	Var % 24/23	Var % 24/22	Meta 2024	Var % 24/23	Var % 24/22
Consulta Externa									
Total Consultas Médicas	82	226	175,60%	324	43,40%	295,10%	247	9,30%	201,20%
Primeiras Consultas	62	215	246,80%	308	43,30%	396,80%	235	9,30%	279,00%
CSP via CTH	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Descentralizadas	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Outras	62	215	246,80%	308	43,30%	396,80%	235	9,30%	279,00%
Consultas Subsequentes	20	11	-45,00%	16	45,50%	-20,00%	16	45,50%	-20,00%
Descentralizadas	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Outras	20	11	-45,00%	16	45,50%	-20,00%	16	45,50%	-20,00%
Total de Doentes em LEC (médicas)	3	64	2033,30%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-
% Consultas médicas com registo de alta	31,70%	32,70%	1 pp	50,00%	17,3 pp	18,3 pp	-	-32,7 pp	-31,7 pp
Internamento									
Lotação Agudos (média do período)	36	32	-8,90%	38	17,10%	6,70%	40	23,20%	12,3%*
HEM-UCI-1	10	10	0,30%	10	4,70%	5,00%	9	-5,70%	-5,50%
HEM-UCI-2	8	8	0,00%	12	50,00%	50,00%	14	75,00%	75,00%
HSFX-UCI-3	9	8	-14,10%	9	16,40%	0,00%	9	16,40%	0,00%
HSFX-UCI-4	8	7	-12,00%	7	-2,50%	-14,20%	8	11,50%	-1,90%
Doentes Tratados	1 188	1 308	10,10%	1 871	43,00%	57,50%	1 430	9,30%	20,40%
HEM-UCI-1	328	391	19,20%	509	30,20%	55,20%	420	7,40%	28,00%
HEM-UCI-2	391	355	-9,20%	610	71,80%	56,00%	372	4,80%	-4,90%
HSFX-UCI-3	297	336	13,10%	481	43,20%	62,00%	346	3,00%	16,50%
HSFX-UCI-4	241	281	16,60%	350	24,60%	45,20%	292	3,90%	21,20%
Média do tempo de permanência na unidade	7,1	6,3	-11,00%	6,3	0,00%	-11,00%	-	-100,00%	-100,00%
HEM-UCI-1	7,7	6,1	-20,50%	6,1	0,00%	-20,50%	-	-100,00%	-100,00%
HEM-UCI-2	5,4	6,1	13,10%	6,1	0,00%	13,10%	-	-100,00%	-100,00%
HSFX-UCI-3	6,5	5,8	-11,00%	5,8	0,00%	-11,00%	-	-100,00%	-100,00%
HSFX-UCI-4	7,7	6,2	-19,50%	6,2	0,00%	-19,50%	-	-100,00%	-100,00%

*Abertura das 6 camas na Ucinter NC

Edição		Próxima edição		Página
Nº 01	11/2024		11/2027	9/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

3.3.2.2 - Indicadores de Qualidade – Normas Clínicas

Face à necessidade de prevenção das infeções nosocomiais, o Serviço de Medicina Intensiva tem implementadas auditorias internas anuais, denominadas:

- 5 Momentos da Higienização das Mãos;
- Feixes de Intervenção da “Pneumonia associada à intubação”;
- Feixes de Intervenção de “Prevenção de Infeção Relacionada com Cateter Venoso Central;
- Medidas de Isolamento e Higienização das Unidades.

Estas avaliações advêm da necessidade de avaliar os *scores* de conformidade dos procedimentos (atualmente definido como objetivo/meta para índice de conformidade global»85%).

São realizadas auditorias internas, com posterior elaboração de relatório e sessões de divulgação dos resultados, com o objetivo de sensibilização dos profissionais, identificação de áreas de melhoria e implementação de medidas ativas na prevenção e controlo das infeções, melhorando desta forma a qualidade da assistência em saúde.

3.4- Rede de Referenciação

A Rede Nacional de Especialidade Hospitalar e de Referenciação em Medicina Intensiva foi revista pela última vez em agosto de 2020, no contexto da pandemia SARS-CoV-2.

Nos seus princípios orientadores é proposto manter uma organização em rede, “orientada por lógicas regionais e eixos preferências de referenciação”, tendo a ULSLO (Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental na altura de elaboração do documento) sido considerada um dos polos da rede de referenciação da ARSLVT, num eixo que inclui também o Hospital de Cascais, a ULS de Almada (H. Garcia de Orta), a ULS do Arco Ribeirinho (CH Barreiro-Montijo) e a ULS da Arrábida (CH Setúbal).

Para além dos doentes potencialmente referenciados pelas outras instituições do seu eixo de referenciação, o SMI-ULSLO recebe doentes provenientes diretamente do seu Serviço de Urgência Geral, Urgência Obstétrica, Blocos Operatórios, Serviços de Internamento, não só por referenciação direta das especialidades envolvidas no cuidado aos doentes, como também por referenciação interna a partir do Circuito do Doente Crítico (CDC), Consultadoria na UCI Cirurgia Cardio-Torácica (CCT) e das equipas de EEMI.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	10/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

4- Análise SWOT

A análise SWOT [*Strengths* (Pontos fortes), *Weaknesses* (Pontos fracos), *Opportunities* (Oportunidades) e *Threats* (Ameaças)] apresentada para o SMI, revela como exemplos de importantes Pontos fortes (**FORÇAS**):

- Equipa médica com elevado grau de diferenciação,
- Formação pré e pós-graduada,
- Programas de controlo de infeção
- Prevenção de úlceras de pressão e de quedas.

Os Pontos fracos (**FRAQUEZAS**) identificados para o Serviço de Medicina Intensiva:

- Problema estrutural/geográfico pela distribuição dos 4 Unidades de Cuidados Intensivos por dois hospitais (HEM e HSFx)
- Subdimensionamento da UCI-2 e a incapacidade na admissão de todo o doente neurocrítico
- Deficiente estrutura Física
- O Plano de contingência do serviço de Urgência da ULSLO com a diminuição de admissões de doentes politraumatizados.

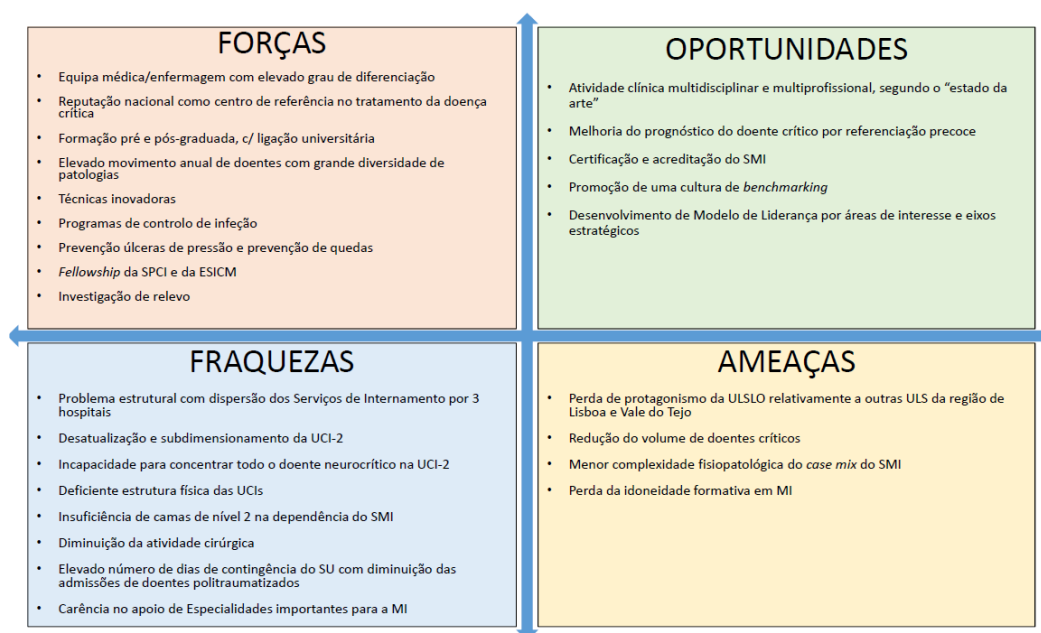


Figura 2- Análise SWAT

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	11/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

Como áreas de **OPORTUNIDADE** são apresentadas:

- Melhoria do prognóstico dos doentes admitidos com uma referenciação precoce
- Desenvolvimento de um modelo de liderança por áreas de interesse e eixos estratégicos
- Certificação do SMI
- Promoção de cultura de benchmarking

Às áreas de **AMEAÇA** identificadas:

- Perda do protagonismo da ULSLO comparativamente com as outras ULS.
- Redução de volume de doentes críticos.
- Perda de idoneidade formativa do SMI
- Menor complexidade fisiológica do *case mix* do SMI

5- Recursos Humanos e Físicos

5.1- Recursos Humanos

O SMI dispõe de um quadro de pessoal próprio, multidisciplinar e que integra as seguintes classes profissionais:

- Médicos
- Enfermeiros
- Assistentes Técnicos Auxiliares de Saúde
- Assistentes Técnicos
- Fisioterapeutas

Conta ainda com o apoio e a colaboração diária de elementos de outros Serviços Hospitalares, nomeadamente de:

- Farmacêuticos
- Técnicos de Cardiopneumologia
- Técnicos de Radiologia
- Técnicos de Eletrofisiologia

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	12/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

Os elementos das diferentes classes profissionais que integram o SMI, bem como a descrição das funções que lhes são atribuídas, encontram-se no Anexo I e II, nos documentos “Recursos Humanos do Serviço de Medicina Intensiva da ULSLO” e “Descrição das Funções dos Profissionais – Serviço de Medicina Intensiva da ULSLO”.

5.2- Recursos Físicos

5.2.1- Recursos Específicos do SMI

De modo a cumprir a sua missão, o SMI necessita de instalações adequadas e funcionais. Atualmente, dispõe de 4 unidades de Cuidados Intensivos, distribuídas por 2 dos hospitais da ULSLO (HEM e HSFX):

- A UCI-1, localizada no piso 5 do HEM e composta por um total de 11 camas holopotenciárias de nível 2/3, distribuídas por um *open-space* com 8 camas e por 3 quartos de isolamento individual com antecâmara e capacidade de pressão negativa.
- A UCI-2, localizada no piso 3 do HEM e composta por um total de 11 camas: 8 camas holopotenciárias de nível 2/3, distribuídas por um *open-space* com 6 camas e por 2 quartos de isolamento individuais, para além de dispor de 3 camas de nível 2 situadas numa sala à parte no mesmo piso.
- A UCI-3, localizada no piso -1 do HSFX e composta por um total de 9 camas holopotenciárias de nível 2/3, distribuídas por um *open-space* com 7 camas e por 2 quartos de isolamento individual.
- A UCI-4, localizada no Piso 1 do HSFX e composta por um total de 8 camas holopotenciárias de nível 2/3, distribuídas por 2 quartos com 4 camas cada um.

Para além dos espaços reservados à assistência clínica aos doentes internados, as 4 unidades incluem ainda zonas administrativas, salas de trabalho, gabinetes de coordenação, salas de reuniões, armazém, copa, instalações sanitárias, vestiários e zona de sujos/despejos. As instalações do SMI regem-se pelo documento RT 13/2019 V. 2024 da ACSS “Recomendações Técnicas para Instalações de Unidades de Cuidados Intensivos”.

No HSFX, o Circuito do Doente Crítico (CDC) integra-se no Serviço de Urgência Geral, avaliando os doentes que lhe são referenciados no SO ou na Sala de Reanimação. A Consultadoria à UCI de Cirurgia Cardíaca exerce-se no interior deste mesmo serviço e as Consultas de Follow-Up do Doente Crítico,

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	13/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

realizadas no HEM e no HSFx, são realizadas fora das Unidades, em Gabinetes de Consulta disponibilizados para o efeito.

5.2.2- Unidades de Suporte

Serviço Farmacêutico

Supervisiona a reconciliação terapêutica e fornece os fármacos específicos, soros e solutos solicitados de forma programada e com a devida e necessária brevidade.

Realiza validação de prescrições, participa na monitorização de terapêutica com antibióticos e ajuda a implementar os protocolos de antibioterapia instituídos no serviço e no centro hospitalar.

Serviço de Patologia Clínica e Microbiologia

Recebe as amostras devidamente identificadas e com protocolos predefinidos para várias situações clínicas na área de atuação.

O resultado fica disponibilizado no sistema informático. Existe a possibilidade de envio de amostras durante 24h por dia, possibilitando assim uma resposta em tempo adequado.

Serviço de Radiologia e Serviço de Neurorradiologia

Funciona durante 24 horas por dia, com possibilidade de dar resposta com brevidade, sempre que o pedido de exames complementares de diagnóstico é efetuado com carácter de urgência e inclui TC, RM, ecografia e radiografia convencional

Serviço de Tecnologias e Sistemas de Informação

Garantem a operacionalidade de todo o sistema informático com acesso a informação clínica, exames complementares, prescrição terapêutica e emissão de receitas. Possuem capacidade de intervenção, caso exista necessidade, 24 horas por dia. Garantem também o sistema de comunicações da ULSLO.

Outros Serviços Médicos da ULSLO

A ULSLO, como unidade hospitalar de nível 2, disponibiliza todos os serviços inerentes a essa qualidade, que são importantes na avaliação e seguimento dos doentes admitidos e tratados no serviço, mas que apresentam múltiplas co-morbilidades.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	14/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

Outros Serviços não Médicos da ULSLO

A ULSLO disponibiliza adicionalmente outros Serviços, não médicos de suporte, tais como:

- Comissão de Gestão de Risco,
- GCL PPCIRA,
- Departamento da Qualidade e Segurança do Doente (DQSD),
- Núcleo de Humanização (NH)
- Núcleo de Formação,
- Comissão de Ética,
- Serviços Hoteleiros,
- Serviços Jurídicos.

5.2.3- Manutenção de infraestruturas e equipamentos

A ULSLO assegura a existência e manutenção de um ambiente de trabalho adequado à prestação de cuidados hospitalares, nas valências de que dispõe, sobretudo a doentes de alto risco.

O ambiente de trabalho cumpre a legislação ou requisitos técnicos aplicáveis no que se refere em diferentes áreas, nomeadamente:

- Existência de um plano de emergência interno hospitalar
- Condições que proporcionam um ambiente adequado a utentes e profissionais (higienização do hospital, gerador de emergência, ar condicionado, elevadores).
- Controlo de radiação a que são submetidos os profissionais que trabalham com radiações ionizantes (através do uso de métodos de proteção barreira).

A- Manutenção Corretiva de infraestrutura e Dispositivos Médicos (Declaração de Competências)

É da responsabilidade de qualquer elemento do Serviço alertar a Enfermeira Chefe ou o Técnico responsável, para a necessidade de qualquer reparação nas respetivas instalações ou em dispositivos de monitorização e medição avariados.

A Enfermeira Chefe ou Técnico responsável, se considerar pertinente, requisita ao Serviço de Instalações e Equipamento (SIE) a reparação (manutenção corretiva, em plataforma própria).

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	15/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

B- Manutenção Preventiva da Infraestrutura

A manutenção preventiva da infraestrutura é assegurada pelo cumprimento do Plano Anual de Manutenção Preventiva de cada Serviço, elaborado pelo Serviço de Instalações e Equipamento, e disponibilizado à Enfermeira Chefe ou ao Técnico Responsável do serviço a que diz respeito, quando requisitado. Compete ainda a esse Serviço acompanhar a execução do Plano e assegurar-se de que são mantidos os parâmetros de funcionamento de origem.

Compete à Enfermeira Chefe informar o serviço de Manutenção de Instalações e Equipamento, sempre que constate que foi ultrapassado o período previsto de intervenção; compete-lhe, ainda, disponibilizar os equipamentos para as intervenções necessárias nas datas previstas ou acordar novas datas, logo que a sua utilização o permita.

C- Verificação/ Calibração de Dispositivos de Monitorização e Medição

A verificação / calibração dos dispositivos de monitorização e medição é assegurada pelo serviço de Instalações e Equipamentos (SIE), após solicitação ao Serviço Utilizador (SU), que elabora o Plano Anual de Verificação / Calibração, competindo-lhe ainda acompanhar a execução do Plano. O SU assegura que os dispositivos de monitorização e medição se encontram a funcionar dentro dos parâmetros exigíveis para cumprimento do fim a que se destinam e identificam o seu estado final de inspeção e ensaio.

Compete à Enfermeira Chefe, ou Técnico responsável, alertar o Serviço de Manutenção de Instalações e Equipamentos quando constate que foi ultrapassado o período previsto para a verificação e/ou calibração dos dispositivos de monitorização e medição, disponibilizando-os para as intervenções necessárias nas datas previstas, ou acordando novas datas, sempre que a sua utilização o não permita.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	16/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

6- Gestão de Risco

6.1- Metodologia

Os riscos, incidentes e eventos adversos podem ser definidos e classificados. Mas a sua ponderação em relação à severidade e à frequência são parcialmente subjetivos. A Comissão de Gestão de Risco da ULSLO definiu uma tipologia de risco, bem como uma escala com base em duas variáveis: probabilidade e impacto.

Tipos de risco, tal como considerados na Plataforma de Gestão de Risco:

- Processo administrativo/ Erro de identificação (admissões, marcações, transferidos...)
- Procedimento Clínico
- Queda
- Infecção associada aos cuidados de saúde
- Medicação
- Sangue ou produtos associados
- Dieta / Alimentação
- Equipamentos e dispositivos médicos
- Comportamento / Conduta
- Ambiente/ Infra-estrutura/ Roupa / Mobiliário
- Gestão organizacional / Recursos Humanos
- Outros (a especificar)

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	17/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

6.2- Escala de Riscos

Escala de Risco

Probabilidade		Reduzido (Doentes sem lesão ou sem aumento no nível de cuidados ou sem prolongamento estadia)	Tolerável (Doentes que requerem um maior nível de cuidados na revisão e avaliação; investigação adicional, encaminhar outro médico)	Grave (Doentes em redução permanente do funcionamento corporal)	Muito Grave (Doentes que sofram perda essencial e permanente de uma função)	Catastrófico (Doentes com morte não relacionada com a evolução normal da doença)
		1	2	3	4	5
Quase Certa (Sem-analmente)	5	5	10	15	20	25
Provável (Várias vezes ao ano)	4	4	8	12	16	20
Possível (A cada 1 a 2 anos)	3	3	6	9	12	15
Improvável (A cada 2 a 5 anos)	2	2	4	6	8	10
Rara (A cada 5 a 30 anos)	1	1	2	3	4	5
		Risco muito grave - medidas preventivas urgentes. Não o se deve prestar o serviço sem aplicação de medidas preventivas urgentes e sem acautelar solidamente o risco				
		Risco elevado - medidas preventivas obrigatórias. Devem-se controlar fortemente as variáveis de risco durante a prestação do serviço				
		Risco moderado - estudar economicamente se é possível introduzir medidas preventivas para reduzir o nível de risco. Se não for possível manter as variáveis controladas.				
		Risco baixo - vai ser acompanhado mas não requer medidas preventivas iniciais				

6.3- Matriz de Riscos

De seguida são apresentados exemplos de diferentes riscos que podem ocorrer durante os cuidados prestados aos doentes no Serviço de Medicina Intensiva. São definidos os graus de risco, a caracterização do risco e planos de melhoria que podem ser executados. São também definidas a modalidade de registo e a periodicidade de avaliação/auditoria aos respetivos riscos/eventos adversos.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	18/42

	Descrição do risco	Grau de Risco	Análise Causa efeito	Plano de Melhoria	Plano de Monitorização
1	Erros na identificação de doente	Baixo	▪ Não colocação da pulseira de identificação. ▪ Presença no serviço de doentes com o mesmo nome ou nome semelhante. ▪ Transferência de um doente sem atualização imediata do nome no processo físico ou eletrónico. ▪ Transferência de doente sem a recolha imediata dos seus exames e documentos. ▪ Apresentação clínica de doentes com o nome incompleto, sobretudo quando há nomes semelhantes.	▪ Seguir as regras de identificação inequívoca dos doentes. ▪ Verificar a pulseira de identificação e confirmar diretamente com o doente, quando possível. ▪ Atualizar imediatamente os registos e coletar toda a documentação dos doentes quando são transferidos. ▪ Na apresentação clínica dos doentes entre os profissionais de saúde, referir o nome completo e chamar a atenção da existência de doentes com nome igual ou semelhante.	Registo de eventos adversos e não conformidade na plataforma de <i>Patient Safety</i> Auditoria Anual

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	19/42

	Descrição do risco	Grau de Risco	Análise Causa efeito	Plano de Melhoria	Plano de Monitorização
2	Confusão no nome dos doentes	Baixo	- Presença no serviço de doentes com o mesmo nome ou nome semelhante. - Transferência de um doente sem atualização imediata do nome no processo físico ou eletrónico. - Transferência de doente sem a recolha imediata dos seus exames e documentos. - Apresentação clínica de doentes com o nome incompleto, sobretudo quando há nomes semelhantes.	- Seguir as regras de identificação inequívoca dos doentes. - Verificar a pulseira de identificação e confirmar diretamente com o doente, quando possível. - Atualizar imediatamente os registos e coletar toda a documentação dos doentes quando são transferidos. - Na apresentação clínica dos doentes entre os profissionais de saúde, referir o nome completo e chamar a atenção da existência de doentes com nome igual ou semelhante.	Registo de eventos adversos e não conformidade na plataforma de <i>Patient Safety</i> Auditoria Anual

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	20/42

	Descrição do risco	Grau de Risco	Análise Causa efeito	Plano de Melhoria	Plano de Monitorização
3	Erros na administração de medicamento	Moderado	▪ Erro na prescrição (medicamento, dose, doente, forma farmacêutica, via de administração). ▪ Erro na dispensa ou reposição de níveis de medicamentos. ▪ Ausência do medicamento na farmácia hospitalar. ▪ Erro na identificação do doente ou do medicamento. ▪ Armazenamento do medicamento incorreto ou de risco. ▪ Erro na administração da dose por erro de cálculo, distração ou interrupção durante a preparação.	▪ Uso exclusivo da prescrição online com ligação a todos os sistemas informáticos. ▪ Validação de todas as prescrições pelo farmacêutico. ▪ Dispensa de medicamentos por distribuição individualizada em unidose. ▪ Identificação e arrumação de medicamentos de risco particular. ▪ Implementação da dupla verificação na preparação e administração de medicamentos listados com códigos de alerta. ▪ Protocolo da Farmácia para a vigilância dos níveis séricos de medicamentos.	Análise de registos de erros de medicação associados à prescrição, validação e dispensa do medicamento na plataforma de gestão de risco.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	21/42

	Descrição do risco	Grau de Risco	Análise Causa efeito	Plano de Melhoria	Plano de Monitorização
4	Falta de material de dispositivos médicos	Baixo	- Níveis baixos de stocks ou falta de comunicação sobre os níveis baixos. - Número excessivo de doentes a concorrerem para o mesmo material ou dispositivo. - Falha na análise periódica de ocorrências e de stocks. - Avaria de equipamento único disponível. - Falta de manutenção do equipamento. - Falta de equipamento de reserva. - Falta de comunicação sobre falhas ou limitações existentes. - Em consequência, a equipa clínica ou operacional não pode assegurar os melhores cuidados assistenciais ao doente.	- Análise de stocks mantendo um número seguro, mas não excessivo de unidades. - Adequação do sistema de substituição de artigos perto do fim do prazo de validade. - Pedido atempado de material necessário raramente usado e não existente em armazém e certificar-se da sua existência. - Existência de equipamentos de substituição, em especial equipamento crítico (ex: monitor de transporte, desfibrilhador, etc) - Cumprimentos dos planos de manutenção. - Comunicação aos serviços de falhas importantes em equipamento básico de segurança.	Registo de eventos adversos e não conformidade na plataforma <i>The Patient Safety</i> da Antares. Auditoria Anual

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	22/42

	Descrição do risco	Grau de Risco	Análise Causa efeito	Plano de Melhoria	Plano de Monitorização
5	Perda de informação na passagem de doentes	Moderado	- Falha na comunicação de comorbilidades, riscos particulares ou complicações do doente ou de procedimentos. - Falha por omissão involuntária ou voluntária do doente, por situação de urgência ou por não se indagar acompanhantes ou outros profissionais de saúde. - Falha no envio de relatórios completos ou de exames complementares, - Falha pode ocorrer na admissão do doente, na passagem de turno dos profissionais ou na alta.	- Relatórios de alta e transferência, os mais possíveis completos e claros. - Comunicação pessoal direta chamando a atenção para os pontos críticos. - Registo da comunicação, quem, onde e quando, e eventualmente, a menção de um ou mais pontos críticos comunicados. - Disponibilidade de responder a dúvidas - Disponibilidade de acesso ao processo digital e exames. - Implementação de auditoria às notas de transferência.	Registo de não conformidades na plataforma do Serviço. Auditoria às notas de transferência.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	23/42

	Descrição do risco	Grau de Risco	Análise Causa efeito	Plano de Melhoria	Plano de Monitorização
6	Miopatia nos Cuidados Intensivos	Moderado	- Carateriza-se por fraqueza muscular generalizada que se desenvolve em doente crítico e que não pode ser atribuído a outras causas. - Diagnostica-se por critérios clínicos (ex: Medical Research Council (MRC) sum score < 48 e poderá ter contribuído de estudo eletrofisiológico. - É especialmente frequente nos doentes em sépsis com disfunção orgânica e ventilação prolongada (> 48h de VM < 7 dias de internamento em UCI) - Associa-se a aumento da mortalidade, tempos de ventilação invasiva e sequelas graves a longo prazo.	- Aplicação do protocolo de mobilização processe. - Uso de doses de sedação mínimas necessárias. - Plano de fisioterapia - Aquisição de cicloergómetro (passivo e ativo) - Utilização de estimulação elétrica neuromuscular. - Avaliação da força muscular por MRCsum e da sarcopenia por ecografia no doente sob SVMi > 7 dias. - Disponibilidade de EMG (exclusão de neuropatia).	Avaliação e registo pelo fisioterapeuta do Serviço no doente de risco (VMI > 7 dias)

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	24/42

	Descrição do risco	Grau de Risco	Análise Causa efeito	Plano de Melhoria	Plano de Monitorização
7	Queda	Moderado	- Doente agitado. confuso. delirante ou medicado com psicotrópicos. - Doente com défice motor, neurológico ou demência. - Doente isolado, com dificuldade ou incapacidade em comunicar. - Doente que tenta levante e sem ordem médica - Ratio insuficiente de profissionais, cansaço ou outras atividades em curso. - Associadas a aumento do tempo de internamento, dos custos hospitalares, a diminuição da mobilidade e aumento grau de dependência.	- Sensibilização aos doentes / familiares - Ações de formação aos Profissionais do SMI - Adequação das instalações e equipamentos. Vigilância adequada. - Proteções nas camas dos doentes de risco Implementação de auditoria da avaliação do risco de queda. - Implementação do protocolo de controlo do delírio. - Em caso de queda comunicação imediata ao médico assistente de serviço que procederá à avaliação clínica para despistar eventuais consequências da queda.	Registo de eventos adversos e não conformidade na plataforma de <i>Patient Safety</i> Auditoria Anual

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	25/42

	Descrição do risco	Grau de Risco	Análise Causa efeito	Plano de Melhoria	Plano de Monitorização
8	Úlceras de Pressão	Moderado	- Doentes acamados e não mobilizados, sobretudo se sedados, inconscientes ou paralisados. - Doentes clinicamente instáveis ou com comorbilidades importantes. - Doentes com deformidades, frágeis ou desnutridos. - Camas, colchões e roupas inapropriadas ou molhadas. - Zonas de pressão ou queimaduras prévias.	- Avaliação do risco para úlcera de pressão por rotina (escala de Braden). Posicionamento correto. - Uso de colchões anti-escara. - Mobilização precoce e frequente sempre que possível. - Implementação do protocolo de levante precoce.	Registo de eventos adversos e não conformidade na plataforma <i>The Patient Safety</i> da Antares. Registo anual da taxa de incidência

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	26/42

	Descrição do risco	Grau de Risco	Análise Causa efeito	Plano de Melhoria	Plano de Monitorização
9	Tromboembolismo	Elevado	- Doentes acamados e não mobilizados sobretudo se sedados, inconscientes ou paralisados. - Cirurgia com duração superior a 2h. - Ausência de medidas profiláticas (mecânicas e/ou medicamentosas)	- Implementação do Protocolo de mobilização precoce. - Melas elásticas ou de compressão mecânica. - Profilaxia medicamentosa.	Auditoria dos processos clínicos do doente.
10	Falha na higienização das Mãos	Elevado	- A higiene das mãos é qualquer medida adotada para limpeza das mãos (fricção com preparado de base alcoólica ou lavagem com água e sabão) com o objetivo de reduzir ou inibir o crescimento de microrganismos nas mãos. - A OMS define 5 momentos oportunos para a lavagem das mãos. - A lavagem das mãos é a medida principal para reduzir as infeções nosocomiais. - Estas infeções têm elevados custos e morbimortalidade. - O uso de soluções alcoólicas diminui a incidência de infeção nosocomial em 40%.	- Disponibilidade de soluções alcoólicas em cada espaço do doente. - Disponibilidade de lavatório com água e sabão no <i>open-space</i> das UCIs do SMI. - Aplicação e monitorização da norma da DGS sobre lavagem das mãos e posterior divulgação dos resultados. - Formação/Divulgação a todos os profissionais do modo como deve ser realizada a higienização das mãos. - É recomendação do PNSD 2021-2026 uma taxa $\geq 90\%$ do cumprimento do 1º Momento da higienização das Mãos.	Auditoria anual (de acordo com norma da DGS).

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	27/42

	Descrição do risco	Grau de Risco	Análise Causa efeito	Plano de Melhoria	Plano de Monitorização
11	Infeção Nosocomial	Elevado	- A transmissão de infeção é muito frequente pelo contacto com os profissionais (ex: mãos) e material de uso clínico. - A quebra das medidas de assepsia e na manipulação de acessos e feridas são causa de infeção grave, tal como a falta de cumprimento dos protocolos de profilaxia antimicrobiana, a cirurgia prolongada, má técnica cirúrgica ou cirurgia contaminada entre outros. - A permanência de vias de acesso central, a entubação oro-traqueal, a imobilidade e a debilidade, entre outros, são fatores de risco para a infeção. - Em UCI é especialmente relevante a bacteriemia associada ao cateter venoso central, a infeção urinária associada a sonda vesical e a pneumonia associa- da ao ventilador.	- A infeção nosocomial é uma das complicações mais frequentes e potencialmente perigosas do internamento; é expectável e faz parte do programa de vigilância epidemiológica realizada pelo GCL-PPCIRA e HELICS. - Programas de formação, monitorização das regras de prevenção e controlo de Infeção (ex: higienização das mãos) - O GCL-PPCIRA publicou e está acessível a todos os profissionais, as recomendações de Prevenção e Controlo de Infeção. - É recomendação do PNSD 2021-2026, uma redução de 30% em: - Infeções associadas ao cateter por 1.000 dias de CVC. - Infeções urinárias por 1000 dias de Sonda vesical. - Pneumonia associada à intubação por 1000 dias de VM.	Avaliação anual e divulgação das taxas de incidência. Auditorias anuais a medidas de prevenção de infeções

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	28/42

	Descrição do risco	Grau de Risco	Análise Causa efeito	Plano de Melhoria	Plano de Monitorização
12	Infeção por microrganismos multiresistentes	Elevado	- O desenvolvimento de resistências bacterianas é um problema crescente. Ao nível das UCI é especialmente importante pela dificuldade no adequado controle da infeção (doente crítico, múltiplas manobras invasivas, falta de assepsia. Admissão de portadores e a pressão antibiótica. - O aparecimento de microrganismos multiresistentes, e mais concretamente de <i>Staphylococcus aureus</i> metilina-resistente (SAMR/MRSA), <i>Pseudomonas aeruginosa</i> multiresistente (PAMR; a >> 3 antibióticos), <i>Klebsiella pneumoniae</i> de espectro extendido aos beta-lactâmicos (ESBL) estão associados a maior tempo de internamento. custos e mortalidade. - A aplicação de uma política antibiótica adequada e de um sistema de controlo de infeção pode ajudar a reduzir a magnitude do problema.	- A infeção por organismos multiresistentes é uma das complicações mais perigosas no internamento. Faz parte da vigilância epidemiológica e de controlo de infeções realizada pelo GCL-PPCIRA e HELICS. - Programas de formação, monitorização das regras de prevenção e controlo de Infeção (ex: higiene de mãos, precauções básicas, limpeza das instalações. cumprimento do protocolo de prevenção da PAI, etc). - O GCL-PPCIRA publicou e está acessível a todos os profissionais, as Recomendações de Prevenção e Controlo de Infeção. - Aplicação do protocolo de Rastreio e Descolonização de MRSA, preconizado pelo GCL-PPCIRA.	Análises da taxa de incidências do relatório anual da GCL-PPCIRA.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	29/42

	Descrição do risco	Grau de Risco	Análise Causa efeito	Plano de Melhoria	Plano de Monitorização
13	Deficiente controlo glicémico	Moderado	- A hiperglicemia no doente crítico está relacionada com aumento da morbimortalidade e complicações infecciosas. - As Hipoglicemias < 70 mg/dl estão associadas a maior mortalidade. - O controlo restrito (70-110mg/dl) com insulina em perfusão mostrou resultados contraditórios sobre a mortalidade, com alta incidência de hipoglicemia grave. - Recomenda-se manter níveis abaixo dos 180 mg/dl com recurso a insulino terapia - O protocolo de perfusão continua de insulina devem estar desenhados de forma a evitar a variabilidade nos valores de glicemia e hipoglicemias graves (<70mg/dl). - O uso standardizado de protocolos de perfusão de insulina difundidos e conhecidos por todos os profissionais melhora a eficácia e segurança do controlo glicémico no doente crítico.	- Divulgação a médicos e enfermeiros do protocolo de controlo glicémico do doente crítico. - Implementar precocemente o uso de perfusão de insulina nos doentes com 2 determinações consecutivas > 180mg/dl. - Medir a percentagem de hipoglicemias graves para estabelecer as medidas adequadas de correção e minimização de episódios de hipoglicemia. - Recomendação internacional: - Cumprimento >80% do controlo glicémico (número de doentes com glicemia > 180mg/dl em tratamento com insulina/número de doentes com glicemias >180mg/dl). - Menos de 0.5% de episódios de hipoglicemias grave (<70mg/dl) / número total de determinações de glicemia.	A implementar na auditoria anual sobre o controlo glicémico.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	30/42

	Descrição do risco	Grau de Risco	Análise Causa efeito	Plano de Melhoria	Plano de Monitorização
14	Falha na identificação do doente em risco de desnutrição	Moderado	- O risco nutricional é um processo de identificação do doente com problemas nutricionais ou com risco de os vir a desenvolver. - Não existe consenso sobre o método de avaliação mais apropriado no doente crítico, embora se considere por si de alto risco. - Nem sempre se dispõe de anamnese nutricional, parâmetros antropométricos fiáveis e o peso na admissão pode estar sobrevalorizado por fluidoterapia agressiva prévia. - Permite selecionar os doentes que podem beneficiar de uma intervenção nutricional e evitar os efeitos secundários da má nutrição.	- Usar método de valorização global subjetiva ou em alternativa: o cálculo do IMC, anamnese nutricional e/ou score NUTRIC. - Identificar por rotina na admissão o doente em risco nutricional, com: - IMC <18.5Kg/m². - Perda de peso involuntária > 5% em 3 meses em >10% em 6 meses. - Disfunção da deglutição ou da absorção com duração superior a 7dias.	A implementar auditoria anual sobre a identificação de parâmetros nutricionais na admissão.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	31/42

	Descrição do risco	Grau de Risco	Análise Causa efeito	Plano de Melhoria	Plano de Monitorização
15	Úlcera de stress	Moderado	- O doente crítico frequentemente desenvolve lesões gastrointestinais devido a alteração da perfusão da mucosa gástrica, à redução dos fatores protetores da mucosa e ao aumento do ácido gástrico. - A hemorragia gastrointestinal aumenta o risco de mortalidade e prolonga o tempo de internamento. - A profilaxia com fármacos não diminui a mortalidade e aumenta o risco de pneumonia nosocomial e de diarreia por <i>Clostridium Difficile</i>, sem eficácia superior à nutrição entérica (NE). - Podem ser usados os seguintes fármacos para profilaxia da úlcera de stress: inibidores da bomba de prótons, ranitidina ou sucralfato	- Identificar corretamente os doentes.com fatores de risco para úlcera de stress: - Ventilação mecânica invasiva (VMI) mais de 48 horas; - Coagulopatia (INR >1.5 ou Plaquetas <50/nl ou aPTT >2x normal). - Outras situações: - Hemorragia digestiva alta <12 meses; - Falência multiorgânica; - Choque séptico ou cardiogénico; - Queimados; - Traumatismo crânio-encefálico; - Lesão renal aguda; - Doença péptica; - Transplantado renal ou hepático; - Corticoterapia em alta dose	Auditoria anual dos processos clínicos do doente.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	32/42

	Descrição do risco	Grau de Risco	Análise Causa efeito	Plano de Melhoria	Plano de Monitorização
16	Auto-extubação	Moderado	- A auto-extubação pode ocorrer em doente desorientado/em delirium e/ou durante desmame de sedação, sem a vigilância apropriada para este tipo de doentes (frequente) - O doente pode desenvolver dessaturação grave, por compromisso da via aérea e obrigar a re-intubação emergente em circunstâncias por vezes menos controladas. - Está associada a necessidade de re-intubações com a um risco aumentado de pneumonia nosocomial, maior tempo de internamento e taxa de mortalidade.	- Avaliação médica e de enfermagem do risco de delirium de cada doente, que permita prever o potencial de extubação. - Adequação das medidas de vigilância necessárias a um doente com maior probabilidade de extubação accidental, principalmente no período noturno. - Maior vigilância do doente durante período de desmame/levante de sedação. - Uso de medidas de contenção física em doentes com alto risco de extubação accidental. - Implementação do protocolo de analgesia, sedação e delirium e do protocolo de desmame ventilatório, de forma a minimizar episódios de auto-extubação accidental.	Registo de auto-extubações na plataforma da PATIENTCARE-ICU.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	33/42

	Descrição do risco	Grau de Risco	Análise Causa efeito	Plano de Melhoria	Plano de Monitorização
17	Sedação excessiva ou insuficiente	Moderado	- A sedação pode ser necessária para garantir o conforto e a segurança do doente sob ventilação invasiva. - O uso de sedação está associado a efeitos adversos, derivados do uso excessivo ou insuficiente e pode prolongar o tempo de ventilação, o tempo de internamento, com consequente aumento do risco de miopatia. - O uso de escalas de sedação demonstrou-se útil no manuseamento destes doentes.	- Implementação do protocolo de analgesia, sedação e delirium. - É recomendação internacional o uso de escalas de sedação em > 95%, sob sedação internados em UCI.	Auditoria anual ao Processo Clínico do doente.
18	Analgesia Insuficiente	Moderado	- Os doentes das UCI são submetidos a múltiplos estímulos causadores de dor. - O controlo inadequado da dor ocasiona stress e aumenta a morbilidade. - A ausência de dor deve ser um objetivo de qualidade nas UCI. - A monitorização da dor deve incluir a medição da mesma através de escalas validadas, até alcançar e manter o nível de analgesia adequada	- Implementação do protocolo de analgesia, sedação e delírio. - É recomendação internacional o uso de escalas de dor em todos os doentes internados em ambiente de UCI.	Auditoria anual ao Processo Clínico do doente.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	34/42

	Descrição do risco	Grau de Risco	Análise Causa efeito	Plano de Melhoria	Plano de Monitorização
19	Delirium	Moderado	- O delirium está associado a uma elevada morbimortalidade e a aumento dos custos hospitalares. - Até 80% dos doentes graves admitidos em UCI apresentam delirium. - Recomenda-se o uso sistemático de escalas que nos permitam identificar precocemente o doente em Delirium, para poder ser tratado. A intervenção precoce tem uma maior probabilidade de prevenir a cronicidade. - Tanto a "<i>Confusion Assesment Method for the ICU</i>" (CAM-ICU) como a "<i>Intensive Care Delirium Screening Checklist</i>" (ICDSC) demonstraram a sua utilidade no diagnóstico de Delirium.	- Implementação do protocolo de Analgesia, Sedação e Delirium. - É recomendação internacional o uso de escalas de Delirium em >90% dos doentes internados em UCI.	Em implementação na auditoria ao processo clínico do doente.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	35/42

	Descrição do risco	Grau de Risco	Análise Causa efeito	Plano de Melhoria	Plano de Monitorização
20	Evento adverso no transporte intra-hospitalar	Moderado	- O transporte intra-hospitalar do doente crítico e sua mobilização para realizar intervenções diagnósticas e/ou terapêuticas, aumenta o risco de eventos adversos por descontinuidade nos cuidados. - O transporte deve realizar-se com sistemas de suporte vital e monitorização. Conforme critérios de qualidade e segurança clínica, realizar-se com o equipamento adequado e com pessoal treinado para a resolução imediata de imprevistos que comprometam a vida do doente. - É imprescindível o registo dos eventos adversos mais graves que possam ocorrer num transporte intra-hospitalar.	- Aumentar o número de registo de eventos adversos: morte, paragem cardio-respiratória recuperada, extubação acidental, retirada acidental de cateteres, drenos ou sondas, interrupção da administração de oxigénio ou quedas - É recomendação internacional que estes eventos adversos ocorram em <10% dos transportes intra-hospitalares.	Registo de eventos adversos e não conformidades na plataforma <i>The Patient Safety</i> da Antares

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	36/42

	Descrição do risco	Grau de Risco	Análise Causa efeito	Plano de Melhoria	Plano de Monitorização
21	Carro de Emergência inoperacional	Elevado	- A correta manutenção dos carros de emergência assegura a disponibilidade do material no caso de o seu uso ser necessário. - É um nível de controlo preventivo face à potencial resposta a uma emergência.	- Avaliar o cumprimento diário da lista de conferência do carro, que inclui: - Monitor desfibrilhador conectado à rede elétrica. 1. Ressuscitador manual acessível. 2. Máscara transparente insuflada conectada ao ressuscitador. 3. Tubo de oxigénio conectado à base de ressuscitador. 4. Estetoscópio junto do ressuscitador. 5. Cabo e lâmina de laringoscópio funcionantes. 6. Bala de oxigénio com reserva de pressão superior a 75 bar. 7. Teste do desfibrilhador. 8. Selo integro	Registo e análise das inconformidades encontradas. Registo de eventos adversos e não conformidades na plataforma <i>The Patient Safety</i> da Antares.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	37/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

6.4- Riscos por Áreas Assistenciais

		Áreas Assistenciais			
		UCI UCINTER	Consulta de Follow-Up	CDC	EEMI
Risco Clínico e não clínico					
1	Erros na Identificação de doentes	X	X	X	X
2	Confusão de nome de doentes	X	X	X	X
3	Erro na administração de medicamento	X		X	X
4	Falta de material de dispositivos médicos	X		X	X
5	Perda de informação na passagem de doentes	X		X	X
6	Miopatia dos Cuidados Intensivos	X		X	X
7	Queda	X	X	X	X
8	Úlceras de pressão	X			
9	Tromboembolismo Venoso	X			
10	Infeção Nosocomial	X			
11	Infeção por organismos Multiresistentes	X			
12	Falha na Higienização das Mãos	X	X	X	X
13	Deficiente controlo glicémico	X			
14	Falha da identificação do doente em risco de desnutrição	X			
15	Úlcera de Stress	X			
16	Auto-extubação	X		X	X
17	Sedação excessiva do doente	X		X	X
18	Analgesia Insuficiente	X		X	X
19	Delirium	X		X	X
20	Evento adversos no transporte intra-hospitalar	X		X	X
21	Carro de Emergência inoperacional	X	X	X	X

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	38/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

6.5- Plano de Auditorias do SMI

A auditoria clínica é um dos pilares da governança clínica, essencial para a segurança dos cuidados de saúde. É uma ferramenta fundamental de melhoria contínua ao nível das práticas clínicas e dos resultados, possibilitando a verificação da aplicação de estratégias e procedimentos que visem o aumento da segurança do doente.

Com o objetivo de avaliar a melhoria da qualidade da assistência prestada aos doentes internados no Serviço de Medicina Intensiva, é apresentado de seguida os Indicadores de Qualidade e Segurança, que são objeto de auditoria e cuja periodicidade de avaliação também se encontra definida.

Objeto da Auditoria	Âmbito	Periodicidade	Método
Indicadores de Segurança			
“Feixe de Intervenções” para a Prevenção da Pneumonia associada à intubação NC DGS 021/2015 de 16/12/2015, atualizada a 17/11/2022	Por observação e seguindo uma checklist	Anual (relatório em janeiro)	Aleatório Registo de 5 observações por profissional
“Feixe de Intervenções” de Prevenção de Infecção Relacionada com Catéter Venoso Central NC DGS 022/2015 de 16/12/2015, atualizada a 29/08/2022	Por observação e seguindo uma checklist	Anual (relatório em janeiro)	Aleatório Registo de 40 observações
Higiene das Mãos nas Unidades de Saúde NC DGS 007/2019 de 16/10/2019	Por observação e seguindo uma checklist	Anual (relatório em janeiro)	10-14 oportunidades por profissional em cada um dos 5 momentos
Precauções básicas do Controlo da Infecção NC DGS 029/2012, atualizada a 31/10/2013	Por observação e seguindo uma checklist	Anual (relatório em janeiro)	Aleatório Registo de 40 observações
Identificação Inequivoca do Doente PM CQS ULSLO 0101 de 26/12/2022	Por observação e seguindo uma checklist	Anual (relatório em janeiro)	Aleatório Registo mínimo de 40 observações
Registo de Eventos Adversos	Notificação na plataforma The Patient Safety da Antares	Anual (relatório em fevereiro)	Avaliação de todos os eventos notificados anualmente

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	39/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

Objeto da Auditoria	Âmbito	Periodicidade	Método
Indicadores de Qualidade			
PA do Choque Séptico	Consulta do Processo Clínico e avaliação de checklist	Semestral (relatório em fevereiro e agosto)	Aleatório Consulta de 20 % dos processos com o diagnóstico de “Sépsis grave com choque séptico”
PA da Hemorragia Subaracnoideia	Consulta do Processo Clínico e avaliação de checklist	Semestral (relatório em fevereiro e agosto)	Consulta de todos os processos com o diagnóstico de “HSA não traumática”
PA da Transfusão Maciça	Consulta do Processo Clínico e avaliação de checklist	Semestral (relatório em fevereiro e agosto)	Consulta de todos os processos com o diagnóstico de “Choque Hemorrágico”
PA do Processo Clínico do Doente	Consulta do Processo Clínico e avaliação de checklist	Semestral (relatório em fevereiro e agosto)	Aleatório Consulta de 20 % dos processos clínicos

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	40/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

7- Abreviaturas e Glossário

ARSLVT- Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

CDC- Circuito do Doente Crítico

CVC- Cateter Venoso Central

EEMI- Equipa de Emergência Médica Intrahospitalar

HEM- Hospital de Egas Moniz

HSA- Hemorragia Subaracnoideia

HSC- Hospital de Santa Cruz

HSFX- Hospital de S. Francisco Xavier

MI- Medicina Intensiva

NE- Nutrição entérica

PA- Processo Assistencial

PAI- Pneumonia Associada à Intubação

PNSD- Plano Nacional de Segurança do doente

SMI- Serviço de Medicina Intensiva

SIE- Serviço de Instalações e Equipamentos

VM- Ventilação Mecânica

UCI- Unidade de Cuidados Intensivos

UCINTER- Unidade de Cuidados Intermédios

ULSLO- Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental

US- Úlcera de Stress

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	41/42

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.MAN.001.01
Governança clínica	
Manual	

8- Anexos

Anexo 1 - “Recursos Humanos do Serviço de Medicina Intensiva da ULSLO”

Anexo 2- “Descrição das Funções dos Profissionais – Serviço de Medicina Intensiva da ULSLO”

Anexo 3- Carteira de Serviço do Serviço de Medicina intensiva

Anexo 4- Regulamento interno da Equipa de Emergência Médica Intra-hospitalar

Anexo 5 – Auditorias Internas aos Processos Assistenciais

Anexo 6 – Auditorias Internas ao Processo Único do Doente

Anexo 7- Plano de Formação Médico do SMI ULSLO (2023, 2024)

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	11/2024	11/2027	42/42



Recursos Humanos do Serviço de Medicina Intensiva da ULSLO

1. Equipa médica

Diretor de Serviço Pais Martins	Assistentes Hospitalares Patrícia Moniz Francisco Coelho João Torres Vasco Costa Ricardo Sousa Rita Ivo Ana Rita Barradas Diogo Santos Francisco Adragão Maria João Correia João Frutuoso Christopher Strong João Pedro Cidade Hugo Vilela Ivo Castro Rita Santos Hugo Moreira Pedro Fidalgo
Assistentes Hospitalares Graduados Pedro Póvoa Maria Eduarda Carmo Isabel Simões Joana Osório Cláudia Martins Bernardino Valério Vítor Mendes David Nora Ana Gabriela Almeida Tomás Lamas Marta Rebelo Pedro Freire Lia Lêdo Pedro Santos João Delgado Catarina Conceição Inês Antunes Ana Oliveira Carolina Paulino	Internos de Formação Específica Marta Maio Herculano Gonçalo Guerreiro Filipa Feliciano Maria Teresa Miranda Maria Rosário Cardoso Ricardo Carnevale David Sousa João Fustiga Michelle Tomazini Inês Medeiros Inês Gomes Eliane Silva Duarte Marques

Edição	Elaborado por	Data	Página
Versão 1.0	Dr. Pais Martins- Diretor do SMI da ULSLO Dra. Marta Rebelo – Assistente Graduada de MI Enfª Isabel Santos- Enfª Gestora da UCI-1 Enfª Clementina Moreira- Enfª Coordenadora UCI-2 Enfª Fernanda Leal- Enfª com funções de Gestão da UCI-3 Enf. José Sempere- Enf. Gestor da UCI-4	Maio 2024	Página 1 de 7



2. Equipa de Enfermagem

[UCI-1]

Enfermeira Gestora: Isabel Santos Enfermeiro Coordenador: Luís Teixeira- EEER Enfermeiros Especialistas: Filipa Cristovão- EEMC Maria Auxilia Pires- EEMC Mariana Casimiro- EEMC Paula Esteves Silva- EEMC Pedro Batista- EEMC Pedro Rodrigues- EEMC	Enfermeiros Cuidados Gerais: Adriana Lopes Afonso Oliveira Ana Beatriz Bento Ana Coutinho Ana Filipa Ferreira Cândida Silva Carla Dias Carla Isabel Saraiva Cátia Loureiro Dulce De Jesus Luís Eveline Tavares Fábio Vera Cruz Gabriela Tavares Graziela Tavares Jéssica Rebelo Jéssica Santos João Amorim Melissa Figueira Madalena B. Pereira Mafalda Magalhães Marco Almeida Margarida Almeida Mariana Batista Mariana Lavos Mariana Marques Marta Sebastião Neuza barata Patrícia Bilhó Paula Esteves Silva Paula Rodrigues Vera Ribeiro
---	--

Edição	Elaborado por	Data	Página
Versão 1.0	Dr. Pais Martins- Diretor do SMI da ULSLO Dra. Marta Rebelo – Assistente Graduada de MI Enfª Isabel Santos- Enfª Gestora da UCI-1 Enfª Clementina Moreira- Enfª Coordenadora UCI-2 Enfª Fernanda Leal- Enfª com funções de Gestão da UCI-3 Enf. José Sempere- Enf. Gestor da UCI-4	Maio 2024	Página 1 de 7



[UCI-2]

Enfermeiro Especialista em funções de Gestão

Paula Lourenço

Enfermeiro Coordenador:

Clementina Moreira

Enfermeiros Especialistas:

Marisa Rocha - EEER

Susana Sobral - EEMC

Andreia Ramos - EEER

Maria Manuela Fernandes - EEMC

Sara Conde - EEER

Enfermeiros de Cuidados Gerais:

Ana Paula Avelar

Daniela Martins

Carina Silva

Liliana Corte Real

Catarina Fernandes

Anabela Sousa

Regina Guilherme

Ana Luísa Esperança

Luís Morais

Sérgio Pereira

Regina Canelas

Ana Gabriela Sousa

Ricardo Pereira

Ana Cristina Almeida

José Augusto Figueira

Ana Rita Mendes

Florbela Machado

Sandra Sebastião

Philippe Fernandes

José Gonçalves

Edição	Elaborado por	Data	Página
Versão 1.0	Dr. Pais Martins- Diretor do SMI da ULSLO Dra. Marta Rebelo – Assistente Graduada de MI Enfª Isabel Santos- Enfª Gestora da UCI-1 Enfª Clementina Moreira- Enfª Coordenadora UCI-2 Enfª Fernanda Leal- Enfª com funções de Gestão da UCI-3 Enf. José Sempere- Enf. Gestor da UCI-4	Maio 2024	Página 1 de 7



[UCI-3]

Enfermeiro Especialista em funções de Gestão

Fernanda Leal- EEER

Enfermeiro Coordenador:

Helena Bravo- EEER

Enfermeiros Especialistas:

António Ribeiro- EEER

João Paulo Cheira- EEMC

Filipa Esteves- EEMC

Sabrina Paula- EEMC

Enfermeiros de Cuidados Gerais

Alfredo Vicente

Ana Cristina Pereira

Isabel Maria Pereira

Marco Mesquita

Carina Gonçalves

Sandra Pinto

Ludomila Alberto

Albertina Alves

Patrícia Pereira

Ana Rita Henriques

Miriam Fernandes

Maria Adelaide Grazina

Ana Patrícia Felgueiras

Sabrina Toledo

Susana Torrão

Sofia Natário

Carlos Simões

Mariana Nogueira

Carina Cabaco

Sandra Ganchinho

Zita Figueira

Sandra Afonso

Fernando Batista

Joana Balinho

Francisca Horta Costa

Edição	Elaborado por	Data	Página
Versão 1.0	Dr. Pais Martins- Diretor do SMI da ULSLO Dra. Marta Rebelo – Assistente Graduada de MI Enfª Isabel Santos- Enfª Gestora da UCI-1 Enfª Clementina Moreira- Enfª Coordenadora UCI-2 Enfª Fernanda Leal- Enfª com funções de Gestão da UCI-3 Enf. José Sempere- Enf. Gestor da UCI-4	Maio 2024	Página 1 de 7



[UCI-4]

Enfermeiro Especialista em funções de Gestão

José do Rosário Sempere

Enfermeiro Coordenador:

Ana Cruz

Enfermeiros Especialistas:

Ana Filipa Ferreira

Cristina Inácio

Paulo Correia

Paulo Monteiro

Pedro Rosa

Rita Campeão

Tânia Pinto

Vanda Silva

Enfermeiros de Cuidados gerais:

Ana Rita Vieira

David Milho

Diana Freitas

Dina Correia

Dora Correia

Estibaliz Alday

Fábio Manaia

Fernando Faria

Horácio Cardoso

Joana Afonso

Joana Pereira

Joana Pimpão

Joana Salavessa

Joana Serra

Liliana Camarate

Liliana Sousa

Maria Carvalho

Marisa Veiga

Paula Alves

Pedro Henriques

Sílvia Lemos

Vítor Carocha

Edição	Elaborado por	Data	Página
Versão 1.0	Dr. Pais Martins- Diretor do SMI da ULSLO Dra. Marta Rebelo – Assistente Graduada de MI Enfª Isabel Santos- Enfª Gestora da UCI-1 Enfª Clementina Moreira- Enfª Coordenadora UCI-2 Enfª Fernanda Leal- Enfª com funções de Gestão da UCI-3 Enf. José Sempere- Enf. Gestor da UCI-4	Maio 2024	Página 1 de 7



3. Equipa de Técnicos Auxiliares de Saúde

[UCI-1]

Ana Herdade
Brasil Andrade
Cátia Marques
Cheila Moreno
Cristiane Macarini
Dalila Rufino
Edinalva Vieira
Joana Pinto
Maria Donzília Santos
Maria Teixeira
Núria Costa
Raquel Avelino

[UCI-3]

José Joaquim Freitas
Ana Pedreira
Aua Mane
Maria de Fátima Silva
Maria Emília Pereira
Patrícia Ferreira
Diogo Freitas
Mafalda Ferraz
Willian Rosa
Maria Beatriz Teixeira
Amália Viegas

[UCI-2]

Sandra fachadas
Ana Paula Pinho
Marizia Ramos
Maria de Lurdes Tavares
Elisângela Horta
Susana Silva
Maria Sameiro Gonçalves
Carla Lopes
Ana Paula Santos

[UCI-4]

Sandra Fernandes
Ângela Melo
Agostinha Brito
Susana Pecurto
Carla Pinto
Vanderiane Silva
Maria eulalia Fragoso
Maria Rita Santos
Anabela Ferreira
Mónica Silva
Arlete Vaz
Susana Coutinho

Edição	Elaborado por	Data	Página
Versão 1.0	Dr. Pais Martins- Diretor do SMI da ULSLO Dra. Marta Rebelo – Assistente Graduada de MI Enfª Isabel Santos- Enfª Gestora da UCI-1 Enfª Clementina Moreira- Enfª Coordenadora UCI-2 Enfª Fernanda Leal- Enfª com funções de Gestão da UCI-3 Enf. José Sempere- Enf. Gestor da UCI-4	Maio 2024	Página 1 de 7



4. Equipa de Assistentes Técnicos

Secretariado:

SMI	Carla Leitão
UCI-1	Olga Alves
UCI-2	Maria Clara Ferreira
UCI-3	Carla Leitão
UCI-4	Susana Nogueira

Edição	Elaborado por	Data	Página
Versão 1.0	Dr. Pais Martins- Diretor do SMI da ULSLO Dra. Marta Rebelo – Assistente Graduada de MI Enfª Isabel Santos- Enfª Gestora da UCI-1 Enfª Clementina Moreira- Enfª Coordenadora UCI-2 Enfª Fernanda Leal- Enfª com funções de Gestão da UCI-3 Enf. José Sempere- Enf. Gestor da UCI-4	Maio 2024	Página 1 de 7

Descrição das funções dos profissionais

Serviço de Medicina Intensiva da ULSLO

2023/2024



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
LISBOA OCIDENTAL

FUNÇÕES DOS DIFERENTES PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA

O Decreto-Lei n.º 102/2023, de 7 de novembro, procedeu à reestruturação das entidades públicas empresariais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), através da integração dos hospitais e centros hospitalares existentes com os Agrupamentos de Centros de Saúde, adotando para isso o modelo de organização e funcionamento em unidades locais de saúde (ULS), nos termos previstos no Estatuto do SNS.

As estruturas intermédias de gestão, com autonomia funcional e organizacional, contratualizam com o Conselho de Administração das ULS o seu contrato-programa anual. No Serviço de Medicina Intensiva da Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental (ULSLO) existe um Diretor de Serviço, Coordenador médico, um Enfermeiro Chefe e/ou um Enfermeiro Gestor, nomeados pelo Conselho de Administração a quem, o respetivo diretor deste Serviço, presta contas.

A arquitetura da organização deve privilegiar o interesse do doente e a eficiência clínica e rentabilizar os recursos humanos existentes. Deverá responder a necessidades locais e gerais identificadas nos planos de saúde e a funções determinadas pela inserção na respetiva rede hospitalar.

Deverá ainda acompanhar a dinamização na Saúde, tornando-se a formação dos profissionais de saúde cada vez mais exigente. A área dos Cuidados Intensivos tem apresentado um enorme desenvolvimento técnico e científico, exigindo uma atualização permanente. Foi criada em 1 janeiro de 2017 a especialidade de Medicina Intensiva (com a duração de cinco anos); com manutenção até 2022 da obtenção da especialidade em Medicina Intensiva pela via clássica.

Relativamente às funções dos profissionais do Serviço de Medicina Intensiva (SMI) serão apresentadas neste documento, de acordo com os respetivos Decretos-Leis (DL). Descrevem-se de seguida as funções dos diferentes postos de trabalho de médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares de saúde e assistentes técnicos no Serviço de Medicina Intensiva da ULSLO.

Edição	Elaboração	Revisão	Aprovação	Próxima edição
02/2024	Dra. Marta Rebelo- Assistente de MI* Dra. Gabriela Almeida- Assistente de MI*	Enfª Isabel Santos- Enfª Gestora da UCI-1 Enfª Clementina Moreira- Enfª Coordenadora da UCI-1 Enfª Fernanda Leal- Enfª em funções de Gestão da UCI-3 Enf. José Sempere- Enf. Gestor da UCI-4	Dr. Pais Martins- Diretor do SMI da ULSO Assinado por : António José Pereira Pais Martins Num. de Identificação: BI04475691 Data: 2024.11.13 15:23:24 Hora padrão de GMT	2027

* Assistente Graduado de Medicina Intensiva



▪ **Diretor de Serviço: Dr. Pais Martins**

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
DL nº176/2009 DL nº177/2009 DL nº 266D/2012	▪ Assegurar a gestão geral do Serviço, de acordo com o Contrato Programa, assinado anualmente com o Conselho de Administração do ULSLO. Elaborar plano de Ação e relatório de atividades do Serviço; ▪ Promover a articulação da equipa multidisciplinar que envolve não só os elementos do Serviço como outros profissionais de outros serviços, com o objetivo de proporcionar os melhores cuidados aos doentes; ▪ Validar o Programação da formação anual do SMI; ▪ Analisar mensalmente os desvios verificados face à atividade esperada e às verbas orçamentadas, corrigi-los ou, sendo necessário, propor medidas corretivas ao Diretor Clínico; ▪ Promover a aplicação dos programas de controlo de qualidade e de produtividade, privilegiando uma melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde; ▪ Garantir a organização e constante atualização dos processos clínicos, designadamente através da revisão das decisões de admissão e alta, mantendo um sistema de codificação correto e atempado das altas clínicas; ▪ Acompanhar a realização de ensaios clínicos ou outras atividades promocionais em que esteja envolvido o nome do estabelecimento ou o serviço do hospital sem colidir com o disposto no número anterior; ▪ Estabelecer a política de delegação de autoridade no Serviço; ▪ Promover a manutenção de um sistema de controlo interno eficaz destinado a assegurar a salvaguarda dos ativos, a integridade e fiabilidade do sistema de informação e a	Capacidade de Desenvolver trabalho de Equipa Capacidade de Liderança Gestão de Recursos Humanos Gestão de Recursos Técnicos e materiais Gestão de Processos Assistenciais: (1) promover o cumprimento do processo assistencial; (2) assegurar a existência de condições logísticas e funcionais para a sua aplicabilidade; (3) monitorizar a sua aplicação; (4) promover as alterações e ajustes considerados necessários ao seu regular funcionamento. Governança clínica	Assistente Hospitalar Graduado Sénior



observância das leis, dos regulamentos e das normas aplicáveis, assim como o acompanhamento dos objetivos globais definidos;

- Participar na atividade clínica do Serviço, em áreas de atuação direta com o doente, nas decisões sobre orientação diagnóstica e terapêutica inerente às reuniões de Serviço;
- Assegurar a gestão adequada dos recursos humanos, incluindo a avaliação interna do desempenho global dos profissionais, dentro dos parâmetros estabelecidos;
- Coordenar as reuniões científicas do Serviço, estimulando o desenvolvimento científico dos seus pares e providenciando resultados;
- Coordenar atividade assistencial de investigação científica e de formação médica ligadas à respetiva especialidade;
- Definir a política de formação de internos no Serviço;
- Coordenar o desenvolvimento curricular dos médicos internos e dos médicos assistentes;
- Coordenar a dinamização da investigação científica;
- Coordenar a dinamização de projetos de bioética;
- Coordenar a dinamização de projetos de informatização clínica;
- Coordenar os protocolos de diagnóstico, terapêuticos e de acompanhamento, bem como a gestão dos internamentos;
- Tomar conhecimento e determinar as medidas adequadas em resposta a reclamações apresentadas pelos utentes.



▪ **Médico Coordenador da Unidade de Cuidados Intensivos**

FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
- Acompanhamento e supervisão do desempenho da equipa multiprofissional da unidade, nomeadamente na execução da atividade assistencial médica; - Assegurar a adequação, qualidade e efetividade dos cuidados prestados - Promoção do trabalho em equipa multiprofissional efetivo e em ambiente saudável; - Exercer as competências que lhe tenham sido delegadas pelo diretor do serviço - Analisar periodicamente os desvios verificados na respetiva unidade, promover as necessárias medidas corretivas e propor ao diretor de serviço as alterações que se mostrem necessárias; - Planeamento e coordenação de reuniões administrativas e clínicas periódicas, promovendo a educação continuada e a atualização técnico-científica da equipa multiprofissional; - Promoção do ensino de profissionais médicos e não médicos; - Planeamento, implementação e monitorização de políticas de qualidade e segurança;	Domínio técnico e científico na área de Medicina Intensiva Capacidade de Desenvolver trabalho de equipa Capacidade de organização e coordenação Capacidade de liderança Gestão de Recursos Humanos Gestão de Recursos Técnicos e materiais Gestão de Processos Assistenciais: (1) promover o cumprimento do processo assistencial; (2) assegurar a existência de condições logísticas e funcionais para a sua aplicabilidade; (3) monitorizar a sua aplicação; (4) promover as alterações e ajustes considerados necessários ao seu regular funcionamento. Orientação para os objetivos do serviço. Capacidade de relação interpessoal. Domínio das aplicações informáticas utilizadas no serviço	Assistente Hospitalar

▪ **Assistente Hospitalar de Medicina Intensiva**



Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
DL n°176/2009 DL n°177/2009 DL n° 266D/2012	- Promover a articulação da equipa multidisciplinar que envolve não só os elementos do serviço como outros profissionais de outros serviços, com o objetivo de proporcionar os melhores cuidados aos doentes; - Garantir a organização e constante atualização dos processos clínicos, designadamente através da revisão das decisões de admissão e alta, mantendo um sistema de codificação correto e atempado das altas clínicas; - Coordenar programas de melhoria contínua da qualidade; - Participar na formação dos médicos internos; - Acompanhar a realização de ensaios clínicos ou outras atividades promocionais em que esteja envolvido o nome do estabelecimento ou o serviço do hospital sem colidir com o disposto no número anterior; - Participar na atividade clínica do Serviço, em áreas de atuação direta com o doente, nas decisões sobre orientação diagnóstica e terapêutica inerente às reuniões de Serviço; - Coordenar as reuniões científicas do Serviço, estimulando o desenvolvimento científico dos seus pares e providenciando feedback; - Participar na atividade assistencial de investigação científica e de formação médica; - Coordenar os protocolos de diagnóstico, terapêutica e de acompanhamento; - Exercer as funções de Assistente Hospitalar.	Domínio técnico e científico na área de Medicina Intensiva Capacidade de Desenvolver trabalho de equipa Capacidade de organização e coordenação Capacidade de liderança Gestão de Recursos Humanos Gestão de Recursos Técnicos e materiais Gestão de Processos Assistenciais: (1) promover o cumprimento do processo assistencial; (2) assegurar a existência de condições logísticas e funcionais para a sua aplicabilidade; (3) monitorizar a sua aplicação; (4) promover as alterações e ajustes considerados necessários ao seu regular funcionamento. Orientação para os objetivos do serviço. Capacidade de relação interpessoal. Domínio das aplicações informáticas utilizadas no serviço Governança clínica	Assistente Hospitalar



▪ **Assistente Hospitalar em formação para acesso a titulação por Via Clássica de Medicina Intensiva**

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
	▪ Coordenar as atividades médicas inerentes à observação e tratamento dos doentes internados no SMI, em todos os aspetos inerentes à sua condição. ▪ Participar na atualização dos processos clínicos, designadamente através da revisão das decisões de admissão e alta, mantendo um sistema de codificação correto e atempado das altas clínicas. ▪ Participar na formação dos médicos internos. ▪ Acompanhar a realização de ensaios clínicos ou outras atividades promocionais em que esteja envolvido o nome do estabelecimento ou o serviço do hospital sem colidir com o disposto no número anterior. ▪ Participar na atividade clínica do Serviço, em áreas de atuação direta com o doente, nas decisões sobre orientação diagnóstica e terapêutica inerente às reuniões de Serviço. ▪ Participar na atividade assistencial de investigação científica. ▪ Exercer as funções de Assistente Hospitalar.	Domínio técnico e científico na área de Medicina Intensiva Atuação em situações urgentes e emergências do foro da medicina intensiva Capacidade de Desenvolver trabalho de equipa Gestão de Recursos Técnicos e materiais Capacidade de coordenação e organização Orientação para os objetivos do serviço. Capacidade de relação interpessoal. Domínio das aplicações informáticas utilizadas no serviço.	Assistente Hospitalar Especialidade de base clínica



▪ Interno de formação específica em Medicina Intensiva

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
Diário da Rep. nº 79/2016, Série I, Portaria nº 103/2016	▪ Observar e fazer a avaliação clínica do doente. Elaborar um diário clínico, com menção de hipóteses de diagnósticas, pedido de exames complementares de diagnósticos, propostas terapêuticas e plano terapêutico; ▪ Planear a calendarização e distribuição de temáticas das reuniões científicas semanais; ▪ Elaborar notas de admissão dos doentes admitidos na UCI; ▪ Manter o processo clínico atualizado, com registo das discussões realizadas em equipa, resultados dos exames complementares de diagnóstico realizados e informação fornecida ao familiar de referência ou representante legal do doente; ▪ Executar procedimentos invasivos em UCI, nomeadamente: colocação de cateter venoso central, colocação de linha arterial, colocação de linha de monitorização arterial invasiva, toracocentese, colocação de dreno torácico, entubação oro-traqueal. Procedimentos realizados sob tutorização da equipa médica; ▪ Participar nas atividades diárias organizadas de acordo com o organograma do serviço e a equipa; ▪ Colaborar ativamente na observação e tratamento dos doentes internados no serviço, sempre que devidamente tutelados; ▪ Discutir a situação clínica do doente com médicos de outras especialidades, nomeadamente Cirurgia Geral, Gastroenterologia, Nefrologia, Pneumologia, Infeciologia e Cardiologia, sempre com o intuito de uma melhor abordagem clínica, diagnóstica e terapêutica do doente.	Domínio técnico e científico na área de Medicina Intensiva Atuação em situações urgentes e emergências do foro da medicina intensiva Capacidade de Desenvolver trabalho de equipa Atitude de estímulo à aprendizagem e melhoria contínua. Orientação para a formação do interno Orientação para os objetivos do serviço Capacidade de gestão de conflitos. Domínio nas aplicações informáticas utilizadas no serviço	Assistente Hospitalar Especialidade de base clínica



- Esclarecer os familiares acerca da situação clínica do doente, procurando responder de forma clara e utilizando linguagem adequada aos diferentes graus socioculturais dos familiares;
- Participar nas reuniões científicas e/ou clínicas do serviço.

• Internos com formação específica noutras especialidades

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
DL nº 13/2018 Diário da Rep. nº 54/2018, Portaria nº 79/2018	- Observar e fazer a avaliação clínica do doente. Elaborar um diário clínico, com menção de hipóteses de diagnósticas, pedido de exames complementares de diagnósticos, propostas terapêuticas e plano terapêutico; - Elaborar notas de admissão dos doentes admitidos na UCI; - Manter o processo clínico atualizado, com registo das discussões realizadas em equipa, resultados dos exames complementares de diagnósticos realizados e informação fornecida ao familiar de referência ou representante legal do doente; - Colaborar ativamente na observação e tratamento dos doentes internados no serviço, sempre que devidamente tutelados; - Executar procedimentos invasivos em UCI, nomeadamente: colocação de Cateter venoso central, colocação de linha arterial, colocação de linho de monitorização arterial invasiva, toracocentese, colocação de dreno torácico, entubação oro-traqueal. Procedimentos realizados sob tutorização da equipa médica; - Participar nas reuniões científicas e/ou clínicas do serviço; - Esclarecer os familiares acerca da situação clínica do doente, procurando responder de forma clara e utilizando linguagem adequada aos diferentes graus socioculturais dos familiares; - Discutir a situação clínica do doente com médicos de outras especialidades, nomeadamente Cirurgia Geral, Gastroenterologia, Nefrologia, Pneumologia, Infeciologia e Cardiologia, sempre com o intuito de uma melhor abordagem clínica, diagnóstica e terapêutica do doente.	Domínio técnico e científico na área de Medicina Intensiva Capacidade de Desenvolver trabalho de equipa Atitude de estímulo à aprendizagem e melhoria contínua. Orientação para os objetivos do serviço Capacidade de gestão de conflitos. Domínio nas aplicações informáticas utilizadas no serviço	Licenciatura em Medicina Internato de Formação Geral



▪ **Médico Responsável pela formação de internos/Formação científica**

Decreto- Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
Diário da Rep. nº 54/2018, Portaria nº 79/2018, Artigo 15º e 16º	- Organizar e calendarizar as atividades assistenciais na UCI da equipa de internos de medicina intensiva e internos de outras especialidades em frequência de estágios parcelares, de acordo com o plano formativo para as diferentes especialidades pela Ordem dos Médicos; - Programar as atividades diárias clínicas do interno e organizá-las de acordo com o organigrama do serviço; - Supervisionar a aplicação do plano formativo do Internato- Formação Específica quanto à sua calendarização e garantia de cumprimento de mínimos exigidos de atividade médica e científica; - Disponibilizar-se para tutelar a atividade do interno no serviço; - Coordenar e estimular a participação do interno em reuniões científicas e clínicas de interesse científico; - Participar ativamente na formação e orientação dos internos do serviço ou de outros internos em formação de outras especialidades; - Coordenar e participar na formação de internos em treino pós-graduado; - Aplicar os instrumentos disponíveis para efeitos de avaliação contínua do internato médico; - Reportar, em tempo útil e de forma fundamentada, ao respetivo diretor ou coordenador do internato médico, ocorrências que exijam a sua intervenção; - Proceder ao acompanhamento dos programas de formação médica com respeito pelas orientações definidas pelo CNIM; - Participar em atividades formativas que visem a sua preparação no domínio da formação médica.	Domínio técnico e científico na área de Medicina Intensiva. Atitude de estímulo à aprendizagem e melhoria contínua. Orientação para a formação do interno. Orientação para os objetivos do serviço. Capacidade de relação interpessoal e aptidão pedagógica Capacidade de comunicação em grupo Conhecimento das necessidades formativas dos profissionais Domínio das aplicações informáticas utilizadas no serviço	Assistente Hospitalar Especialidade de base clínica

▪ **Médico Elo de Ligação com PPCIRA**

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
Diário da Rep n.º 174/2022, Série II de 8 de setembro de 2022	- Dinamizar projetos e promover as atitudes que conduzam ao alcance das metas e objetivos conjuntamente definidos pelo Diretor de Serviço, Coordenadores das Unidades de Cuidados Intensivos e PPCIRA. - Ser os interlocutores mais diretos entre o Serviço de Medicina Intensiva e o PPCIRA - Coordenar e apoiar as atividades de prevenção e controlo de infeção, o uso adequado de antimicrobianos e a prevenção de resistências a antimicrobianos, nas unidades de saúde da sua região de saúde, no respeito pelas normas e orientações do PPCIRA e da DGS. - Elaborar um relatório anual, que inclua, mas não se esgote, nos indicadores relativos ao objetivo estratégico 5.3 do PNSD 2021-2026, que deve ser remetido ao diretor do PPCIRA, até 31 de março do ano seguinte ao qual se reporta - Promover e monitorizar a investigação de surtos e a realização de inquéritos epidemiológicos, colaborando na realização de auditorias; - Manter atualizado o registo na plataforma HELICS-UCI e comunicar periodicamente os resultados de vigilância de infeção nosocomial aos membros do Serviço.	Domínio técnico e científico na área de Medicina Intensiva. Atitude de estímulo à aprendizagem e melhoria contínua. Orientação para os objetivos do serviço. Capacidade de relação interpessoal. Domínio das aplicações informáticas utilizadas no serviço Capacidade de organização e coordenação Capacidade de comunicação em grupo Conhecimento das necessidades formativas dos profissionais Aptidão pedagógica	Assistente Hospitalar



▪ **Médico Elo de Ligação com a Comissão de Qualidade e Segurança do Doente (CQSD)**

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
Diário da Rep n.º 47/2013, Série II de 7 de março de 2013, Artigo nº 9 e nº 10	▪ Articulação entre a Comissão de Qualidade e Segurança do Doente (CQSD) e os serviços/departamento, facilitando a aplicação setorial do Plano de Atividades; ▪ Colaborar no desenvolvimento e implementação do Plano Anual de Atividades; ▪ Colaborar com a CQSD na implementação de projetos de qualidade de acordo com o plano estratégico da Instituição; ▪ Implementar instrumentos de auditoria, como metodologia de monitorização do plano de ação; ▪ Planear e realizar auditorias internas; ▪ Elaborar planos de ação corretiva.	Domínio técnico e científico na área de Medicina Atitude de estímulo à aprendizagem e melhoria contínua. Orientação para os objetivos do serviço. Capacidade de relação interpessoal. Domínio das aplicações informáticas utilizadas no serviço Capacidade de organização e coordenação Capacidade de comunicação em grupo Aptidão pedagógica	Assistente Hospitalar



▪ Médico responsável pela formação científica

Decreto- Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
	- Promover a atualização científica dos médicos do serviço; - Coordenar e participar na formação de internos em treino pós-graduado;^[1]_[SEP] - Promover a atualização técnico-científica e o conhecimento do estado da arte de temas fundamentais para a atividade clínica do serviço; - Facilitar o conhecimento de novas normas de orientação, novas técnicas e equipamentos; - Colaborar e promover reuniões de carácter científico e formativo do foro da medicina intensiva ou afim, internas ou externas ao ULSLO; - Coordenar e participar na formação de internos em treino pós-graduado;^[1]_[SEP] - Responsabilizar-se pela organização, atualização e divulgação de bibliografia com interesse para o serviço.	Domínio técnico e científico na área de Medicina Intensiva. Atitude de estímulo à aprendizagem e melhoria contínua. Orientação para a formação do interno. Orientação para os objetivos do serviço. Capacidade de relação interpessoal. Domínio das aplicações informáticas utilizadas no serviço Capacidade de organização e coordenação Capacidade de comunicação em grupo Conhecimento das necessidades formativas dos profissionais Aptidão pedagógica	Assistente Hospitalar Especialidade de base clínica



▪ Médico da Consulta de Follow-up SMI

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
Diário de Rep. nº 86/2017, série I, Portaria nº 153/2017, Anexo II, alínea 1.4	▪ Fazer a triagem na plataforma da <i>Patient Care</i>, dos utentes admitidos na UCI com SPICI positivo na admissão ou à alta da UCI e que apresentem mais de 3 dias de internamento na UCI; ▪ Realizar atos assistenciais adequados no âmbito da especialidade e registar os mesmo no processo clínico informático, nomeadamente: anamnese, exame objetivo, registo de antecedentes, alergias, pedidos de exames complementares, plano terapêutico e consentimento informado para a realização de exames complementares e do tratamento dos dados clínicos para fins estatísticos; ▪ Esclarecer o doente sobre questões/dúvidas pertinentes; ▪ Aplicar escalas de avaliação de risco de Stress Pós-traumático em UCI; ▪ Referenciar outras consultas externas da ULISO ou ao exterior sempre que adequado; ▪ Reconciliar a terapêutica; ▪ Elaborar Relatórios Clínicos; ▪ Articular a prestação e a continuidade dos cuidados de saúde com os médicos de família; ▪ Formar internos com formação específica em Medicina Intensiva;	Domínio técnico e científico na área de Medicina Intensiva. Orientação para os objetivos do serviço. Capacidade de relação interpessoal. Capacidade de comunicação Domínio das aplicações informáticas utilizadas no serviço	Assistente Hospitalar



▪ **Médico do EEMI (Equipa de Emergência Médica Intra-Hospitalar)**

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
DQ nº 15/DQS/DQCO de 22/06/2010 DL nº 198/2018, série II	▪ Exercer a responsabilidade de Líder de Equipa (Team Leader) em situações de ativação da EEMI; ▪ Observar, estabilizar e iniciar medidas diagnósticas e terapêuticas adequadas aos doentes avaliados no contexto da EEMI; ▪ Convocar os colegas das especialidades necessárias para uma adequada abordagem terapêutica do doente que se encontra sob sua observação; ▪ Assegurar o ingresso do doente avaliado no local mais adequado para o mesmo, se necessário com realização de transporte intra ou inter-hospitalar; ▪ Registar de forma correta e adequada a atuação realizada; ▪ Reportar à direção do serviço, ocorrências, incidentes, e complicações ocorridos no período em vigor.	Domínio técnico e científico na área de Medicina Intensiva. Orientação para os objetivos do serviço. Orientação para o doente Capacidade de desenvolver trabalho de equipa Capacidade de comunicação Coordenação e articulação de cuidados Conhecimento organizacional Uso adequado dos recursos disponíveis Capacidade de gestão de conflitos. Atitude de aprendizagem e melhoria contínua Domínio das aplicações informáticas	Assistente Hospitalar ou médico interno da formação específica com reconhecida capacidade de atuação na doença crítica Formação em Suporte Avançado de Vida Formação em Emergência/Intensivismo



▪ **Médico do CDC (Circuito do Doente Crítico)**

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
(Ver documento em anexo sobre as funções do médico CDC aprovadas pela Direção Médica do SMI)	▪ A atividade assistencial desenvolvida pelo médico do CDC desenvolve-se, mediante ativação, na Sala de Reanimação, na consultoria a doentes internados em SO e no transporte de doentes, em estreita colaboração com os colegas do SU e de outras especialidades. ▪ Essa atividade inclui, não exclusivamente: ▪ a abordagem terapêutica e diagnóstica inicial; ▪ os pedidos de consultoria a médicos de diferentes especialidades; ▪ a decisão de iniciar ou excluir medidas extraordinárias de suporte de órgão (em particular ventilação mecânica invasiva e vasopressores); ▪ a proposta de admissão dos doentes no espaço físico do SMI ou noutros serviços de internamento; ▪ a decisão de permanência dos doentes no espaço do SU, em SO; ▪ a identificação e referenciação de potenciais dadores de órgãos; ▪ o encaminhamento dos doentes no SU, incluindo o acompanhamento para a realização de meios complementares de diagnóstico ou ao bloco operatório, sempre que tal for apropriado.	Domínio técnico e científico na área de Medicina Intensiva. Orientação para os objetivos do serviço. Orientação para o doente Capacidade de desenvolver trabalho de equipa Capacidade de comunicação Coordenação e articulação de cuidados Conhecimento organizacional Uso adequado dos recursos disponíveis Capacidade de gestão de conflitos. Atitude de aprendizagem e melhoria contínua Domínio das aplicações informáticas	Assistente Hospitalar ou médico interno da formação específica com reconhecida capacidade de atuação na doença crítica Formação em Suporte Avançado de Vida Formação em Emergência/Intensivismo

Funções e Competências da equipa de Enfermagem, Assistentes Técnicos e Técnicos Auxiliares de Saúde

▪ Enfermeiro Gestor ou Enfermeiro em Funções de Gestão

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
Funções: Gerais e transversais DL nº 71/2019, de 27 de Maio Específicas Regulamento nº101/2015 FDF nº 2 da DSE do HEM Norma 8 Av. Desempenho, ULSLO	- Integrar a gestão do serviço, em colaboração com o responsável, elaborando os respetivos planos de ação e relatórios; - Gerir os cuidados de enfermagem prestados no serviço, supervisionando, orientando e avaliando os mesmos; - Gerir os recursos humanos de enfermagem dotados ao seu serviço elaborando as escalas, mapa de férias, a distribuição diária de acordo com o SCD e mantendo atualizado o suporte informático de apoio ao mesmo (SISQUAL); - Gerir os recursos materiais colocados à sua responsabilidade, expressando necessidades, promovendo a sua boa utilização e promovendo as reparações necessárias; - Propor as medidas necessárias à melhoria da estrutura organizativa, funcional e física do serviço que coordena; - Elaborar políticas e procedimentos para a prestação de cuidados de enfermagem, visando a concretização dos padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem definidos para o hospital; - Promover o intercâmbio de experiências dos enfermeiros na prestação de cuidados, coordenando atividades de formação em serviço;	Orientação para resultados Planeamento e organização Conhecimentos especializados e experiência Responsabilidade e compromisso com o serviço Relacionamento interpessoal Comunicação Trabalho de equipa e cooperação Coordenação Tolerância à pressão e contrariedades- Conhecimento organizacional Coordenação e articulação de cuidados Atitude de aprendizagem e melhoria contínua	Licenciatura em Enfermagem Curso de Especialização em Enfermagem Pós-Graduação em Gestão de Serviços de Saúde (preferencial)



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Avaliar os enfermeiros do serviço e colaborar na avaliação de desempenho dos Técnicos auxiliares de saúde;▪ Participar nas comissões de escolha de material e equipamento a adquirir para a prestação de cuidados;▪ Colaborar na avaliação da qualidade de cuidados de enfermagem definidos para o hospital;▪ Responsabilizar-se pela imagem profissional dos enfermeiros do serviço ou unidade funcional;▪ Colaborar na identificação dos riscos clínicos e não clínicos do serviço ou unidade funcional;▪ Elaborar o Plano e Relatório anual de enfermagem conforme orientação da DSE;▪ Responder a todas as reclamações formalizadas relativas aos profissionais de enfermagem do serviço ou unidade funcional;▪ Participar nas reuniões para as quais for convocado;▪ Manter o organograma do serviço atualizado;▪ Designar elementos “Elos de ligação” pela gestão de risco, GCLPPCIRA, formação e qualidade;▪ Designar um enfermeiro responsável pela organização e manutenção do carro de emergência;▪ Garantir o respeito pelos valores, regras deontológicas e prática legal;▪ Garantir a implementação da melhoria contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem;▪ Garantir a prática profissional baseada na evidência;▪ Garantir o desenvolvimento de competências dos profissionais da equipa que lidera;▪ Gerir os recursos humanos e recursos técnicos e materiais. | <p>Capacidade para gestão de conflitos</p> <p>Conhecimento técnico e científico dos processos</p> <p>Promoção da saúde</p> <p>Uso adequado dos recursos disponíveis</p> <p>Domínio das aplicações informáticas utilizadas na organização</p> |
|--|--|

▪ **Enfermeiro do Serviço de Medicina Intensiva**

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
Funções: Gerais e transversais DL nº 71/2019, de 27 de Maio Específicas Regulamento nº190/2015 FDF nº1 da DSE do HEM Norma 8 Av. Desempenho, ULSLO	▪ Acolher o utente à chegada da UCI e proceder à identificação do mesmo através da pulseira identificativa, confirmando os dados (identificação inequívoca); ▪ Efetuar a vigilância e as observações recomendadas nomeadamente, a monitorização dos parâmetros de acordo com o preconizado ou de acordo com a situação clínica do doente; ▪ Elaborar a nota de entrada / avaliação inicial; ▪ Proceder à identificação das necessidades em cuidados de enfermagem; estabelecer o plano de cuidados tendo em conta o risco de falência das funções vitais; implementar e avaliar os cuidados prestados efetuando os respetivos registos; ▪ Desenvolver os cuidados planificados, respeitando os seus princípios e intervindo ou alterando-os em resposta a uma mudança do estado do doente; ▪ Utilizar os meios ao seu dispor para proporcionar ao doente a manutenção e/ ou aumento das suas capacidades funcionais, segundo a sua condição, nomeadamente na: (1) Respiração (vigilância da função respiratória procedendo à higiene brônquica e otimização da função ventilatória); (2) Mobilização (levantes, posicionamentos, movimentos ativos e passivos, treino de marcha...); (3) Alimentação/ hidratação (privilegia adequada alimentação oral e reforço hídrico); (4) Eliminação (limita a utilização desnecessária de algália, fraldas...); (5) Cuidados de pele e mucosas (prevenção de úlceras de pressão, infeções); (6) Orientação à realidade (proporciona estímulos visuais, auditivos e afetivos); (7) Aplicar as medidas de prevenção das infeções;	Exercer a sua prática profissional de acordo com os quadros ético, deontológico e jurídico Atitude de aprendizagem e melhoria contínua Conhecimentos técnicos e científicos dos processos Uso adequado dos recursos Comunicação e relações interpessoais eficazes Promover um ambiente seguro Contribuir para a promoção da saúde/prevenção da doença/readaptação funcional Domínio das aplicações informáticas utilizadas na organização	Licenciatura em Enfermagem



- (8) Proceder à correta lavagem e desinfeção das mãos nos 5 momentos (orientações) pré definidos pelo UL PPCIRA;
- (9) Utilizar de forma adequada o equipamento de proteção individual (luvas, batas, máscara);
- (10) Cumprimento das normas de triagem de roupa e lixos;
- (11) Cumprir a técnica asséptica na realização de penso a lesão aberta e outros procedimentos que o requeiram;
- (12) Cumprir as normas de isolamento segundo o seu tipo e aplicação do protocolo de descontaminação.
- Administrar terapêutica respeitando os princípios:
 - (1) Confirmar a prescrição;
 - (2) Condições de preparação e administração (doente certo / medicação certa / via certa / dose certa e horário certo);
 - (3) Registrar a administração e se for caso disso o seu efeito terapêutico (analgésico, antipiréticos...) / ou efeitos secundários.
- Registrar no processo do doente (Sistema de informação *Patient Care*):
 - (1) As observações / vigilâncias específicas e alterações do estado do doente;
 - (2) A prestação de cuidados e colaboração do doente (alimentação, higiene, mobilização...);
 - (3) A resposta do doente aos cuidados prestados (quantidades ingeridas, tolerância ao levantar...);
 - (4) A reação do doente aos tratamentos em curso;
 - (5) A recusa de tratamento;
 - (6) Os meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica e colheita de amostras de produtos biológicos.
- Intervir numa situação de urgência segundo as normas do serviço:
 - Iniciar o suporte básico de vida (se for caso disso) e contactar o médico;



- Preparar o utente para os exames complementares de diagnóstico fora da UCI, acompanhar o doente na realização dos mesmos e prestar os cuidados requeridos após os mesmos;
- Articular com a restante equipa de enfermagem a mobilidade dos utentes da UCI para as enfermarias;
- Acompanhar o utente na transferência de serviço (dentro do hospital, ULSLO ou outra instituição de saúde);
- Aplicar medidas de gestão do risco clínico (queda, UP, infeção);
- Tomar as medidas de prevenção de acidentes de acordo com estado do doente (campanhas, grades, pulseira identificadora, isolamento, vigilância...) reportando a sua ocorrência por escrito (eventos adversos / erros e quedas);
- Elaborar a nota de alta / transferência;

▪ **Enfermeiro Chefe de equipa**

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
Funções: Gerais e transversais DL nº 71/2019, de 27 de Maio Específicas Regulamento nº190/2015 FDF nº1 e nº 6 da DSE do HEM Norma 8 Av. Desempenho, ULSLO	Para além das funções de enfermeiro de cuidados gerais, compete-lhe na ausência do Enfº chefe e/ou enfermeiro coordenador: ▪ Coordenar o processo de admissão/acolhimento e de alta/transferência dos utentes; ▪ Rever/Elaborar plano de distribuição diária de enfermeiros e técnicos auxiliares de saúde em função da situação do serviço e regista no sistema de informação <i>Patient Care</i>; ▪ Orientar, coordenar e apoiar a equipa de enfermagem na prestação de cuidados de enfermagem globais e diretos ao utente, sempre que necessário ▪ Orientar, coordenar e supervisionar a equipa de técnicos auxiliares de saúde no desempenho das suas tarefas ▪ Assegurar a gestão dos recursos humanos disponíveis, otimizando a sua eficiência, eficácia e produtividade; ▪ Favorecer a boa relação entre a equipa interdisciplinar devendo ser visto como um elemento de referência; ▪ Coordenar a atuação dos enfermeiros em situações de urgência e de emergência; ▪ Providenciar a correta manutenção e funcionamento do material e equipamento;	Orientação para resultados Planeamento e organização Conhecimentos especializados e experiência Responsabilidade e compromisso com o serviço Relacionamento interpessoal Capacidade de Comunicação Trabalho de equipa e cooperação Coordenação Tolerância à pressão e contrariedades Conhecimentos técnicos e científicos dos processos Uso adequado dos recursos Estabelece comunicação e relações interpessoais eficazes Promove um ambiente seguro	Licenciatura em Enfermagem



- Identificar rotura de materiais e medicamentos e providenciar a respetiva resolução, se urgente;
- Providenciar a devolução ou recuperação de material/equipamento que tenha sido emprestado pelo serviço;
- Reportar ao Enfº chefe as ocorrências significativas do seu turno e as decisões tomadas;
- Gerir os cuidados, otimizando a resposta da equipa de enfermagem e a articulação na equipa multiprofissional;
- Adaptar a liderança e a gestão dos recursos (humanos e materiais) às situações e ao contexto visando a otimização da qualidade dos cuidados;
- Atribuir um Enfermeiro para a equipa de Emergência Intra-hospitalar (EEMI), preferencialmente com SAV ou SIV atualizados;

Contribui para a promoção da saúde/prevenção da doença/readaptação funcional

Domínio das aplicações informáticas utilizadas na Organização



▪ **Enfermeiro Coordenador**

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
Funções: Gerais e transversais DL nº 71/2019, de 27 de Maio Específicas Regulamento nº190/2015 FDF nº1 e nº 6 da DSE do HEM Norma 8 Av. Desempenho, ULSLO	▪ Executar o conteúdo funcional de enfermeiro e de enfermeiro especialista (sempre que estiver habilitado com Curso de Estudos Superiores Especializados) ▪ Prestar cuidados de enfermagem na área onde estiver colocado (sempre que necessário) ▪ Colaborar com o Enfermeiro Chefe na Gestão dos Cuidados de Enfermagem: (1) Orientar, coordenar e apoiar a equipa de enfermagem na prestação de cuidados de enfermagem globais e diretos ao utente, sempre que necessário; (2) Orientar e coordenar os técnicos auxiliares de saúde no desempenho das suas tarefas; (3) Colaborar como Enfermeiro Chefe na resolução de problemas e na análise da qualidade de cuidados, introduzindo as medidas corretivas que forem necessárias; (4) Identificar os doentes com risco de úlceras de pressão e orienta o preenchimento do respetivo registo; (5) Assistir e participar nas reuniões de passagem de turno transmitindo todas as informações que se considerem importantes para o bom funcionamento do serviço; (6) Colaborar sempre que possível na visita médica. ▪ Colaborar com o Enfermeiro Chefe na Gestão dos Recursos Humanos: (1) Elaborar plano de distribuição diária de Enfermeiros e Técnicos auxiliares de saúde; (2) Conferir as trocas de turno efetuadas;	Orientação para resultados Planeamento e organização Conhecimentos especializados e experiência Responsabilidade e compromisso com o serviço Relacionamento interpessoal Comunicação Trabalho de equipa e cooperação Coordenação Tolerância à pressão e contrariedades Conhecimentos técnicos e científicos dos processos Comunicação e relações interpessoais eficazes Promoção da saúde/prevenção da doença/readaptação funcional Domínio das aplicações informáticas utilizadas na Organização	Licenciatura em Enfermagem Curso de Especialização em Enfermagem



- (3) Promover um clima de boas relações interpessoais na equipa de enfermagem e na articulação com a equipa multidisciplinar;
- (4) Promover uma relação de interajuda e de resolução de conflitos entre todos os elementos do serviço;
- (5) Colaborar na avaliação de desempenho dos profissionais de enfermagem e dos Técnicos auxiliares de saúde;
- (6) Colaborar no acolhimento ao serviço dos profissionais recém-admitidos e nos processos de integração dos mesmos.
- Colaborar com o Enfermeiro Chefe na manutenção de materiais e equipamentos:
 - (1) Providenciar a correta manutenção e funcionamento do equipamento;
 - (2) Colaborar na conferência dos inventários do serviço e do material médico-cirúrgico de acordo com a periodicidade estabelecida;
 - (3) Providenciar a devolução ou recuperação de material e equipamento que tenha sido emprestado pelo serviço.
- Colaborar com o Enfermeiro Chefe no sistema de reposição de stock de medicação:
 - (1) Responsabilizar-se por corrigir procedimentos incorretos;
 - (2) Conferir com o Técnico da Farmácia a revisão de níveis do stock de medicação;
 - (3) Verificar o consumo de estupefacientes e providenciar a sua reposição;
 - (4) Conferir as reservas de medicamentos e de outros produtos farmacêuticos e efetuar os respetivos pedidos de reposição.
- Colaborar com Enfermeiro Chefe na formação em serviço:
 - (1) Identificar necessidades de formação, com base nos problemas identificados, necessidades sentidas e incidentes críticos ocorridos;
 - (2) Colaborar com o Enfermeiro Chefe na gestão e organização dos Ensinos clínicos, assim como na distribuição dos estudantes pelos enfermeiros de referência



(Cuidados Gerais e Especialistas);

(3) Colaborar na formação de Estudantes da Licenciatura de Enfermagem e do Curso de Pós-Licenciatura / Mestrado e de outros profissionais em conjunto com os Enfermeiros orientadores dos Ensinos Clínicos.

- Executar outras atividades que lhe sejam solicitadas pela Direção de Enfermagem ou pelo Enfermeiro Chefe, dentro do seu conteúdo funcional
- Assegurar cuidados de enfermagem diferenciados
- Garantir boas práticas profissionais e a qualidade dos cuidados prestados no serviço
- Assegurar com o Enfermeiro Chefe a gestão diária do serviço

▪ **Enfermeiro responsável pela formação**

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
Funções: Gerais e transversais DL nº 71/2019, de 27 de Maio Específicas Regulamento nº190/2015 FDF nº1 e nº4 da DSE do HEM Norma 8 Av. Desempenho, ULSLO	▪ Colaborar com o Enfermeiro Chefe no levantamento de necessidades formativas; ▪ Planear e elaborar em colaboração com o Enfermeiro Chefe, o projeto de formação em serviço, anual, a apresentar à Direção de Enfermagem; ▪ Orientar os enfermeiros designados para apresentação de ações de formação, coordenando reuniões periódicas, nomeadamente no referente a conteúdos, estratégias, treino prévio; ▪ Organizar as sessões (preparação da sala, pedidos formativos) e colaborar com o Enfermeiro Chefe na seleção dos formadores e formandos; ▪ Estimular a participação dos enfermeiros do serviço na implementação e avaliação do plano formativo; ▪ Colaborar com o Enfermeiro Chefe na integração de novos profissionais, através de um plano de integração realista e adequado ao serviço e supervisionar e avaliar a sua implementação junto dos recém-admitidos; ▪ Colaborar com o Enfermeiro Chefe na formação estudantes orientando os respetivos estágios; ▪ Elaborar, em colaboração com o Enfermeiro Chefe, o relatório anual das atividades formativas desenvolvidas no serviço e avaliar a sua eficácia; ▪ Responsabilizar-se pela organização, atualização e divulgação de bibliografia com interesse para o serviço; ▪ Manter organizado e atualizado o Manual de enfermagem em suporte documental em papel ou informatizado; ▪ Estabelecer comunicação e relações interpessoais eficazes.	Conhecimentos especializados e experiência Responsabilidade e compromisso com o serviço Relacionamento interpessoal Trabalho de equipa e cooperação Tolerância à pressão e contrariedades Atitude de aprendizagem e melhoria contínua Domínio das aplicações informáticas utilizadas na Organização Capacidade de organização e coordenação Capacidade de motivação Capacidade de comunicação Conhecimento das necessidades formativas dos profissionais Aptidão pedagógica	Licenciatura em Enfermagem Curso de Especialização em Enfermagem (preferencial)

▪ **Enfermeiro Elo de Ligação com o Departamento de Qualidade e Segurança**

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
Funções: Gerais e transversais DL nº 71/2019, de 27 de Maio	▪ Dinamizar a replicação da formação dos Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem; ▪ Integrar os Enfermeiros recém-admitidos na política de Qualidade da Instituição e do Serviço;	Conhecimentos especializados e experiência Trabalho de equipa e cooperação	Licenciatura em enfermagem Formação em Gestão de Risco
Específicas Regulamento nº190/2015 FDF nº1 e nº10 da DSE do HEM Norma 8 Av. Desempenho, ULSLO	▪ Colaborar com o elemento de enfermagem da Comissão da Qualidade do ULSLO para os projetos de âmbito institucional; ▪ Colaborar na dinamização dos projetos organizacionais no âmbito dos Padrões da Qualidade dos Cuidados de Enfermagem (MAQCEH, úlceras, quedas, satisfação do doente, prevenção da infeção, planeamento de altas ...); ▪ Colaborar com o Enfermeiro Chefe na definição e implementação da política de qualidade e projetos de melhoria continua no contexto da prática clínica; ▪ Colaborar com o Enfermeiro Chefe na organização e atualização do manual da qualidade e suportes de informação da qualidade (manuais/intranet); ▪ Efetuar formação à equipa nas áreas de risco identificadas; ▪ Monitorizar a percentagem de enfermeiros com formação em gestão de risco e qualidade; ▪ Elaborar relatório anual e apresentar o mesmo ao Enfermeiro Chefe; ▪ Efetuar propostas de melhoria contínua; ▪ Promover um ambiente seguro; ▪ Contribuir para a promoção da saúde/prevenção da doença/readaptação funcional.	Orientação para resultados Planeamento e organização Responsabilidade e compromisso com o serviço Tolerância à pressão e contrariedades Atitude de aprendizagem e melhoria contínua Capacidade de comunicação e relações interpessoais eficazes. Capacidade de motivação em relação ao risco Domínio das aplicações informáticas utilizadas na Organização	Formação em triagem de resíduos hospitalares

▪ **Enfermeiro Elo de ligação com Serviço de Saúde e Segurança no Trabalho (SSST)**

O Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
Funções: Gerais e transversais DL nº 71/2019, de 27 de Maio Específicas Regulamento nº190/ 2015 FDF nº1 e nº8 da DSE do HEM Norma 8 Av. Desempenho, ULSLO	- Participar em reuniões periódicas com o SSST; - Comunicar ao SSST toda e qualquer situação irregular que surja no Serviço ou Unidade, no âmbito da Saúde, Higiene e Segurança; - Colaborar nas visitas do SSST ao Serviço para caracterização da situação a nível de Saúde, Higiene e Segurança; - Colaborar com o SSST na resolução dos problemas, sempre que para isso seja solicitado; - Transmitir aos profissionais do Serviço as orientações emanadas pelo SSST; - Orientar, supervisionar e monitorizar o cumprimento dessas mesmas orientações; - Colaborar com o SSST nas ações de formação em Serviço na área da Saúde, Higiene e Segurança, sempre que para tal seja solicitado; - Assegurar a articulação entre o SSST e o serviço; - Promover em colaboração com o SSST a identificação e implementação de medidas que visem a melhoria das condições de saúde, higiene e segurança dos profissionais; - Promover um ambiente seguro; - Contribuir para a promoção da saúde/prevenção da doença/readaptação funcional.	Domínio das normas e procedimentos relativos à utilização, manuseamento e manutenção dos equipamentos Capacidade de planeamento, organização e coordenação Conhecimentos especializados e experiência Responsabilidade e compromisso com o serviço Trabalho de equipa e cooperação Tolerância à pressão e contrariedades Atitude de aprendizagem e melhoria contínua Uso adequado dos recursos Capacidade de comunicação e relações interpessoais eficazes Domínio das aplicações informáticas utilizadas na Organização	Licenciatura em enfermagem Curso de Especialização em Enfermagem (preferencial)

▪ **Enfermeiro Elo de Ligação com GL-PPCIRA**

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
Funções: Gerais e transversais DL nº 71/2019, de 27 de Maio Específicas Regulamento nº190/2015 Regulamento interno da Comissão de Controlo de Infecção, ULSLO	▪ Colaborar em estudos de vigilância epidemiológica no âmbito do controlo de infeção; ▪ Participar na elaboração de procedimentos com base nas recomendações do GL-PPCIRA para o serviço; ▪ Orientar os profissionais de enfermagem do serviço ou unidade face às medidas de prevenção e controlo de infeção hospitalar; ▪ Supervisionar a execução das boas práticas, procedimentos ou outras medidas de controlo de infeção emitidas pelo GL-PPCIRA no respetivo serviço; ▪ Identificar problemas de estrutura, de processo e/ou de resultados com impacto na área da prevenção e controlo da infeção; ▪ Informar o GL-PPCIRA em caso de suspeita de surto epidémico ou de outras situações de risco em controlo da infeção; ▪ Colaborar na realização de auditorias às práticas nos respetivos serviços; ▪ Colaborar com o GL-PPCIRA na identificação de necessidades de formação nos profissionais do serviço; ▪ Dinamizar e participar como formador em ações de formação na área de controlo de infeção; ▪ Monitorizar a percentagem de profissionais do serviço com formação em prevenção, controlo de infeção e resistência aos antimicrobianos; ▪ Participar nas reuniões marcadas pelo GL-PPCIRA para as quais seja convocado;	Domínio das estratégias do PPCIRA relativamente às Precauções Básicas em Controlo de Infeção. Conhecimentos técnico-científicos especializados e experiência Capacidade de organização e planeamento Capacidade de motivação Orientação para resultados Responsabilidade e compromisso com o serviço Relacionamento interpessoal Capacidade de Comunicação Capacidade de Trabalho de equipa e cooperação Tolerância à pressão e contrariedades Capacidade de comunicação e relações interpessoais eficazes Atitude de aprendizagem e melhoria contínua Domínio das aplicações informáticas utilizadas na Organização	Licenciatura em enfermagem Curso pós-licenciatura em especialização em Enfermagem (preferencial) Formação na área de Prevenção e controlo de Infeção e Resistência aos antimicrobianos



- Elaborar e divulgar relatório anual sobre o controlo de infeção;
- Exercer a sua prática profissional de acordo com os quadros ético, deontológico e jurídico;
- Promover um ambiente terapêutico e seguro;
- Contribuir para a promoção da saúde/prevenção da doença/readaptação funcional.



▪ **Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação**

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
Funções: Gerais e transversais DL nº 71/2019, de 27 de Maio Específicas Regulamento nº 190/2015 FDF nº9 da DSE do HEM Norma 2 Av. Desempenho, CHLO Regulamento das competências comuns do enf. Especialista e específicas em enfermagem de reabilitação da OE Diário de Rep nº 85/2019 Art. 5º ANEXO I	▪ Efetuar avaliação inicial a todos os doentes admitidos no serviço a fim de identificar alterações funcionais reais ou potenciais, temporárias ou permanentes, decorrentes da situação clínica do doente assim como as potenciais complicações com impacto no funcionamento futuro no domicílio; ▪ Implementar plano de cuidados, quer executando cuidados diretos e ensino específico, quer orientando a equipa de enfermagem nos cuidados a prestar para manter ou restaurar a função e prevenir complicações, estabelecendo prioridades tendo em vista o potencial do doente focando: ▪ Manutenção da Integridade cutânea, muscular e osteoarticular (mobilizações e posicionamentos) ▪ Reeducação funcional respiratória ▪ Controlo de função de eliminação ▪ Treino de atividades de vida diária (autocuidado) ▪ Transferências cama/cadeira/cama ▪ Treino equilíbrio, marcha, readaptação ao esforço; ▪ Identificar e propor ao doente/família ajudas técnicas e as adaptações necessárias no domicílio a fim de garantir um ambiente seguro e orienta a sua aquisição; ▪ Orientar o planeamento de alta e continuidade de cuidados na enfermaria ou domicílio providenciando o ensino ao doente /familiar prestador de cuidados face às necessidades identificadas;	Planeamento e organização Conhecimentos especializados e experiência Conhecimentos técnicos e científicos dos processos Responsabilidade e compromisso com o serviço Relacionamento interpessoal Trabalho de equipa e cooperação Coordenação Tolerância à pressão e contrariedades Exercer a sua prática profissional de acordo com os quadros ético, deontológico e jurídico em equipa Atitude de aprendizagem e melhoria contínua Conhecimentos técnicos e científicos dos processos Uso adequado dos recursos	Licenciatura em enfermagem Curso de especialização em Enfermagem de Reabilitação



- Identificar necessidades de formação e promover formação formal e informal da equipa de enfermagem e de Técnicos auxiliares de saúde;
- Assegurar cuidados de enfermagem diferenciados;
- Cuidar de pessoas com necessidades especiais, em contexto de internamento na UCI;
- Promover a capacitação da pessoa para a reinserção e exercício da cidadania;
- Promover e maximizar a funcionalidade desenvolvendo as capacidades da pessoa;
- Promover um ambiente terapêutico e seguro;
- Contribuir para a promoção da saúde/prevenção da doença/readaptação funcional;
- Orientar a equipa nos cuidados a prestar quando oportuno, atuando como consultor técnico na sua área de especialidade.

Capacidade de comunicação e relações interpessoais eficazes

Domínio das aplicações informáticas utilizadas na Organização



▪ **Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica**

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
Funções: Gerais e transversais DL nº 71/2019, de 27 de Maio Específicas Norma Nº 7 da avaliação de desempenho do CHLO: Cuidados de Enfermagem Especializados à Pessoa em Situação Crítica	▪ Cuidar da pessoa a vivenciar processos complexos de doença crítica e ou falência orgânica: - Prestar cuidados à pessoa em situação emergente e na antecipação da instabilidade e risco de falência orgânica; - Fazer a gestão diferenciada da dor e do bem-estar da pessoa em situação crítica e ou falência orgânica, otimizando as respostas; - Assistir a pessoa e família nas perturbações emocionais decorrentes da situação crítica de saúde/doença e ou falência orgânica; - Gerir a comunicação interpessoal que fundamenta a relação terapêutica com a pessoa/família face à situação de alta complexidade do seu estado de saúde; - Gerir o estabelecimento da relação terapêutica perante a pessoa/família em situação crítica e ou falência orgânica; ▪ Dinamizar a resposta a situações de catástrofe ou emergência multi-vítima, da conceção à ação: - Gerir os cuidados em situações de Emergência e ou Catástrofe; ▪ Maximizar a intervenção na prevenção e controlo da infeção perante a pessoa em situação crítica e ou falência orgânica, face à complexidade da situação e à necessidade de respostas em tempo útil e adequadas: - Liderar o desenvolvimento de procedimentos de controlo de infeção, de acordo com as normas de prevenção, designadamente das Infeções Associadas à Prestação de Cuidados de Saúde à pessoa em situação crítica e ou falência orgânica.	Responsabilidade e compromisso com o serviço; Planeamento e Organização; Coordenação; Orientação para o cidadão; Orientação para resultados; Conhecimentos especializados e experiência; Comunicação; Relacionamento interpessoal; Trabalho de equipa e cooperação; Tolerância à pressão e contrariedades; Orientação para os objetivos do serviço. Exerce a sua prática profissional de acordo com os quadros ético, deontológico e jurídico; Conhecimento organizacional; Capacidade para gestão de conflitos; Conhecimento técnico e científico dos processos; Uso adequado dos recursos disponíveis; Promove um ambiente seguro;	Licenciatura em enfermagem Curso de especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica

▪ Enfermeiro do EEMI (Equipa de Emergência Médica Intra-hospitalar)

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
DQ nº 15/DQS/DQCO de 22/06/2010 DL nº 198/2018, série II	▪ Colaborar nas ativações do EEMI: Observação, estabilização e início de medidas terapêuticas adequadas aos doentes avaliados no contexto da EEMI; ▪ Assegurar o ingresso do doente avaliado no local mais adequado para o mesmo, se necessário com realização de transporte intra ou inter-hospitalar; ▪ Registar de forma correta e adequada a atuação realizada; ▪ Monitorizar o News em todos os turnos; ▪ Avaliar junto ao doente ou por contacto telefónico com o médico assistente os doentes sinalizados no NEWS; ▪ Realizar a verificação diária da mala de transporte do EEMI, caso o selo esteja desbloqueado; ▪ Realizar a verificação diária do monitor; ▪ Rever a cada 15 dias a <i>check list</i> da mala do EEMI e fazer os testes de avaliação do monitor do EEMI; ▪ Garantir a integridade do material do EEMI;	Capacidade de comunicação com os diferentes profissionais do Serviço Formação interna hospitalar sobre News Domínio das normas e procedimentos internos Capacidade de desenvolver trabalho em equipa Atitude de aprendizagem e melhoria contínua Capacidade de iniciativa Conhecimento organizacional Uso adequado dos recursos disponíveis Capacidade de comunicação e relações interpessoais eficazes Domínio das aplicações informáticas utilizadas na Organização	Licenciatura em enfermagem Formação SIV (Suporte Imediato de Vida) e/ou Formação SAV (Suporte Avançado de Vida) (preferencial)



▪ **Enfermeiro Responsável pela Manutenção do Carro de Emergência**

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
Funções: Gerais e transversais DL nº 71/2019, de 27 de Maio Específicas Regulamento nº190/2015 Norma 8 Av. Desempenho, ULSLO	▪ Organizar o carro de emergência de acordo com a Norma da DGS e os procedimentos internos (Procedimento nº1 da DSE – Organização do carro de emergência); ▪ Efetuar o teste do desfibrilhador / verificar o registo da verificação automática; ▪ Verificar o selo do carro de emergência; ▪ Verificar e registar a validade dos medicamentos e material de consumo clínico; ▪ Garantir a legibilidade dos registos efetuados; ▪ Reportar as não conformidades ao Enfermeiro Chefe; ▪ Exercer a sua prática profissional de acordo com os quadros ético, deontológico e jurídico; ▪ Promover um ambiente seguro; ▪ Participar na formação do SBV no serviço.	Domínio das normas e procedimentos relativos ao carro de emergência Domínio no manuseamento do desfibrilhador Responsável pelas verificações (protocolo) e <i>checklist</i>. Conhecimentos especializados e experiência Trabalho de equipa e cooperação Tolerância à pressão e contrariedades Atitude de aprendizagem e melhoria contínua Uso adequado dos recursos Capacidade de comunicação e relações interpessoais eficazes.	Licenciatura em enfermagem Formação em SBV e / ou SAV (preferencial)



▪ **Enfermeiro da Consulta de Follow-up SMI**

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
Diário de Rep. nº 132/2017, Série 1, Nº 1, Artº3, Secção 1, da Port nº 207/2017, alinea d) e e)	- Realizar a colheita de dados (parâmetros biomédicos), avaliação inicial, registo no SClínico; - Avaliar o utente para o risco de SPICI (Síndrome Pós-internamento em Cuidados Intensivos), com a aplicação das seguintes escalas: EuroQol 5D (instrumento de avaliação da qualidade de vida relacionada com a saúde), ADH (avaliação de Ansiedade e Depressão) após internamento Hospitalar. - Planear os cuidados a prestar, de acordos com os dados colhidos e analisados previamente; - Identificar (nome, contacto telefónico), o representante legal / prestador de cuidados e registar na avaliação inicial do SClínico; - Avaliar o cuidador informal, caso exista, segundo a escala CADI (Índice para avaliação das dificuldades do prestador de cuidados), Escala CAMI (Índice para avaliação das maneiras como o prestador de cuidados enfrenta as dificuldades) e ADH (avaliação de Ansiedade e Depressão), fazer o Registo no SClínico e se necessário encaminhar para a especialidade respetiva; - Capacitar o prestador de cuidados para a continuidade dos cuidados ao utente; - Entregar Questionário de Satisfação da Consulta Externa ao utente ou representante legal / cuidador informal; - Exercer a sua prática profissional de acordo com os quadros ético, deontológico e jurídico; - Contribuir para a promoção da saúde/prevenção da doença/readaptação funcional.	Conhecimentos especializados e experiência Trabalho de equipa e cooperação Tolerância à pressão e contrariedades Atitude de aprendizagem e melhoria contínua Uso adequado dos recursos Capacidade de comunicação e relações interpessoais eficazes.	Licenciatura em enfermagem

▪ **Fisioterapeuta**

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
Diário de Rep. nº 85/2023, 2ª série REG. nº 490/2023	- Determinar o plano de intervenção em Fisioterapia e Reabilitação; - Otimizar a função cardiopulmonar; - Realizar Fisioterapia Respiratória (promoção de clearance de secreções brônquicas, manutenção e recrutamento de volume pulmonar, manualmente e com dispositivos de assistência); - Colaborar na colocação de Ventilação Não-Invasiva (escolha de interface, dispositivos e modalidade; otimização dos parâmetros ventilatórios); - Colaborar no Desmame da Ventilação Mecânica; - Promover o programa de Mobilização e Reabilitação Precoce; - Posicionar o doente, com objetivos de otimização da condição cardiopulmonar, proteção articular, prevenção de contraturas e otimização do tônus muscular; - Promover independência funcional e otimizar tolerância ao exercício; - Gerir a patologia músculo-esquelética; - Utilizar dispositivos e ortóteses (e.g. medição de colar cervical, ortóteses de coluna, programação de estimulação elétrica neuromuscular; dispositivos de higiene brônquica e assistência da tosse); - Promover a Educação dos doentes (exercício, reabilitação, assistência ventilatória, assistência da tosse e higiene brônquica, estilos de vida).	Capacidade de comunicação com os diferentes profissionais do Serviço Capacidade relacional e de comunicação com utentes e familiares Domínio das normas e procedimentos internos Domínio das Aplicações Informáticas Capacidade de desenvolver trabalho em equipa Atitude de aprendizagem e melhoria contínua Capacidade de iniciativa Conhecimento organizacional Uso adequado dos recursos disponíveis	Licenciatura em Fisioterapia

▪ **Técnicos Auxiliares de Saúde**

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
DL nº 120/2023, de 22 de Dezembro	▪ Colaborar, sob supervisão, na prestação de cuidados de higiene e conforto aos doentes; ▪ Colaborar, sob supervisão, na movimentação / posicionamento e transferências dos doentes; ▪ Colaborar com o enfermeiro no posicionamento correto do doente para se alimentar; prepara o tabuleiro da refeição e coloca-o de fácil acesso, se o doente se alimentar autonomamente. Se o doente necessitar de ajuda, administra a refeição se o enfermeiro lho delegar; ▪ Realizar a higiene oral do doente ou fornecer o material para o mesmo a fazer; ▪ Proceder à receção, conferência e armazenamento de dispositivos médicos esterilizados; ▪ Preparar os dispositivos médicos para esterilização; ▪ Colaborar na vigilância e segurança do serviço transmitindo à equipa as ocorrências e situações anómalas (avarias, faltas de material, desaparecimentos e danos, pessoas estranhas, comportamentos inadequados); ▪ Proceder à higienização e manutenção de superfícies e equipamentos, em conformidade com as normas do serviço e procedimentos de boas práticas do GL-PPCIRA; ▪ Assegurar o serviço de mensageiro; ▪ Assegurar atividades de apoio logístico, como atendimento de campainhas, de telefones, reposição de material;	Capacidade de desenvolver trabalho em equipa Atitude de aprendizagem e melhoria contínua Orientação para o utente Capacidade de iniciativa Domínio nas necessidades básicas dos utentes (alimentação, eliminação, mobilização e higiene) Capacidade de comunicação com os diferentes profissionais do Serviço Capacidade relacional e de comunicação com utentes e familiares Domínio das normas e procedimentos internos Conhecimento organizacional Uso adequado dos recursos disponíveis	Escolaridade mínima obrigatória Formação em: - Precauções básicas no controlo de Infecção - Triage de resíduos sólidos hospitalares



- Proceder à receção das visitas, encaminhando para o enfermeiro responsável sempre que for necessário prestar esclarecimentos;
- Colaborar na gestão dos resíduos sólidos hospitalares;
- Desenvolver outras atividades para as quais seja solicitado, dentro do seu conteúdo funcional.



▪ **Assistente Técnico (Direção do Serviço)**

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
Diário da Rep. nº 117/2014, 1ª série Artigo nº 88 da Lei 35/2014 Regulamento Interno do SGD	▪ Apoiar a recolha e organização da documentação para despacho do Diretor de Serviço, designadamente: ▪ Escalas do serviço ▪ Faltas, baixas e outros impedimentos ou as alterações de férias ou de escalas, ▪ Reclamações ou elogios de doentes, familiares ou profissionais; ▪ Agendamento de reuniões do serviço e divulgação de reuniões de outros serviços ▪ Atas de reuniões ▪ Apoiar o Diretor de Serviço na Gestão do SMI; ▪ Apoiar a coordenação dos estágios dos médicos do serviço ou dos médicos de outras especialidades.	- Capacidade de desenvolver trabalho em equipa - Atitude de aprendizagem e melhoria contínua - Capacidade de iniciativa - Capacidade de comunicação com os diferentes profissionais do Serviço - Capacidade relacional e de comunicação com utentes e familiares - Domínio das normas e procedimentos internos - Conhecimento organizacional - Domínio das Aplicações Informáticas	12º ano de escolaridade, com formação profissional ou universitária - Atendimento - Aplicação Alert - Aplicação Sonho - Ferramentas do Office



▪ **Assistente Técnico (Internamento)**

Decreto-Lei	FUNÇÕES	Competências	Formação mínima
Diário da Rep. nº 117/2014, 1ª série Artigo nº 88 da Lei 35/2014 Regulamento Interno do SGD	▪ Garantir um atendimento personalizado consoante as dificuldades dos doentes; ▪ Recolher / completar todos os dados identificativos possíveis para que haja um correto preenchimento do processo hospitalar do doente; ▪ Prestar apoio e secretariado administrativo ao Serviço, designadamente com a abertura do processo de internamento do doente, a entrega de informação no momento da transferência / alta e envio do processo do doente para codificação clínica; ▪ Articular estreitamente com o pessoal de enfermagem, de forma a recolher todas as informações que sejam uteis, para os utentes no âmbito das suas competências; ▪ Em qualquer situação o secretariado não poderá fornecer informações de natureza clínica, mas deve promover com a celeridade possível o encaminhamento das questões para o clínico ou enfermeiro responsável pelo doente; ▪ Atualizar constantemente o processo digitalizado; anexar documentos ao processo do doente.	Capacidade de desenvolver trabalho em equipa Atitude de aprendizagem e melhoria contínua Capacidade de iniciativa Capacidade de comunicação com os diferentes profissionais do Serviço Capacidade relacional e de comunicação com utentes e familiares Domínio das normas e procedimentos internos Conhecimento organizacional Domínio das Aplicações Informáticas	12º ano de escolaridade, com formação profissional ou universitária Atendimento Aplicação Alert Aplicação Sonho Ferramentas do Office

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.002.00
Carteira de Serviços	
Procedimento Multissetorial	

1. OBJETIVO

Descrever o conjunto de atividades de prestação de cuidados-carteira de serviços-disponíveis pelo Serviço de Medicina Intensiva da Unidade (SMI) da Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental (ULSLO).

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente documento é dirigido a todos os profissionais que exercem funções no SMI, para divulgação aos utentes da comunidade em geral e aos serviços requisitantes internos e externos à instituição para que tenham conhecimento dos serviços disponíveis no SMI.

3. RESPONSABILIDADES

- Elaboração do presente documento: Dra. Marta Rebelo
- Revisão do documento: Dr. Pais Martins

4. SIGLAS, ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS

SMI: Serviço de Medicina Intensiva

ULSLO: Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental

UCI: Unidade de Cuidados Intensivos

ECCO2R: Remoção extracorporal de CO2

PICCO: Pulse Contour Cardiac Output

BIS: Índice Bispectral

PCA: Patient-Controlled Analgesia

NCA: Nursed –Controlled Analgesia

CA 23/10/2024

Aprovado

Dr. Pais Martins
Unidade Local de Saúde
LISBOA OCIDENTAL, E.P.E.
Conselho de Administração
H. de R. de S.

Elaboração	Revisão	Aprovação	Próxima edição
Dra. Marta Rebelo	Dr. Pais Martins	CHLO - EPE Direção do SMI DR. PAIS MARTINS	09/2027
		Data: 28/09/2024	Página: 1/5

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.002.00
Carteira de Serviços	
Procedimento Multissetorial	

5. DESCRIÇÃO

5.1. Enquadramento:

O SMI é uma estrutura orgânica da ULSLO, incluída na Área do Doente Crítico, que agrupa diversas áreas funcionais e que presta assistência, ensino pré e pós-graduado e investigação na área do doente emergente/crítico. Para além da área de influência da ULSLO, o SMI presta assistência a uma população que ultrapassa o milhão de pessoas. O SMI é Polo do Eixo de Referência em Medicina Intensiva, que integra o Hospital de Cascais, o Hospital Garcia da Orta (ULS de Almada-Seixal), o Centro Hospitalar de Setúbal (ULS da Arrábida) e o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo (ULS do Arco Ribeirinho).

É missão do SMI a organização e coordenação dos recursos existentes na ULSLO, com a criação de áreas dirigidas à assistência clínica, à investigação e à formação pré e pós-graduada que visem contribuir para maior eficiência técnica e social, promover uma maior qualificação e rentabilização das estruturas e melhor prestação de cuidados.

5.2. Descrição:

A equipa do SMI assume a responsabilidade integral dos utentes internados no Serviço. São prestados pelo SMI cuidados aos doentes que englobam o diagnóstico, tratamento médico e realização de procedimentos que auxiliam no diagnóstico e tratamento. É também realizado o seguimento clínico dos doentes com risco de desenvolvimento de Síndrome Pós Internamento em Cuidados Intensivos (SPICI) em consulta de follow-up.

O SMI é, ainda, apoiado institucionalmente por outras especialidades médicas (Anestesiologia, Infeciologia, Gastroenterologia, Imuno-hemoterapia, Cardiologia, Medicina Física e Reabilitação, Reumatologia, Oncologia e Psiquiatria) e cirúrgicas (Cirurgia Geral, Neurocirurgia, Urologia, Cirurgia Cardiorácica, Cirurgia Vascular, Ortopedia, Urologia) e por outros serviços como a Farmácia Hospitalar, Radiologia, Patologia Clínica, Anatomia Patológica e Microbiologia Clínica, bem como profissionais de diversas áreas como fisioterapeutas, nutricionistas e assistentes sociais.

O SMI desenvolve atividades pedagógicas nas áreas de ensino médico e de enfermagem, pré e pós-graduado.

A carteira de serviços é divulgada aos profissionais da ULSLO através da Intranet. É também divulgada através da Internet, no site MyULSLO, para os utentes e para os serviços requisitantes externos à instituição tomarem conhecimento dos serviços disponíveis no SMI.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	10/2024	10/2027	2/5

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.002.00
Carteira de Serviços	
Procedimento Multissetorial	

A carteira de serviços é revista e atualizada sempre que ocorra alguma alteração pertinente no seu conteúdo.

Para assegurar o cumprimento das suas responsabilidades clínicas, o SMI dispõe da seguinte carteira de serviços.

1. ÁREA ASSISTENCIAL CLÍNICA

- Unidades de Internamento do Doente Crítico
- Unidade de Internamento de Doente Neurocrítico
- Consultaria Hospitalar e *Outreach*
- Circuito do Doente Crítico
- Consulta de Follow-up
- Suporte de Dador de Órgãos e Doação
- Urgência e Emergência

2. TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO SMI

2.1. ABORDAGEM DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO

- Reanimação cardio-respiratória avançada;
- Manutenção das vias aéreas, incluindo entubação oro e naso traqueal, via aérea avançada, traqueotomia cirúrgica e percutânea,
- Ventilação mecânica (invasiva e não invasiva) em modalidades convencionais, avançadas e estratégias complementares e melhoria da oxigenação e remoção de CO₂ [ventilação em decúbito ventral, manobras de recrutamento, remoção extracorporal de CO₂ (ECCO2R) com plataforma de substituição renal]
- Oxigenoterapia de alto fluxo
- Monitorização oximétrica contínua e monitorização gasimétrica
- Colocação de drenos torácicos
- Broncofibroscopia diagnóstica e terapêutica
- Fisioterapia respiratória e Cinesioterapia

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	10/2024	10/2027	3/5

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.002.00
Carteira de Serviços	
Procedimento Multissetorial	

2.2. ABORDAGEM DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA DO SISTEMA CARDIOVASCULAR E RENAL

- Monitorização cardíaca contínua
- Monitorização invasiva e não invasiva da pressão arterial
- Colocação de cateteres venosos e arteriais pela via clássica e ecoguiados
- Monitorização invasiva das pressões da aurícula direita, ventrículo direito e artéria pulmonar e débito cardíaco por cateter Swanz-Ganz
- Monitorização hemodinâmica por cateter PiCCO™
- “Pacing” cardíaco temporário (externo e endocavitário)
- Técnicas contínuas de depuração/substituição renal, plasmaférese, hemoperfusão

2.3. ABORDAGEM DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA DA FUNÇÃO CEREBRAL

- Punção e drenagem lombar
- Monitorização da Pressão intracraniana (PIC)
- Doppler Transcraniano
- Monitorização de sedação pelo Índice Bispectral (BIS) uni e bilateral
- Monitorização de oximetria cerebral (monitor INVOS™)

2.4. DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO

- Aparelho portátil para radiologia convencional
- Ecografo multiusos com sonda cardíaca, abdominal e vascular
- Intensificador de imagens disponível na Imagiologia

2.5. OUTRAS TÉCNICAS DISPONÍVEIS:

- Monitorização da Pressão intra-abdominal
- Técnicas endoscópicas digestivas, urológicas
- Terapia da dor (Analgesia epidural por PCA, NCA, analgesia sistémica)
- Aparelho para aferição de gases no sangue, electrólitos e metabólitos
- Monitorização farmacocinética de fármaco
- Ecocardiografia transtorácica e tranesofágica

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	10/2024	10/2027	4/5

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.002.00
Carteira de Serviços	
Procedimento Multissetorial	

- Equipamento portátil de suporte vital para transporte intra ou interhospitalar
- Consultoria de todas as especialidades existentes na ULSLO
- Consulta de Follow-up para os doentes internados na UCI e com risco de Síndrome Pós-Internamento em Cuidados Intensivos

3. ÁREA DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO

- Formação pré-graduada: alunos de Medicina da NOVA Medical School/Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.
- Formação pré-graduada dos alunos de Enfermagem (área de doente crítico)
- Cursos de Formação pós-graduada:
 - Formação de internos de formação específica de vários Serviços do Hospital e de outros Hospitais
 - Programa de Formação Via Clássica em Medicina Intensiva.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	10/2024	10/2027	5/5

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.001.00
Regulamento Das Equipas de Emergência Médica Intra-Hospitalar	
Procedimento Multissetorial	

1. OBJETIVO

- a) Definir os propósitos, modelo de organização e funcionamento das Equipas de Emergência Médica Intra-hospitalar (EEMI) da Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental (ULSLO) no Hospital de São Francisco Xavier (HSFX) e do Hospital de Egas Moniz (HEM).

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- a) As EEMI foram criadas com o intuito de assegurar uma melhoria efetiva dos cuidados prestados aos doentes adultos internados no HSFX e no HEM e a todos os frequentadores adultos das instalações do HSFX e do HEM (doentes, acompanhantes, funcionários ou outros) suscetíveis de doença aguda que configure uma situação de Emergência Médica.

3. RESPONSABILIDADES

- a) Responsáveis Implementação do procedimento: Dr. Pedro Santos; Dr. Francisco Coelho e Enf. Pedro Rodrigues.
- b) Responsáveis pela revisão do procedimento: Dr. David Nora, Dra. Marta Rebelo

CR 23/10/2024

Aprovado

[Handwritten signature]

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
LISBOA OCIDENTAL, E.P.E.
Conselho de Administração

Elaboração	Revisão	Aprovação	Próxima edição
Dr. Pedro Santos Dr. Francisco Coelho Enf. Pedro Rodrigues	Dr. David Nora Dra. Marta Rebelo	<i>[Handwritten signature]</i> CHLO-EPE DIRETOR DO SERVIÇO MEDICINA INTENSIVA DR. PAIS MARTINS	09/2027
		Data: 10/09/2024	Página: 1/21

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA		SMI.PM.001.00
Regulamento Das Equipas de Emergência Médica Intra-Hospitalar		
Procedimento Multissetorial		

4. SIGLAS, ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS

- a) EEMI- Equipa de Emergência Médica Intra-Hospitalar
- b) SMI- Serviço de Medicina Intensiva
- c) UCI- Unidade de Cuidados Intensivos
- d) SAV- Suporte Avançado de Vida
- e) HSFX- Hospital São Francisco de Xavier
- f) HEM- hospital Egas Moniz
- g) ULSLO- Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental
- h) ISBAR- (Identificação, Situação atual, Antecedentes, Avaliação e Recomendações)

5. DEFINIÇÕES E CONCEITOS

- a) “Não aplicável”

6. DESCRIÇÃO

6.1. Enquadramento:

Os doentes que são internados nos Hospitais acreditam que estão a ser admitidos num espaço seguro, onde eles e as suas famílias têm o direito a receber o melhor tratamento possível, e sentem-se confiantes que, se a sua condição clínica se agravar, estão no melhor sítio para uma pronta e eficaz intervenção.

É importante reconhecer o mais precocemente possível a deterioração clínica, potencialmente grave e fatal. Os casos de morte intra-hospitalar inesperada são maioritariamente precedidos de sinais de instabilidade clínica do doente. Estes sinais refletem a falência dos diversos órgãos e sistemas e devem ser atempadamente reconhecidos pelos profissionais de saúde, independentemente da doença subjacente ao internamento.

Assim, é fundamental assegurar, em ambiente hospitalar, a deteção precoce de sinais de deterioração clínica dos doentes internados e de disfunções agudas graves de indivíduos que frequentem as instalações hospitalares, para que, desencadeando a ativação e intervenção atempada dos profissionais competentes, se obtenha uma melhoria sustentada dos cuidados de saúde.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	09/2024	09/2027	2/21

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.001.00
Regulamento Das Equipas de Emergência Médica Intra-Hospitalar	
Procedimento Multissetorial	

A Medicina Intensiva tem a capacidade e a responsabilidade de abordar e gerir todos os doentes críticos em ambiente hospitalar, assumindo, por isso, com naturalidade, a coordenação e operacionalização das EEMI.

Neste contexto, a Direção-Geral da Saúde, através da Circular Normativa nº 15/DQS/DQCO, de 22 de junho de 2010⁽¹⁾, determinou a criação e implementação, a nível nacional, das EEMI, reconhecendo a sua importância e necessidade na orgânica hospitalar.

O despacho nº 9639/2018 do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde⁽²⁾ reforça a relevância das EEMI, determinando a sua composição por um médico e um enfermeiro com competências avançadas na abordagem do doente crítico e em técnicas de reanimação, com capacidade de resposta não apenas em situações de paragem cardiorrespiratória, mas também em situações de significativa deterioração fisiológica aguda. Todos os profissionais de cada instituição devem ter o conhecimento das EEMI, das situações que justificam a sua intervenção, do processo para a sua correta ativação e da sua metodologia de intervenção.

A rápida ativação da EEMI é crucial, havendo evidência científica robusta que a sua atividade reduz a mortalidade e a morbilidade dos doentes. No despacho supramencionado é feita a sugestão, assumida já por várias Sociedades Científicas Europeias, de que deve haver um número de telefone interno universal para a sua ativação o - 2222, sendo também este o número sugerido para Portugal pela DGS (SNS), com o apoio do Conselho Português de Ressuscitação.

6.2. Recursos

Cada EEMI é composta por um médico e um enfermeiro com experiência na reanimação e abordagem do doente crítico, preferencialmente com formação em Suporte Avançado de Vida (SAV), com escala dedicada. O Serviço de Medicina Intensiva (SMI) da ULSLO é responsável pela operacionalização da EEMI através da afetação de recursos humanos e supervisão técnica.

Os médicos da EEMI são Intensivistas do SMI, assistentes hospitalares ou internos do SMI e de outros serviços da ULSLO ou prestadores externos, a quem são reconhecidas a experiência clínica e competência necessárias ao exercício de funções na equipa, que desempenham sempre sob coordenação e apoio do(s) Intensivista(s) do SMI em presença permanente no HEM (UCI 1) e no HSFX (UCI 3 e/ou UCI 4). Os enfermeiros da EEMI pertencem à equipa de enfermagem do SMI

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	09/2024	09/2027	3/21

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.001.00
Regulamento Das Equipas de Emergência Médica Intra-Hospitalar	
Procedimento Multissetorial	

no HEM (UCI 1) e no HSFx (UCI 3 e UCI 4). A coordenação da EEMI do HEM está a cargo dos Drs. Pedro Santos e Francisco Neves Coelho e do Enfermeiro Pedro Rodrigues. A coordenação da EEMI do HSFx está a cargo do Dr. David Nora e do Enfermeiro Pedro Rosa.

As EEMI estão organizadas num modelo que pressupõe telecomunicações dedicadas, equipa multidisciplinar de resposta rápida em permanência, com referenciarão e reencaminhamento para a abordagem secundária que estiver indicada, em articulação com todos os serviços da ULSLO. A área de intervenção da EEMI no HEM e no HSFx inclui todo o hospital (áreas clínicas e não clínicas), com exceção do Serviço de Urgência Geral, Serviço de Urgência Pediátrica, Serviço de Pediatria, Serviço de Neonatologia (para doentes internados) e dos Blocos Operatórios (para doentes internados).

6.3. Descrição:

6.3.1. ATIVAÇÃO (HEM)

De acordo com as recomendações resultantes da reunião da *"First Consensus Conference on Medical Emergency Team"*, é necessário, para além da criação de uma equipa de emergência médica intra-hospitalar (EEMI), a definição de uma componente "aferente" de deteção dos doentes com agravamento do seu estado clínico e em risco de paragem cardiorrespiratória; seguido da ativação da EEMI, que dará uma resposta organizada e padronizada. Recentes estudos têm demonstrado que os critérios de identificação desses doentes de risco devem ser abrangentes e alargados.

Note-se que este componente aferente é o início de todo o processo; o *trigger* de todo o sistema, pelo que deve ser-lhe dado um particular enfoque na fase de implementação destas equipas.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	09/2024	09/2027	4/21

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.001.00
Regulamento Das Equipas de Emergência Médica Intra-Hospitalar	
Procedimento Multissetorial	

A ativação da EEMI no HEM deverá ser realizada nas seguintes situações:

-	PARAGEM CARDIO-RESPIRATÓRIA
A	COMPROMISSO DA VIA AÉREA
B	PARAGEM RESPIRATÓRIA FREQ RESP < 6 OU > 35 ciclos/min SpO2 < 85% COM O ₂ SUPLEMENTAR
C	PARAGEM CARDÍACA FREQ CARD < 40 OU > 140 + SINAIS DE GRAVIDADE* HIPOTENSÃO REFRATÁRIA (PAS < 80 mmHg OU PAM < 60 mmHg)
D	GCS < 10 OU DIMINUIÇÃO AGUDA > 2 PONTOS CRISE CONVULSIVA PROLONGADA OU REPETIDA
E	Score de NEWS > 7 pontos (ver Anexo1) PREOCUPAÇÃO DA EQUIPA ASSISTENCIAL E/OU RESPOSTA INADEQUADA AO TRATAMENTO PRÉVIO
T	TRANSPORTE DE DOENTE CRÍTICO
* DOR TORÁCICA, ALTERAÇÃO DO ESTADO DE CONSCIÊNCIA, SINAIS DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA OU HIPOTENSÃO	

Tabela 1- Critérios de Ativação da EEMI no HEM

Tão ou mais importante do que a observação de valores num determinado momento, é a sua evolução dinâmica em avaliações sucessivas.

- A EEMI deve ser ativada pelo médico assistente ou médico de urgência interna, exceto a paragem cardio-respiratória que pode ser ativada por qualquer profissional do Hospital Egas Moniz.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	09/2024	09/2027	5/21

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.001.00
Regulamento Das Equipas de Emergência Médica Intra-Hospitalar	
Procedimento Multissetorial	

- A EEMI deverá ser ativada através do telefone com o nº 2222, de acordo com os critérios de ativação, nas áreas clínicas e não clínicas, para situações clínicas urgentes e emergentes localizadas em áreas clínicas e não clínicas, cujo limite geográfico se localiza no portão exterior do hospital.
- A EEMI quando ativada tem como principal objetivo o tratamento de uma situação aguda/agudizada; NUNCA deverá ser ativada em situações já definidas de ONR (ordem de não reanimação).

Após o reconhecimento de qualquer critério de ativação, a testemunha deve:

1. Ligar a extensão 2222; selecionar a opção 2 (correspondente ao HEM) após atendimento automático
2. Identificar-se
3. Indicar local
4. Indicar critério de ativação
5. Iniciar medidas terapêuticas ou reanimação se aplicável, até à chegada de ajuda diferenciada.

Sempre que a ativação seja feita por um médico e/ou enfermeiro do ULSLO, numa área clínica, este deve de imediato:

1. Aproximar o carro de emergência
2. Monitorizar o doente (ECG, oximetria, pressão arterial não invasiva)
3. Iniciar oxigenoterapia, cateterizar veia periférica (sempre que aplicável)
4. Iniciar e manter Suporte Básico de Vida (sempre que aplicável)

Para efeitos de comunicação entre os serviços clínicos e a EEMI, e conforme recomendação da DGS (norma 001/2017) ⁽⁴⁾, sugere-se que os profissionais de saúde utilizem o instrumento de comunicação ISBAR (Anexo 2).

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	09/2024	09/2027	6/21

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.001.00
Regulamento Das Equipas de Emergência Médica Intra-Hospitalar	
Procedimento Multissetorial	

6.3.2. APÓS ATIVAÇÃO (HEM)

A EEMI deslocar-se-á até ao local da ativação, transportando consigo todo o equipamento necessário à intervenção requerida. Após estabilização do doente, a EEMI deverá avaliar adequadamente de nível de cuidados necessário para o doente em questão e assegurar o seu correto encaminhamento tão cedo quanto possível.

Uma vez que não existe urgência externa no HEM, nas situações em que a EEMI é ativada para doentes não internados, i.e.: na consulta externa, áreas de exames complementares de diagnóstico, visitas, etc., os mesmos serão transportados o mais rapidamente possível até Hospital de Dia (dentro do seu horário de funcionamento) de modo a serem adequadamente tratados / estabilizados. Durante a permanência no Hospital de Dia e até ser definido o seu encaminhamento, o doente continua a ser responsabilidade da EEMI. Fora do horário normal de funcionamento do Hospital de Dia a decisão dependerá sempre da situação e da decisão do Médico escalado de EEMI nesse dia, podendo, também, ser utilizado o espaço físico do Hospital de Dia (chave com a Equipa de Vigilantes), se necessário. Decidida a admissão para internamento, se não existir vaga no HEM deverá ser primeiro promovido o transporte para outra instituição hospitalar da ULSLO e só em último recurso para uma ULS diferente.

A realização de transporte intra ou inter-hospitalar do doente sob a alçada da EEMI é da responsabilidade da mesma, tal como definido no Manual atualizado de Transporte do Doente Crítico da ULSLO. O transporte de outros doentes críticos que não se encontrem sob a responsabilidade da EEMI, deverá ser avaliado e decidida conjuntamente pela EEMI e os Médicos Assistentes/ Médicos de Urgência Interna e sempre de acordo o estipulado no Manual de Transporte do Doente Crítico da ULSLO.

A colaboração e a comunicação com os outros Médicos de Urgência Interna no HEM é absolutamente primordial, já que situações de saída da EEMI para realização de transporte ou situações de ativação simultânea, condicionam a sua interoperabilidade (ver ponto 6.9).

6.3.3. ATIVAÇÃO (HSFX)

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	09/2024	09/2027	7/21

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.001.00
Regulamento Das Equipas de Emergência Médica Intra-Hospitalar	
Procedimento Multissetorial	

A área de intervenção da EEMI no HSFX inclui todo o hospital (áreas clínicas e não clínicas), com exceção do Serviço de Urgência Geral, Serviço de Urgência Pediátrica, Serviço de Pediatria, Serviço de Neonatologia (para doentes internados) e Blocos Operatórios (para doentes internados). O Bloco de Partos integra a área de intervenção da EEMI do HSFX.

Definem-se como critérios de ativação da EEMI no HSFX todas as situações de paragem cardiorrespiratória ocorrida ou eminente, assim como disfunções agudas potencialmente emergentes em indivíduos adultos localizados nas áreas clínicas e não clínicas do HSFX, como expresso seguinte Tabela 2.

A	COMPROMISSO DA VIA AÉREA
B	PARAGEM RESPIRATÓRIA FREQ RESP < 6 OU > 35 ciclos/min SpO2 < 85% COM O ₂ SUPLEMENTAR
C	PARAGEM CARDÍACA FREQ CARD < 40 OU > 140 + SINAIS DE GRAVIDADE* HIPOTENSÃO REFRATÁRIA (PAS < 80 mmHg OU PAM < 60 mmHg)
D	GCS < 10 OU DIMINUIÇÃO AGUDA > 2 PONTOS CRISE CONVULSIVA PROLONGADA OU REPETIDA
E	PREOCUPAÇÃO DA EQUIPA ASSISTENCIAL E/OU RESPOSTA INADEQUADA AO TRATAMENTO PRÉVIO
T	TRANSPORTE DE DOENTE CRÍTICO
* DOR TORÁCICA, ALTERAÇÃO DO ESTADO DE CONSCIÊNCIA, SINAIS DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA OU HIPOTENSÃO	

Tabela 2- Critérios de Ativação do EEMI no HSFX

Após o reconhecimento de qualquer critério de ativação, a testemunha deve:

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	09/2024	09/2027	8/21

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.001.00
Regulamento Das Equipas de Emergência Médica Intra-Hospitalar	
Procedimento Multissetorial	

1. Ligar a extensão 2222; selecionar a opção 1 (correspondente ao HSFx) após atendimento automático
2. Identificar-se
3. Indicar local
4. Indicar critério de ativação
5. Iniciar medidas terapêuticas ou reanimação se aplicável, até à chegada de ajuda diferenciada.

Sempre que a ativação seja feita por um médico e/ou enfermeiro do ULSLO, numa área clínica, este deve de imediato:

1. Aproximar o carro de emergência
2. Monitorizar o doente (ECG, oximetria, pressão arterial não invasiva)
3. Iniciar oxigenoterapia, cateterizar veia periférica (sempre que aplicável)
4. Iniciar e manter Suporte Básico de Vida (sempre que aplicável)

Para efeitos de comunicação entre os serviços clínicos e a EEMI, e conforme recomendação da DGS (norma 001/2017), sugere-se que os profissionais de saúde utilizem o instrumento de comunicação ISBAR (Anexo 1).

6.3.4. APÓS ATIVAÇÃO (HSFX)

Ao apelo do 2222, responde a EEMI, 24h por dia, todos os dias do ano. Se a EEMI der procedência à ativação, a equipa constituída por médico e enfermeiro dirigir-se-á ao local do evento, com equipamento próprio (mala médica com desfibrilhador portátil).

As áreas clínicas do HSFx estão equipadas com carros de emergência, que devem ter o material de reanimação considerado essencial para situações críticas, a ser usado em conformidade com a EEMI.

A gestão clínica e posterior encaminhamento do doente é da responsabilidade da EEMI, que assegura o transporte intra e inter-hospitalar do doente, sempre que aplicável. Em caso de necessidade de transporte inter-hospitalar, a decisão relativa à equipa de transporte obedece ao protocolo de transporte do doente crítico da ULSLO e do SMI. Todas as situações de exceção, são

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	09/2024	09/2027	9/21

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.001.00
Regulamento Das Equipas de Emergência Médica Intra-Hospitalar	
Procedimento Multissetorial	

alvo de análise e decisão individualizada pelo responsável da EEMI e pela Direção do SMI. Perante a necessidade de transporte de doentes deverá ser sempre minimizado o tempo de indisponibilidade de resposta da EEMI.

6.4. Registos

Em todas as situações de ativação será efetuado um registo em formulário próprio da responsabilidade da EEMI (HEM Figura 1 e HSFx Figura 2) e um registo resumido e adequado da intervenção em processo clínico online.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	09/2024	09/2027	10/21



SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.001.00
Regulamento Das Equipas de Emergência Médica Intra-Hospitalar	
Procedimento Multissetorial	



EEMI/UC11 HEM: Folha de registo de ativação

Nº ativação: ____/20__

Inserção na base dados ☐ Sim ☐ Não
(A preencher no momento de tratamento estatístico)

1. Identificação de caso		
Ativação equipa Data: ____/____/____ Hora: ____h ____min Término de caso / Retorno da equipa Data: ____/____/____ Hora: ____h ____min Tempo de resposta: ____min (Tempo entre chamado e chegada ao local médico - enfermeiro EEMI)	Identificação do utente (colar visível ou preencher) Nº processo: ____ Nome utente: ____ Admissão: ____/____/____ Idade: ____ Género ☐ Masculino ☐ Feminino	
Localização: Áreas clínicas ☐ Enfermaria: ____ ☐ Outro: ____ (consultas, técnicas, imagiologia, dermatologia, ...) Áreas não clínicas: (finas, oficinas, repositório, etc...)	☐ Serviço responsável: ____ ☐ Exterior: ____ (Rua)	
2. Ativação/Dados pré evento		
Ativação 2222-2: ☐ Sim ☐ Não	Ativação por: ☐ Médico ☐ Enfermeiro ☐ Outro: ____ ☐ Evento agudo ☐ Transporte de doente crítico ☐ Avaliação EEMI/ Risco clínico	
Motivo de ativação: (em caso de evento agudo) ☐ Paragem cardiopulmonar (PCR) ☐ Paragem Respiratória ☐ Frequência respiratória <6 ou >35 /m ☐ Frequência Cardíaca inferior a 40 bpm ou superior a 140 bpm, quando acompanhado de critérios de gravidade (Dor torácica, alteração do estado de consciência, sinais de insuficiência cardíaca congestiva ou hipotensão); ☐ Pressão Arterial Sistólica <90mmHg	☐ Compromisso via aéreas ☐ SaO2 <85% com oxigénio suplementar (qualquer) ☐ Escala de Coma de Glasgow - diminuição > 2 pontos ☐ Score de NEWS - Score ≥ 7 ☐ Outro: ____	
Status do utente na ativação ☐ Transferência de UCI há menos de 24h ☐ Transferência de outro hospital há menos de 24h ☐ Transferência do SU há menos de 24h		☐ Ambulatório ☐ Funcionário ☐ Outro: ____
3. Condição clínica na ativação		
Nível de consciência Escala ACDU (valores 1 a 4) ☐ Alerta ☐ Confuso ☐ Sem resposta ☐ Sonolento	Escala de coma de Glasgow Score O V M	

Atualizado a: 31/04/2024
Dr. Pedro Santos, En. Carla Dias, En. Pedro Rodrigues

Figura 1- Folha de registo EEMI no HEM.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	09/2024	09/2027	11/21

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.001.00
Regulamento Das Equipas de Emergência Médica Intra-Hospitalar	
Procedimento Multissetorial	

FOLHA DE REGISTO

DATA ____/____/____ LOCAL ____
(ÁREA CLÍNICA / ÁREA NÃO CLÍNICA)

HORA ATIVAÇÃO ____ h HORA CHEGADA ____ h

HORA FIM ATIVAÇÃO ____ h DESTINO ____

MOTIVO PRINCIPAL DE ATIVAÇÃO

A	COMPROMISSO DA VIA AÉREA	
B	PARAGEM RESPIRATÓRIA FREQ RESP < 6 OU > 35 SpO2 < 85% COM O ₂ SUPLEMENTAR	
C	PARAGEM CARDÍACA FREQ CARD < 40 OU > 140 + SINAIS DE GRAVIDADE* HIPOTENSÃO REFRATÁRIA (PAS < 80 mmHg OU PAM < 60 mmHg)	
D	GCS < 10 OU DIMINUIÇÃO AGUDA > 2 PONTOS CRISE CONVULSIVA PROLONGADA OU REPETIDA	
E	PREOCUPAÇÃO DA EQUIPA ASSISTENCIAL E/OU RESPOSTA INADEQUADA AO TRATAMENTO PRÉVIO	
F	TRANSPORTE DOENTE CRÍTICO	
* DOR TORÁCICA, ALTERAÇÃO DO ESTADO DE CONSCIENCIA, SINAIS DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA OU HIPOTENSÃO		

OBSERVAÇÕES

MÉDICO _____ Nº MEC _____ Nº ORDEM _____
ENFERMEIRO _____ Nº MEC _____ Nº ORDEM _____

Figura 2- Folha de registo EEMI no HSFx

6.5. Fluxogramas (HEM)

Edição	Próxima edição	Página
Nº 01 09/2024	09/2027	12/21



SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.001.00
Regulamento Das Equipas de Emergência Médica Intra-Hospitalar	
Procedimento Multissetorial	

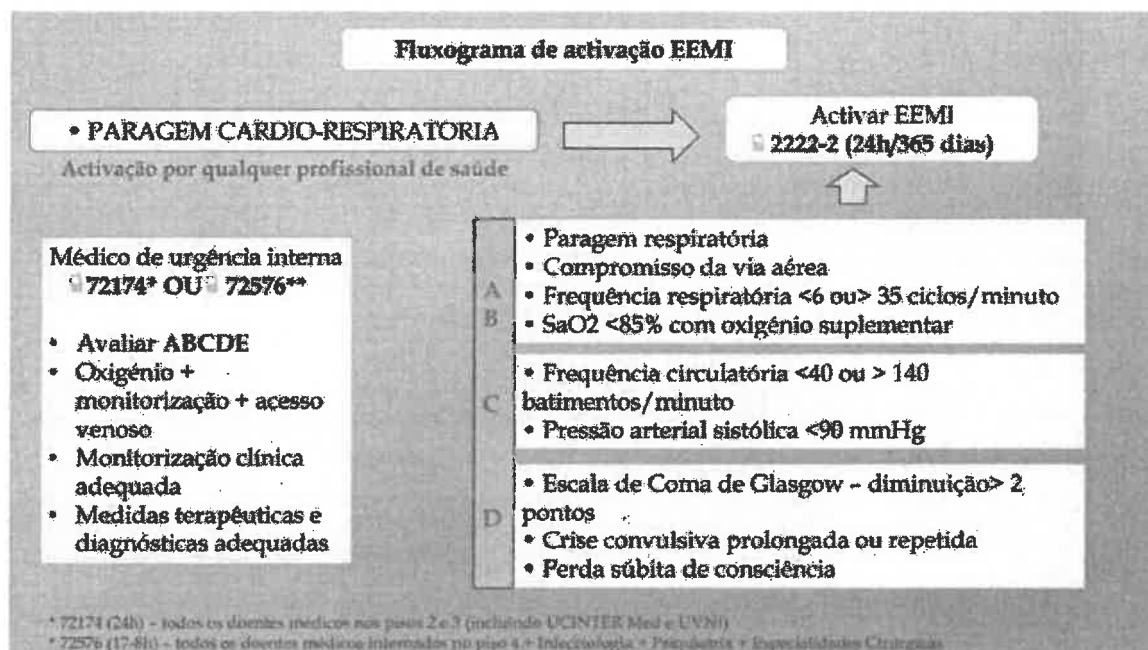


Figura 3- Fluxograma de ativação EEMI HEM em áreas não clínicas

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	09/2024	09/2027	13/21

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.001.00
Regulamento Das Equipas de Emergência Médica Intra-Hospitalar	
Procedimento Multissetorial	

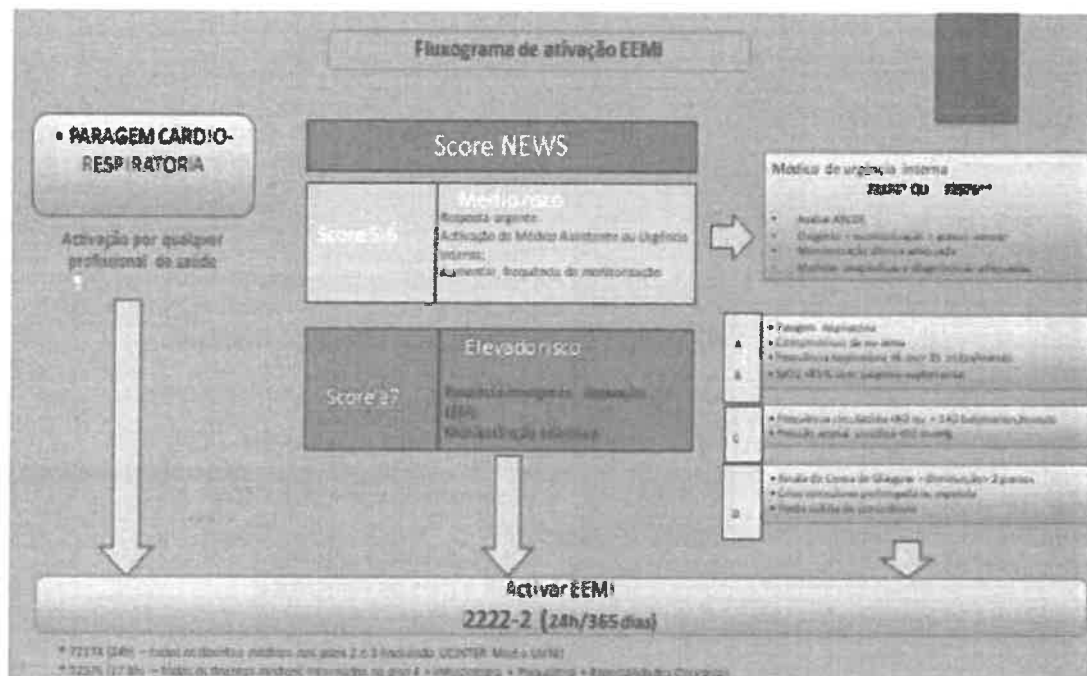


Figura 4- Fluxograma de ativação EEMI HEM em áreas clínicas

F

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	09/2024	09/2027	14/21

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.001.00
Regulamento Das Equipas de Emergência Médica Intra-Hospitalar	
Procedimento Multissetorial	

6.6. Fluxogramas (HSFX):

Nas figuras 4 e 5 estão representados os fluxogramas de funcionamento para as áreas clínicas e não clínicas no HSFX.

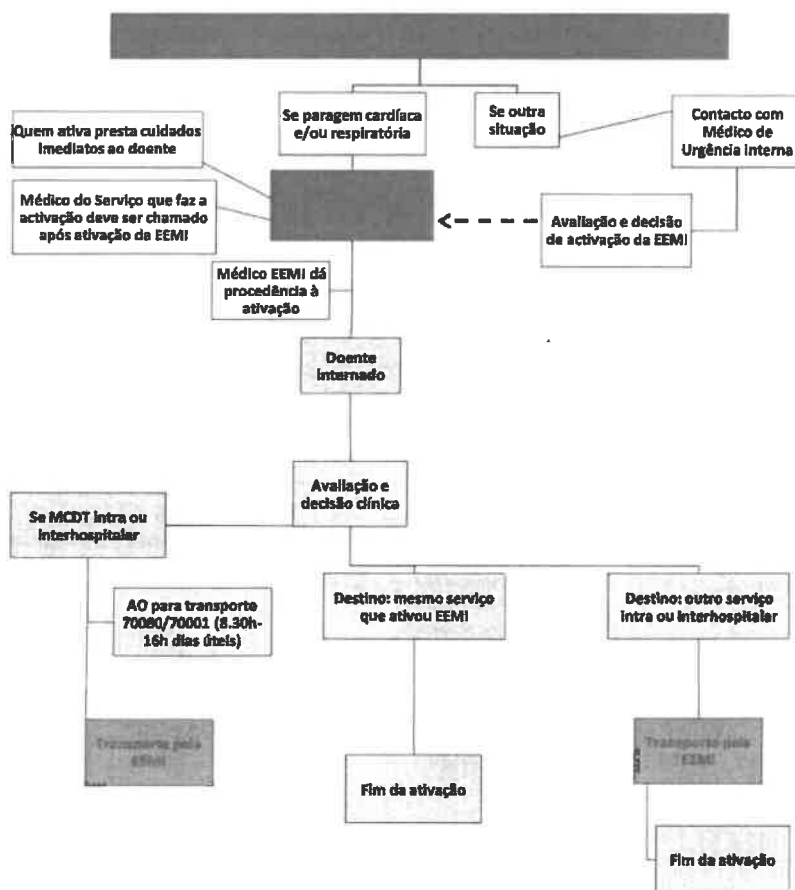


Figura 5- Fluxograma de ativação EEMI HSFX em áreas não clínicas

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	09/2024	09/2027	15/21

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.001.00
Regulamento Das Equipas de Emergência Médica Intra-Hospitalar	
Procedimento Multissetorial	

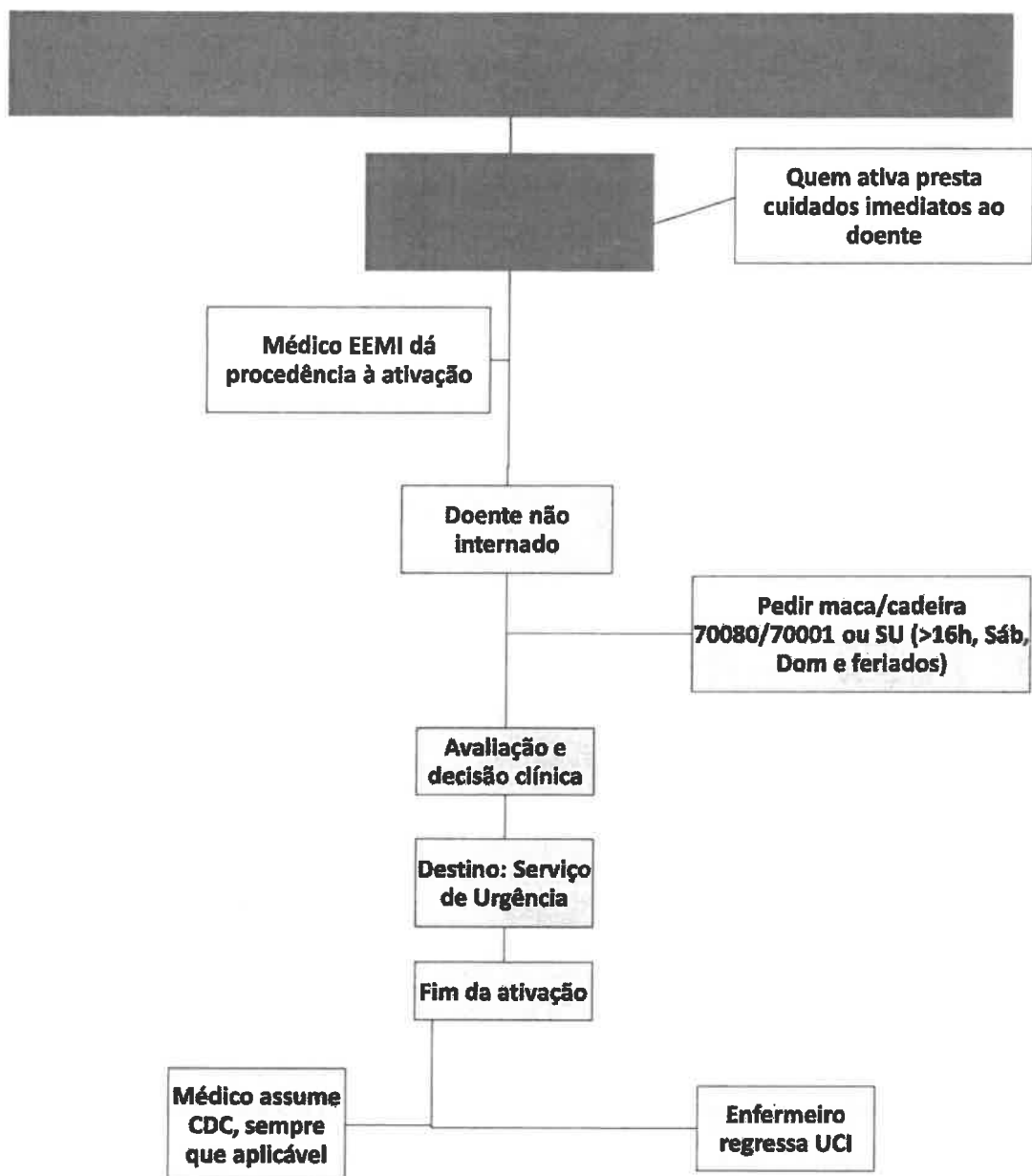


Figura 6- Fluxograma de ativação EEMI HSFx em áreas clínicas

Edição	Próxima edição	Página
Nº 01 09/2024	09/2027	16/21



SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.001.00
Regulamento Das Equipas de Emergência Médica Intra-Hospitalar	
Procedimento Multissetorial	

Nas áreas clínicas, quando a ativação for feita por um enfermeiro ou outro profissional não médico, e sem que isso atrase a ativação da EEMI e os cuidados ao doente, deve ser contactado o médico responsável do serviço (urgência interna, desfasamento, consulta).

6.7. Indicadores

A melhoria contínua da qualidade é um objetivo da EEMI. Assim a EEMI, mediante auditoria aos registos realizados e processo clínico dos doentes assistidos, realiza as seguintes atividades:

Discussão semestral de mortalidade, morbilidade e das mortes evitáveis dos doentes para os quais a EEMI foi ativada, em momento de discussão aberto às direções dos serviços (diretores médicos e enfermeiros chefes);

Discussão semestral da atividade, tempos de resposta e atuação da equipa com base em *case study* ou *mix cases*, com enfoque nas implicações decorrentes das intervenções da EEMI (ausência de registos, iatrogenias, *outcome*);

Criação de um sistema de *follow-up* a operacionalizar pelos elementos da EEMI, que nos casos em que o doente assumido pela EEMI e se mantenha hospitalizado deve ser presencial e nas situações após alta hospitalar deverá ser realizado por contacto telefónico;

Implementação de um sistema de divulgação de resultados e deliberações resultantes do ciclo de melhoria contínua da qualidade a implementar pela EEMI.

6.8. Equipamento

As EEMI têm à sua disposição o equipamento e fármacos necessários para uma intervenção eficaz, cumprindo rigorosamente as recomendações em vigor. Existem elementos no SMI, responsáveis pela verificação e manutenção dos equipamentos e fármacos utilizados pelas EEMI, através da verificação de uma “*check list*”, com verificação regular e auditada.

Todos os serviços clínicos da ULSLO estão dotados de um carro de emergência, padronizado conforme Procedimento n.º1 da DSE, Relativo à Política n.º2 da DSE, de acordo com a orientação nº 008/2011 da DGS.

A atuação em áreas não clínicas implica a utilização de equipamentos complementares de reanimação que serão transportados pela EEMI.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	09/2024	09/2027	17/21

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.001.00
Regulamento Das Equipas de Emergência Médica Intra-Hospitalar	
Procedimento Multissetorial	

6.9. Formação

A formação em emergência e reanimação é fulcral para o sucesso de um programa institucional de resposta a situações de emergência clínica. É necessário, portanto, que tendencialmente todos os colaboradores do hospital estejam preparados para (1) reconhecer uma situação de deterioração clínica (de acordo com os critérios de ativação da EEMI), (2) pedir ajuda diferenciada, (3) iniciar suporte básico de vida, se indicado. À EEMI compete assegurar uma resposta atempada e apropriada à situação, garantindo que a cadeia de sobrevivência intra-hospitalar seja eficaz e eficiente. É essencial que o SMI promova uma boa comunicação com todos os serviços e profissionais do hospital, que permita realizar a divulgação da EEMI (objetivos, organização, metodologia) e receber o feedback relativo à sua atividade.

Todos os profissionais colaboradores da EEMI devem receber formação regular em SAV e noutras áreas relevantes para a abordagem de doentes urgentes e emergentes, como abordagem da via aérea, ventilação invasiva e não invasiva, sépsis, trauma, entre outros.

A criação da EEMI deve pressupor o compromisso institucional de garantia de preferência aos elementos da EEMI na inscrição nestas formações, sempre que realizadas no âmbito do Plano de Formação anual da ULSLO. Assim que seja possível do ponto de vista logístico e epidemiológico, devem ser organizados eventos de *mass training* em suporte básico de vida, a todos os colaboradores do SMI

6.10. Inoperacionalidade

É um compromisso do SMI garantir a operacionalidade permanente das EEMI. Podem, contudo, ocorrer períodos de inoperacionalidade, seja por ausência de profissional (médico e/ou enfermeiro), ou por inerência da atividade da EEMI (ativações simultâneas, transportes, atividade médica no Circuito do Doente Crítico do HSFx).

Qualquer que seja o motivo da inoperacionalidade, a assistência ao doente crítico nos serviços de internamento ou no SU, sem prejuízo da atividade assistencial das UCIs do SMI, é

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	09/2024	09/2027	18/21



SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.001.00
Regulamento Das Equipas de Emergência Médica Intra-Hospitalar	
Procedimento Multissetorial	

prestada pelos profissionais destas Unidades, numa lógica de complementaridade e abrangência do SMI.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

7.1. Fontes citadas: n/a

7.2. Fontes consultadas:

- 1) Circular Normativa nº 15/DQS/DQCO, de 22 de junho de 2010. <https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/circular-normativa-n-15dqsdcqco-de-22062010-pdf.aspx>
- 2) Correia N, Rodrigues RP, Sá MC, Dias P, Lopes L, Paiva A. Improving recognition of patients at risk in a Portuguese general hospital: results from a preliminary study on the early warning score. Int J Emerg Med. 2014 Jul 10;7:22. doi: 10.1186/s12245-014-0022-7. PMID: 25635187; PMCID: PMC4306038.
- 3) Despacho nº 9639/2018 do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. <https://files.dre.pt/2s/2018/10/198000000/2753327534.pdf>
- 4) DGS (norma 001/2017). <https://normas.dgs.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/10/comunicacao-eficaz-na-transicao-de-cuidados-de-saude.pdf>

8. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES

a) Preencher a tabela infra de acordo com os itens apresentados.

EDIÇÃO	DATA	ALTERAÇÕES AO DOCUMENTO
00	29/01/2020	Elaboração
01	11/10/2004	Atualização do regulamento, abarcando agora a atividade de ambas as EEMI (HSFX e HEM) e atualizando fluxogramas.

Edição	Próxima edição	Página
Nº 01	09/2024	19/21

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.001.00
Regulamento Das Equipas de Emergência Médica Intra-Hospitalar	
Procedimento Multissetorial	

9. ANEXOS

1) Score de NEWS

PARÂMETRO FISIOLÓGICO	3	2	1	0	1	2	3
FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (cpm)	≤8		9-11	12-20		21-24	≥25
% PERIFÉRICA DE O ₂	≤91	92-93	94-95	≤96			
O ₂ SUPLEMENTAR		Sim		Não			
TEMPERATURA (°C)	≤35.0		35.1-36.0	36.1-38.0	38.1-39	≥39.1	
TA SISTÓLICA (mmHg)	≤90	91-100	101-110	111-219			≥220
FREQUÊNCIA CARDÍACA (bpm)	≤40		41-50	51-90	91-110	111-130	≥131
NÍVEL DE CONSCIÊNCIA				Alerta			V/P/I*
* V: resposta apenas a Voz; D: resposta apenas a Dor; I: Inconsciente ou não responsivo a qualquer estímulo							

Pontuação NEWS	Risco clínico	Monitorização	Resposta
0	Baixo	Mínima a cada 12h	Continuar cuidados
1-4	Baixo	Mínima a cada 4-6h	Continuar cuidados Informar enfermeira responsável de turno
5-6 3 em qualquer parâmetro	Médio	Horária	Resposta urgente Ativação de médico assistente ou urgência interna
≥7	Alto	Contínua	Resposta emergente Ativação EEMI

Edição	Próxima edição	Página
Nº 01	09/2024	20/21



SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	SMI.PM.001.00
Regulamento Das Equipas de Emergência Médica Intra-Hospitalar	
Procedimento Multissetorial	

2) Mnemónica ISBAR

I - Identificação Identificação e localização precisa dos intervenientes na comunicação e do doente	a) Nome completo, data nascimento, género; b) Nome e função do emissor; c) Nome e função do recetor; d) Serviço de origem/destinatário;
S - Situação Atual/Causa Descrição do motivo atual de necessidade de cuidados de saúde	a) Data e hora de admissão; b) Descrição do motivo atual do internamento; c) Meios complementar de diagnóstico e terapêutica.
B - Antecedentes/Anamnese Descrição de factos clínicos, de enfermagem e outros relevantes, diretivas antecipadas de vontade	a) Antecedentes clínicos e Níveis de dependência; b) Diretivas antecipadas de vontade; c) Alergias conhecidas ou da sua ausência; d) Hábitos relevantes; e) Terapêutica de ambulatório e adesão à mesma; f) Técnicas invasivas realizadas; g) Presença ou risco infeção nosocomial; h) Identificação da situação social.
A - Avaliação Informações sobre o estado do doente, terapêutica instituída, estratégias de tratamento, alterações de estado de saúde significativas e avaliação da eficácia das medidas implementadas	a) Problemas ativos; b) Terapêutica instituída; c) Alterações de estado de saúde significativas e avaliação da eficácia das medidas implementadas; d) Focos de atenção, diagnósticos e intervenções ativas.
R - Recomendações Descrição de atitudes e plano terapêutico adequados à situação clínica do doente	a) Indicação do plano de continuidade de cuidados; b) Informação sobre consultas e MCDT agendados; c) Identificação de necessidades do cuidador informal.
Adaptado de DGS, Norma 001/2017 de 08/02/2017	

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	09/2024	09/2027	21/21

Auditoria a Processo Assistencial

Serviço de Medicina Intensiva

2023/2024



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
LISBOA OCIDENTAL

Serviço de Medicina Intensiva
Processo Assistencial da HSA por rotura de Aneurisma Cerebral
Auditoria Interna

Serviço auditado: Serviço de Medicina Intensiva (SMI)

Local: Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental (ULSLO)

Data: 23/10/2024

Responsável de Auditoria: Dra. Patrícia Moniz, Dr. Pedro Freire e Dra. Marta Rebelo

Universo:

Processos clínicos de doentes internados no SMI nos seguintes 3 períodos (semestrais):

- 1) 1 de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2023 (1º Período)
- 2) 1 de julho de 2023 a 31 de dezembro de 2023 (2º Período)
- 3) 1 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024 (3º Período)

Método:

Análise retrospectiva dos dados relativos aos indicadores de qualidade para o Processo Assistencial da Hemorragia subaracnoideia (HSA) por rotura de Aneurisma Cerebral.

Os indicadores selecionados para este Processo Assistencial foram obtidos da *Guideline* de cuidados neurocríticos na hemorragia subaracnoideia da *Neurocritical Care Society* (2023) e da *Guideline* da *American Heart Association/American Stroke Association* (2023).

Os resultados foram obtidos do processo informático utilizado no Serviço de Medicina Intensiva (PATIENTCARE-ICU), dos doentes com diagnóstico de admissão/diagnóstico associado/ diagnóstico de alta de Hemorragia Subaracnoideia. O período de análises considerado foi de 1 de janeiro de 2023 e 30 de junho de 2024.

Um total de 93 processos clínicos foram elegíveis para auditoria com base no diagnóstico de Hemorragia Subaracnoideia, mas só 69 desses diagnósticos é que correspondiam a HSA por rotura de Aneurisma cerebral. Foram excluídos da análise um total de 24 doentes, porque tratava-se de doentes com HSA não aneurismáticas e doentes com re-internamentos por outra situação clínica.

Foram auditados todos os 69 processos e a análise é apresentada por semestre, para poder ser comparativa.

Assinado por: **António José Pereira Pais Martins**

Num. de Identificação: BI04475691

Data: 2024.11.13 10:21:16 Hora padrão de GMT

Edição	Aprovação	Proxima auditoria	Página
1ª	09/2024 Dr. Pais Martins	01/2025	1/6

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA
Processo Assistencial da HSA por rotura de Aneurisma Cerebral
Auditoria Interna

Assim, por semestre foram auditados no:

- 1º Período: 25 processos clínicos,
- 2º Período: 18 processos clínico,
- 3º Período: 26 processos clínicos.

Dos processos auditados:

- 1º Período: 56% dos doentes eram do sexo masculino, com uma média de idades de 62 anos e taxa de mortalidade de 16%.
- 2º Período: 56% dos doentes eram do sexo masculino, com uma média de idades de 63 anos e taxa de mortalidade de 6%.
- 3ª Período: 42% dos doentes eram do sexo masculino, com uma média de idades de 56 ano e taxa de mortalidade de 8%.

Motivo:

Esta foi uma auditoria integrada no plano de auditorias internas, de avaliação de indicadores de qualidade do Processo assistencial da HSA por rotura de Aneurisma Cerebral, com o objetivo de proporcionar uma melhoria nos cuidados prestados aos doentes admitidos no SMI com esta patologia.

Foi realizada uma análise comparativa entre semestre, com os valores obtidos na auditoria, para comparar cada semestre às metas definidas por indicador de qualidade.

Pretende-se assim avaliar áreas de melhoria a serem integradas num processo contínuo de desenvolvimento, aperfeiçoamento e crescimento do SMI.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 1	09/2024	01/2025	2/6

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA

Processo Assistencial da HSA por rotura de Aneurisma Cerebral

Auditoria Interna

Resultados:

INDICADORES DE		META	2023				2024	
QUALIDADE			1º	Desvio	2º	Desvio	1º	Desvio
		Semestre	da meta	Semestre	da meta	Semestre	da meta	
1	Registo, na nota de admissão da UCI da Escala Fisher	≥75%	16%	-59%	33%	-42%	27%	-48%
2	Nos doentes sem sedação, avaliação funcional com recurso à escala de GCS	≥ 90%	100%	+10%	100%	+10%	100%	+10%
3	Avaliação pupilar (tamanho e foto reatividade),	≥ 90%	83%	-7%	75%	-15%	73%	-17%
4	Entubação orotraqueal para proteção da via aérea no doente com GCS ≤8	≥ 90%	92%	+2%	100%	+10%	88%	-2%
5	Início de nimodipina via entérica em todos os doentes com aHSA.	≥ 90%	91%	+1%	94%	+4%	100%	+10%
6	Realização de TC-CE nas 24 horas após o tratamento do aneurisma	≥ 90%	100%	+10%	86%	-4%	100%	+10%
7	Realização de TC-CE sempre que haja suspeita de complicação.	≥ 75%	100%	+ 25%	83%	+8%	100%	+25%
8	Realização de TC-CE pelo menos 1 vez/semana após a primeira TC-CE de reavaliação	≥ 75%	90%	+15%	89%	+14%	92%	+17%
9	Monitorização com BIS ou NIRS em doente com aHSA sob sedação e curarização contínua	≥ 75%	50%	-15%	NA	NA	NA	NA
10	PAS alvo <160mmHG em doentes sem tratamento de aneurisma	≥ 90%	100%	+10%	100%	+10%	100%	+10%
11	Iniciação de terapêutica com levetiracetam em doentes com evidência prévia de crise convulsiva ou necessidade de regime profilático perante elevado risco para atividade epiléptica	≥ 90%	92%	+2%	72%	-18%	96%	+6%
12	Realização de DTC para rastreio de vasospasmo em doentes sob sedação (sem possibilidade de avaliação neurológica)	≥ 60%	54%	-6%	75%	+15%	55%	-5%
13	Início de suporte vasopressor com noradrenalina em doentes com necessidade de estratégia hipertensiva perante evidência de vasospasmo	≥ 75%	100%	+25%	100%	+25%	100%	+25%
14	Vigilância da natremia e registo do mesmo em diário clínico	≥ 70%	100%	+30%	67%	-3%	68%	-2%

Edição		Próxima edição	Página
Nº 1	09/2024	01/2025	3/6

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA

Processo Assistencial da HSA por rotura de Aneurisma Cerebral

Auditoria Interna

15	Profilaxia mecânica de TEV com meias de compressão (incluindo de compressão mecânica intermitente)	≥ 90%	50%	-40%	33%	-57%	71%	-19%
16	Profilaxia farmacológica de TEV com HBPM nos doentes com aneurisma tratado	≥ 75%	15%	-60%	30%	-45%	13%	-62%
17	Medicação antiagregante segundo indicação da NRI no contexto de colocação de stent	≥ 90%	100%	+ 10%	100%	+10%	100%	+10%
18	Profilaxia farmacológica de úlcera de stress	≥ 95%	96%	+1%	83%	-8%	100%	+10%
19	Elevação da cabeceira a 30º com cabeça centrada na linha média	≥ 90%	100%	+10%	100%	+10%	100%	+10%

Análise dos dados colhidos:

De uma forma global verificou-se que nos 3 semestres analisados, os resultados observados estão de acordo com as objetivos/metast definidos, traduzindo a vasta experiência do Serviço de Medicina Intensiva, no tratamento destes doentes, nomeadamente da Unidade de Cuidados Intensivos dedicada ao doente neurocrítico.

Nesta análise salienta-se um contraste entre resultados muito favoráveis (com desvios da meta positivos, acima de 10%) e os resultados com desvios negativos.

Foi consensual, nos três semestres analisados, que os indicadores com resultados mais desfavoráveis e um desvio negativo acima dos 10%, foram:

- Registo, na nota de admissão da UCI, da gravidade clínica e prognóstico associados com a Escala Fisher,
- Avaliação pupilar (tamanho e foto reatividade),
- Profilaxia mecânica de TEV com meias de compressão (incluindo de compressão mecânica intermitente),
- Profilaxia farmacológica de TEV com HBPM nos doentes com aneurisma tratado.

Estas são áreas em que é possível melhorar, destacando-se como de primordial importância não só a sensibilização dos profissionais para a importância de registo de forma a minimizar a perda de informação médica que permite auxiliar determinadas decisões e orientações médicas.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 1	09/2024	01/2025	4/6

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA

Processo Assistencial da HSA por rotura de Aneurisma Cerebral

Auditoria Interna

Não existiram doentes no 2º Semestre de 2023 e 1º Semestre de 2024 com indicação para monitorização com BIS, pelo que os resultados foram não aplicáveis (NA).

Os restantes indicadores com desvios negativos, foram situações limitadas a um semestre e com desvios inferiores a 10%, nomeadamente:

- Realização de DTC para rastreio de vasospasmo em doentes sob sedação (sem possibilidade de avaliação neurológica),
- Vigilância da natremia e registo do mesmo em diário clínico
- Profilaxia farmacológica de úlcera de stress

Na comparação do ano 2023 com o 1º Semestre de 2024, verificou-se uma melhoria dos registos nos processos do doente e documentaram-se muito menos desvios negativos em relação às metas definidas.

Limitações

À parte das falhas do registo clínico e que torna o processo de auditoria árduo, não se verificaram grandes limitações nesta auditoria.

Áreas de melhoria:

A maioria dos indicadores de qualidade encontram-se dentro dos objetivos definidos, salientando-se o facto de se ter conseguido manter um bom nível de cuidados. No entanto, é necessário melhorar o preenchimento do registo clínico, nomeadamente na admissão da classificação FISHER e na avaliação neurológica.

Vai ser proposto à equipa responsável pela plataforma PATIENT-CARE ICU a introdução Checklist que vai servir de auxiliar de memória que vai permitir minimizar algumas das falhas no registo clínico.

A apresentação deste Processo Assistencial no Serviço permitiu sensibilizar os profissionais para a otimização dos registos clínicos relativamente a avaliação de prognóstica na admissão destes doentes e na avaliação neurológica. Um registo clínico incompleto, pode prejudicar a continuação da prestação de cuidados e a própria comunicação entre profissionais. O registo clínico é a única forma de garantir que o médico esteve presente, que observou o doente e que lhe prestou cuidados.

Deve, portanto, ficar sempre registado em processo clínico a razão por que o doente não se encontra sob profilaxia mecânica ou medicamentosa para TEV.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 1	09/2024	01/2025	5/6

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA
Processo Assistencial da HSA por rotura de Aneurisma Cerebral
Auditoria Interna

Esta auditoria reforça a importância de haver indicadores que monitorizem e avaliem todo processo de abordagem do doente admitido em Unidade de Cuidados Intensivos por HSA secundário a rotura de aneurisma. Permite identificar áreas de melhorias e contribuir para a qualidade e segurança nos cuidados prestados.

Próxima Auditoria

Agendamento: A próxima auditoria será agendada dentro de 6 meses, com uma periodicidade anual de 6 meses.

Método: o método utilizado será o mesmo.

Objetivos propostos: A meta será cumprir os objetivos definidos na elaboração do Processo Assistencial

Edição		Próxima edição	Página
Nº 1	09/2024	01/2025	6/6

Auditoria a Processo Assistencial

Serviço de Medicina Intensiva

2023/2024



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
LISBOA OCIDENTAL

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA
Processo Assistencial Sépsis e Choque Séptico
Auditoria Interna

Serviço auditado: Serviço de Medicina Intensiva (SMI)

Local: Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental (ULSLO)

Data: 30/10/2024

Responsável de Auditoria: Dra. Cláudia Martins, Dra. Rebelo

Universo:

Processos clínicos de doentes internados no Serviço de Medicina Intensiva nos seguintes 3 períodos (semestrais):

- 1) 1 de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2023 (1º Período)
- 2) 1 de julho de 2023 a 31 de dezembro de 2023 (2º Período)
- 3) 1 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024 (3º Período)

Método:

Análise retrospectiva dos dados relativos aos indicadores de qualidade para o Processo Assistencial da sépsis/choque séptico.

Os resultados foram obtidos do processo informático utilizado no Serviço de Medicina Intensiva (Patient Care-ICU), dos doentes com diagnóstico de admissão/diagnóstico associado/ diagnóstico de alta de sépsis grave/choque séptico. O período de análises considerado foi de 1 de janeiro de 2023 e 30 de junho de 2024. Um total de 248 processos clínicos foram elegíveis para auditoria com base no diagnóstico de sépsis grave/choque séptico. Neste número estão incluídos 2 processos com o diagnóstico de sepsis estafilocócica/estreptocócica. Foram auditados todos os 64 processos e a análise é apresentada por semestre, para poder ser comparativa.

Assim, por semestre foram auditados no:

- 1º Período: 22 processos clínicos, que corresponde a cerca de 30% dos doentes
- 2º Período: 20 processos clínicos, que corresponde a cerca de 24% dos doentes
- 3º Período: 22 processos clínicos, que corresponde a cerca de 24% dos doentes

Edição		Próxima auditoria	Página
1ª	09/2024	01/2025	1/5

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA

Processo Assistencial da Sépsis e Choque Séptico

Auditoria Interna

Dos processos auditados:

- 1º Período: 40,9% dos doentes eram do sexo masculino, com uma média de idades de 71 anos e taxa de mortalidade de 54%.
- 2º Período: 55% dos doentes eram do sexo masculino, com uma média de idades de 70 anos e taxa de mortalidade de 60%.
- 3ª Período: 50% dos doentes eram do sexo masculino, com uma média de idades de 69 anos e taxa de mortalidade de 45%.

Motivo:

Esta foi uma auditoria integrada no plano de auditorias internas, de avaliação de indicadores de qualidade do Procedimento Assistencial da Sépsis/ Choque séptico, com o objetivo de proporcionar uma melhoria nos cuidados prestados aos doentes admitidos no SMI com esta patologia.

Foi realizada uma análise comparativa entre semestres, com os valores obtidos na auditoria, para avaliar a melhoria das metas definidas por indicador de qualidade.

Pretende-se assim avaliar áreas de melhoria a serem integradas num processo contínuo de desenvolvimento, aperfeiçoamento e crescimento do SMI.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 1	09/2024	01/2025	2/6

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	
Processo Assistencial da Sépsis e Choque Séptico	
Auditoria Interna	

Resultados:

Indicador a implementar	Objetivo %	1º semestre 2023	2º semestre 2023	1º semestre 2024	Desvio da meta em 2024
Doentes com sépsis/choque séptico que colhem produtos biológicos na primeira hora de admissão na UCI (se não realizado previamente);	>90%	86%	84,2%	100%	+10%
Doentes com sépsis/choque séptico com controlo de foco nas primeiras 6h;	>80%	45,4%	44,4%	67,5%	-12,5%
Doentes com sépsis/choque séptico que têm avaliação de lactato sérico na primeira hora após admissão na UCI;	>90%	68,2%	75%	72,7%	-17,3%
Doentes com sépsis/choque séptico que têm reavaliação do lactato sérico após 2h de instituição terapêutica;	>90%	57,1%	55%	66,7%	-23,3%
Doentes com sépsis/choque séptico que recebem cristalóides como fluido de ressuscitação;	>90%	100%	94,4%	80,9%	-9,1%
Doentes com sépsis/choque séptico cuja antibioterapia é iniciada na primeira hora, inicialmente de largo espectro	>80%	90%	95%	95,5%	+15,5%
Doentes com sépsis/choque séptico cujo suporte vasopressor inicial é a noradrenalina, se mantiverem hipotensão após fluidoterapia;	>90%	100%	100%	100%	+10%
Doentes com sépsis/choque séptico com administração de vasopressores via cateter central;	>90%	95,5%	100%	100%	+10%
Doentes com sépsis/ choque séptico sob suporte vasopressor com monitorização invasiva de pressão arterial via cateter arterial;	>90%	100%	100%	100%	+10%

Edição		Próxima edição	Página
Nº 1	09/2024	01/2025	3/6

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA

Processo Assistencial da Sepsis e Choque Séptico

Auditoria Interna

Análise dos dados colhidos:

Na análise do 1º Semestre de 2023 verificou-se que os indicadores com maior desvio da meta/objetivo definido foram:

- Doentes com sepsis/choque séptico com controlo de foco nas primeiras 6h, cujo objectivo seria situar-se acima dos 80% e cujo resultado se situou nos 45,5%. (desvio de 34,5% abaixo da meta).
- Doentes com sepsis/choque séptico que têm reavaliação do lactato sérico após 2h de instituição terapêutica e cujo resultado se situou nos 57,1% para uma meta definida acima dos 90% (desvio de 32,9% abaixo da meta).
- Doentes com sepsis/choque séptico que têm avaliação de lactato sérico na primeira hora após admissão na UCI, cuja meta era acima dos 90% e que na auditoria se situou nos 68,2%, 21,8% abaixo da meta.
- Doentes com sepsis/choque séptico que colhem produtos biológicos na primeira hora de admissão na UCI (se não realizado previamente), cujo objetivo seria situar-se acima dos 90% e cujo resultado se situou nos 86%, desvio de 4% abaixo da meta.

Na análise do 2º semestre de 2023 a grande maioria dos indicadores foram cumpridos dentro dos objetivos definidos no Processo Assistencial. Como desvios negativos na avaliação do 2º semestre de 2023, temos a salientar:

- Doentes com sepsis/choque séptico com controlo de foco nas primeiras 6h, cujo objetivo seria situar-se acima dos 80% e cujo resultado se situou nos 44,4%. (desvio de 35,6% abaixo da meta)
- Doentes com sepsis/choque séptico que têm reavaliação do lactato sérico após 2h de instituição terapêutica e cujo resultado se situou nos 55% para uma meta definida acima dos 90% (desvio de 35% abaixo da meta).

Apesar de ainda existir um desvio negativo relativamente à meta estabelecida existiu uma melhoria no cumprimento do indicador “Doentes com sepsis/choque séptico que têm avaliação de lactato sérico na primeira hora após admissão na UCI” com uma taxa de cumprimento de 75%..

Edição		Próxima edição	Página
Nº 1	09/2024	01/2025	4/6

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA	
Processo Assistencial da Sepsis e Choque Séptico	
Auditoria Interna	

Assim, em 2023, como indicadores com maior desvio nas metas definidas (desvio de >20%) está o controlo de foco nas primeiras 6h e a avaliação de lactato sérico na primeira hora após admissão em UCI e a sua reavaliação 2h após a instituição de terapêutica.

Comparativamente, no 1º Semestre de 2024, verificou-se uma melhoria na colheita de produtos biológicos na primeira hora de admissão na UCI (se não realizado previamente), que situou em 10% acima da meta estabelecida. A salientar como desvios negativos no 1º semestre de 2024:

- Doentes com sepsis/choque séptico com controlo de foco nas primeiras 6h.
- Doentes com sepsis/choque séptico que têm avaliação de lactato sérico na primeira hora após admissão na UCI.
- Doentes com sepsis/choque séptico que têm reavaliação do lactato sérico após 2h de instituição terapêutica.
- Doentes com sepsis/choque séptico que recebem cristalóides como fluido de ressuscitação.

Limitações

Uma das maiores limitações desta auditoria relaciona-se com a própria seleção dos processos a serem auditados. Apesar de existir o diagnóstico de sepsis grave/choque séptico no sistema informático utilizado no SMI (Patient Care) existem também outros diagnósticos como sepsis por E. Coli ou S. pneumoniae que podem ser fator confundidor.

Apesar do fator tempo ser fundamental na bundle da sepsis/choque séptico e terem sido considerados indicadores em que este fator é fundamental, torna-se extremamente difícil a auditoria dos processos por ausência de registos relativamente a horários considerados.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 1	09/2024	01/2025	5/6

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA
Processo Assistencial da Sépsis e Choque Séptico
Auditoria Interna

Áreas de melhoria:

A grande maioria dos indicadores encontram-se dentro dos objetivos definidos. No entanto, é necessário melhorar o preenchimento do registo clínico, nomeadamente a hora zero do choque séptico, do controlo do foco e colheita de produtos.

A apresentação deste Processo Assistencial no Serviço permitiu sensibilizar os profissionais para a otimização dos seus registos.

Esta auditoria reforça a importância de haver indicadores que monitorizem e avaliem o processo assistencial da sépsis/choque séptico a fim de identificar processos de melhoria, nomeadamente na abordagem precoce e terapêutica adequada destes doentes.

Próxima Auditoria

Agendamento: A próxima auditoria será agendada dentro de 6 meses, com uma periodicidade anual de 6 meses.

Método: o método utilizado será o mesmo.

Objetivos propostos: A meta será cumprir os objetivos definidos na elaboração do Processo Assistencial

Edição		Próxima edição	Página
Nº 1	09/2024	01/2025	6/6

Auditoria a Processo Assistencial

Serviço de Medicina Intensiva

2023/2024



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
LISBOA OCIDENTAL

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA
Processo Assistencial da Transfusão Maciça
Auditoria Interna

Serviço auditado: Serviço de Medicina Intensiva (SMI)

Local: Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental (ULSLO)

Data: 30/10/2024

Responsável de Auditoria: Dra. Marta Rebelo, Dra, Ana Rita Barradas

Universo:

Processos clínicos de doentes internados no Serviço de Medicina Intensiva nos seguintes 3 períodos (semestrais):

- 1) 1 de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2023 (1º Período)
- 2) 1 de julho de 2023 a 31 de dezembro de 2023 (2º Período)
- 3) 1 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024 (3º Período)

Método:

Análise retrospectiva dos dados relativos aos indicadores de qualidade para o Processo Assistencial (PA) da Transfusão Maciça. Os indicadores selecionados para este PA foram retirados da Norma da DGS 011/2013 atualizada a 18/07/2017 (Abordagem da Transfusão Maciça do Adulto).

Os resultados foram obtidos do processo informático utilizado no Serviço de Medicina Intensiva (PATIENTCARE-ICU), dos doentes com diagnóstico de admissão/diagnóstico associado/ diagnóstico de alta de Choque hipovolémico. O período de análises considerado foi de 1 de janeiro de 2023 e 30 de junho de 2024.

Um total de 112 processos clínicos foram elegíveis para auditoria com base no diagnóstico de Choque Hipovolémico, mas só 56 desses diagnósticos é que correspondiam a choque hemorrágico submetido a protocolo de transfusão maciça [cumpriram um mínimo de 4 Unidades de Concentrado Eritrocitário (UCE) nas primeiras 24h de Choque Hemorrágico]. Foram auditados todos os 56 processos e a análise é apresentada por semestre, para poder ser comparativa.

Assinado por: **António José Pereira Pais Martins**
Num. de Identificação: BI04475691
Data: 2024.11.13 10:22:12 Hora padrão de GMT



Edição		Aprovação	Próxima auditoria	Página
1ª	09/2024	Dr. Pais Martins	01/2025	1/5

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA
Processo Assistencial da Transfusão Maciça
Auditoria Interna

Assim, por semestre foram auditados no:

- 1º Período: 11 processos clínicos,
- 2º Período: 24 processos clínico,
- 3º Período: 21 processos clínicos.

Dos processos auditados:

- 1º Período: 55% dos doentes eram do sexo masculino, com uma média de idades de 73 anos e taxa de mortalidade de 45%.
- 2º Período: 67% dos doentes eram do sexo masculino, com uma média de idades de 61 anos e taxa de mortalidade de 32%.
- 3ª Período: 38% dos doentes eram do sexo masculino, com uma média de idades de 69 anos e taxa de mortalidade de 19%.

Motivo:

Esta foi uma auditoria integrada no plano de auditorias internas, de avaliação de indicadores de qualidade do Processo assistencial da Transfusão Maciça, com o objetivo de proporcionar uma melhoria nos cuidados prestados aos doentes admitidos no SMI com esta patologia.

Foi realizada uma análise comparativa entre semestre, com os valores obtidos na auditoria, para avaliar a melhoria das metas definidas por indicador de qualidade.

Pretende-se assim avaliar áreas de melhoria a serem integradas num processo contínuo de desenvolvimento, aperfeiçoamento e crescimento do SMI.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 1	09/2024	01/2025	2/6

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA
Processo Assistencial da Transusão Maciça
Auditoria Interna

Resultados:

INDICADORES DE QUALIDADE	META	2023				2024	
		1º Semestre	Desvio da meta	2º Semestre	Desvio da meta	1º Semestre	Desvio da meta
Registo contacto do Serviço IHT	≥ 90%	73%	-17%	75%	-15%	100%	+ 10%
Dispensa de 2 CE em 15 min	≥ 60%	64%	+4%	38%	-22%	48%	-12%
Registo de alvo de Hb: 7-9 g/dL	≥ 70%	64%	-6%	71%	+1%	90%	+20%
Hemoderivados administrados com protocolo 4+4+1 em 24h ou ROTEM	≥ 70%	36%	-34%	75%	+5%	65%	-5%
Administração inicial de fibrinogénio	≥ 70%	55%	-15%	75%	+5%	75%	+5%
Administração de antifibrinolítico	≥ 70%	67%	-3%	38%	-42%	83%	+13%
Reversão da anticoagulação com idarucizumab ou andexanet alfa	≥ 60%	100%	+40%	38%	-22%	67%	+7%
Reposição de volémia	≥ 90%	64%	-26%	71%	-29%	100%	+10%
Avaliação PaO2 (< 60 mmHg)	≥ 70%	100%	+ 30%	96%	+ 26%	100%	+30%
Registo de SvO2 (<65mmHg)	≥ 60%	0%	-60%	0%	-60%	10%	-50%
Avaliação pH (<7.2)	≥ 70%	100%	+30%	100%	+ 30%	100%	+ 30%
Avaliação BE (>-6)	≥ 70%	100%	+30%	100%	+30%	100%	+30%
Registo Lactato	≥ 70%	100%	+30%	100%	+30%	100%	+30%
Registo de Cálcio ionizado (< 1,1mmol/L ou 4.6 mg/dL)	≥ 70%	64%	-6%	83%	+13%	95%	+25%
Registo PlaQ (< 50.000/mL)	≥ 70%	82%	+12%	96%	+ 26%	100%	+30%
Registo PT (> 1,5x normal)	≥ 70%	82%	+12%	88%	+18%	100%	+30%
Registo de aPTT (> 1,5x normal)	≥ 70%	64%	-6%	88%	+18%	100%	+30%
Registo Fibrinogénio (< 1,5g/L)	≥ 70%	64%	-6%	88%	+18%	100%	+30%
Correção iónica	≥ 85%	73%	-12%	75%	-10%	100%	+30%

Edição		Próxima edição	Página
Nº 1	09/2024	01/2025	3/6

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA**Processo Assistencial da Transfusão Maciça****Auditoria Interna****Análise dos dados colhidos:**

Na análise do 1º Semestre de 2023 verificou-se que os indicadores com maior desvio da meta/objetivo definido foram:

- Registo de contacto com o serviço de imunohemoterapia (-5%);
- Registo de Hb alvo (-6%);
- Administração de Hemoderivados de acordo com protocolo 4 +4 +1 ou guiado por ROTEM (-34%);
- Administração inicial de fibrinogénio (-15%)
- Administração de antifibrinolítico (-3%),
- Reversão da anticoagulação (-22%),
- Reposição volémica (-26%),
- Registo de cálcio ionizado (< 1,1mmol/L ou 4.6 mg/dL) (-6%)
- Correção iónica (-12%)
- Registo de SVO2(-60%).

Na análise do 2º semestre de 2023 a grande maioria dos indicadores foram cumpridos dentro dos objetivos definidos no Processo Assistencial. Como desvios negativos na avaliação do 2º semestre de 2023, temos a salientar:

- Dispensa de 2 CE em 15 minutos (-22%),
- Administração de antifibrinolítico (-42%),
- Reversão da anticoagulação (-22%),
- Reposição volémica (-29%),
- Correção iónica (-10%)
- Registo de SVO2(-60%).

Assim, em 2023, como indicadores com maior desvio nas metas definidas (desvio de >20%) está a dispensa de 2 UCE em 15 minutos, a administração de antifibrinolítico, a reposição volémica, a reversão da anticoagulação e o registo de SvO2.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 1	09/2024	01/2025	4/6

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA			
Processo Assistencial da Transfusão Maciça			
Auditoria Interna			

Comparativamente com o 1º Semestre de 2024, verificou-se uma melhoria dos registos nos processos do doente e documentaram-se muito menos desvios negativos em relação às metas definidas.

A salientar como desvios negativos no 1º semestre de 2024:

- Dispensa de 2 CE em 15 minutos (-22%),
- Administração dos componentes sanguíneos de acordo com ROTEM ou 4+4+1 (-5%)
- Registo de SVO2(-60%).

A dispensa de 2 UCEs é um importante indicador de qualidade, pois atrasos nas transfusões continuam a contribuir para a desfechos fatais nos doentes. O registo do tempo em que é dispensada a 1ª UCE, após contacto com o Serviço de ImunoHemoterapia, continua a falhar no registo do processo clínico e na apresentação dos resultados da auditoria interna, pois são muito difíceis de monitorizar os 15 minutos recomendados.

Após apresentação destes resultados em reunião no SMI, considerámos que o indicador contacto com o Serviço de Imunohemoterapia é um indicador redundante, visto que a dispensa de Hemoderivados pressupõe o contacto com esse serviço, pelo que nas próximas auditorias não será tido considerado como indicador para auditar.

O registo do SvO2 como indicador hemodinâmico de resposta à ressuscitação volémica continua a faltar.

Na apresentação desta auditoria, foram sensibilizados os profissionais para otimização desse registo

Ao contrário do que se passou em 2023, no 1º Semestre de 2024, verificou-se que nos doentes sob anticoagulação e em choque hemorrágico foi realizada a reversão da mesma em 100% dos processos auditados.

Limitações

Uma das maiores limitações desta auditoria relaciona-se com a própria seleção dos processos a serem auditados. Não existe na plataforma de registo da PATIENTCARE-ICU o diagnóstico de Choque hemorrágico, pelo que o diagnóstico mais próximo é o Choque Hipovolémico e a partir daí há necessidade de rever todos os processos e identificar os doentes elegíveis para auditoria. Também não existe, na mesma plataforma da PATIENTCARE-ICU, uma forma de registo do resultado das alterações apresentadas no ROTEM. Dessa forma é difícil, na auditoria a estes processos, perceber se a administração de antifibrinolíticos ocorreu porque a análise ROTEM revelava ativação da fibrinólise.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 1	09/2024	01/2025	5/6

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA			
Processo Assistencial da Transfusão Maciça			
Auditoria Interna			

Apesar destas limitações, salienta-se uma boa resposta, no geral, a estes doentes admitidos por choque hipovolémico com necessidade de suporte transfusional maciço, verificando-se, em termos de atividade clínica, uma redução progressiva na mortalidade do 1º Semestre de 2023 ao 1º Semestre de 2024.

Áreas de melhoria:

A grande maioria dos indicadores encontram-se dentro dos objetivos definidos. No entanto, é necessário melhorar o preenchimento do registo clínico, nomeadamente na dispensa de CE, no registo de SvO2 e administração de antifibrinolíticos.

Vai ser realizada uma Checklist na plataforma da PATIENTCARE relativa ao Choque Hipovolémico que vai permitir selecionar os doentes em Choque Hemorrágico e elegíveis para auditoria do Processo Assistencial da Transfusão Maciça.

A apresentação deste PA no Serviço permitiu sensibilizar os profissionais para a otimização dos seus registos.

Esta auditoria reforça a importância de haver indicadores que monitorizem e avaliem o processo transfusional a fim de identificar os riscos relativos a esta terapêutica, as melhorias que podem ser realizadas, e contribuir para a qualidade e segurança transfusional.

Próxima Auditoria

Agendamento: A próxima auditoria será agendada dentro de 6 meses, com uma periodicidade anual de 6 meses.

Método: o método utilizado será o mesmo.

Objetivos propostos: A meta será cumprir os objetivos definidos na elaboração do Processo Assistencial

Edição		Próxima edição	Página
Nº 1	09/2024	01/2025	6/6

Auditoria a Processo clínico do doente

Serviço de Medicina Intensiva

2023/2024



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
LISBOA OCIDENTAL

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA
Processo clínico do doente
Auditoria Interna

Serviço auditado: Serviço de Medicina Intensiva (SMI)

Local: Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental (ULSLO)

Data: 30/10/2024

Responsável de Auditoria: Dra. Marta Rebelo, Dr. David Nora

Universo:

Processos clínicos de doentes internados no SMI nos seguintes 3 períodos (semestrais):

- 1) 1 de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2023 (1º Período)
- 2) 1 de julho de 2023 a 31 de dezembro de 2023 (2º Período)
- 3) 1 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024 (3º Período)

Método:

Análise retrospectiva dos dados relativos aos indicadores de qualidade para o Processo Clínico único do doente.

Os resultados foram obtidos do processo informático utilizado no Serviço de Medicina Intensiva (PATIENTCARE-ICU), dos doentes internados de 1 de janeiro de 2023 e 30 de junho de 2024.

Um total de [1402 (ano 2023) + 750 (1º Semestre de 2024)] 2152 processos clínicos foram elegíveis para auditoria. Deste total, foram auditados 488 (22.7%) processos clínicos, tendo sido considerada uma amostra significativa.

A análise é apresentada por semestre para poder ser comparativa entre semestres e porque o compromisso do SMI era avaliar semestralmente os resultados da auditoria ao Processo Clínico do doente.

Assim, por semestre foram auditados no:

- 1º Período: 153 processos clínicos (UCI-1: 38, UCI-2: 37, UCI-3: 39, UCI-4: 39)
- 2º Período: 150 processos clínico (UCI-1: 53, UCI-2: 34, UCI-3: 32, UCI-4: 31)
- 3º Período: 185 processos clínicos (UCI-1: 48, UCI-2: 44, UCI-3: 47, UCI-4: 46)

Assinado por : **António José Pereira Pais Martins**
Num. de Identificação: BI04475691
Data: 2024.11.13 10:22:52 Hora padrão de GMT



Edição		Aprovação	Próxima auditoria	Página
1ª	09/2024	Dr. Pais Martins	01/2025	1/6

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA
Processo clínico do doente
Auditoria Interna

Dos processos auditados:

- 1º Período: 53.4% dos doentes eram do sexo masculino, com uma média de idades de 62 anos e taxa de mortalidade de 14.4%.
- 2º Período: 60% dos doentes eram do sexo masculino, com uma média de idades de 63 anos e taxa de mortalidade de 11.3%.
- 3ª Período: 52.4% dos doentes eram do sexo masculino, com uma média de idades de 63 ano e taxa de mortalidade de 17.8%.

Motivo:

Esta foi uma auditoria integrada no plano de auditorias internas de avaliação de indicadores de qualidade do Processo Clínico do doente, com o objetivo de desenvolver intervenções que visem a melhoria da qualidade dos cuidados prestados.

Foi realizada uma análise comparativa entre semestres com os valores obtidos na auditoria para comparar cada semestre às metas definidas por indicador de qualidade.

Pretende-se assim avaliar áreas de melhoria a serem integradas num processo contínuo de desenvolvimento, aperfeiçoamento e crescimento do SMI.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 1	09/2024	01/2025	2/7

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA
Processo clínico do doente
Auditoria Interna

Resultados:

INDICADORES DE		META	2023				2024	
QUALIDADE			1º	Desvio	2º	Desvio	1º	Desvio
			Semestre	da meta	Semestre	da meta		
1	Identificação completa do utente (nome, apelido, morada, contacto, nº utente, etc.)	95%	100%	+5%	100%	+5%	100%	+5%
2	Alergias (registo na plataforma PatientCare, mesmo em caso de não haver alergias)	95%	96%	+1%	95%	+5%	99%	+4%
3	Anamnese e exame físico	95%	99%	+4%	100%	+5%	99%	+4%
4	Referência no processo clínico da terapêutica de ambulatório	90%	92%	+2%	93%	+3%	98%	+8%
5	Descrição de familiar de referência	90%	97%	+7%	100%	+10%	96%	+6%
6	Confirmação de existência de Testamento Vital	80%	27%	-53%	25%	-35%	58%	-22%
7	Registo de acesso/resultados exames complementares de diagnóstico	90%	100%	+10%	100%	+10%	100%	+10%
8	Consentimento Informado digitalizado no PU	80%	NA	NA	NA	NA	90%	+10%
9	Existência de prescrição analgesia eficaz	90%	98%	+8%	96%	+6%	99%	+9%
10	Nível de sedação (quando aplicável)	90%	100%	+10%	98%	+8%	99%	+9%
11	Prevenção (farmacológica ou mecânica) de tromboembolismo venoso	90%	100%	+10%	94%	+4%	94%	+4%
12	Cabeceira elevada a 30º em doentes ventilados	95%	100%	+5%	100%	+5%	94%	-1%
13	Prevenção de úlcera de stress	90%	96%	+6%	93%	+3%	95%	+5%
14	Localização de CVC	95%	99%	+4%	100%	+5%	100%	+5%
15	Plano/Reconciliação terapêutica	90%	99%	+9%	100%	+10%	99%	+9%
16	Plano de cuidados de enfermagem	95%	99%	+4%	100%	+5%	98%	+3%

Edição		Próxima edição		Página
Nº 1	09/2024		01/2025	3/7

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA

Processo clínico do doente

Auditoria Interna

17	Plano terapêutico à data de alta	90%	99%	+9%	98%	+8%	89%	-1%
18	Nota de Alta da Unidade de Cuidados Intensivos do Serviço de Medicina Intensiva	95%	99%	+4%	96%	+1%	99%	+4%

Análise dos dados colhidos:

De uma forma global, verificou-se que, nos 3 semestres analisados, os resultados observados estão de acordo com as objetivos/metast definidos, traduzindo a vasta experiência do Serviço de Medicina Intensiva no tratamento do doente crítico com padrões elevados de qualidade e segurança.

Nesta análise salienta-se um contraste entre resultados favoráveis (com desvios da meta positivos, acima de 5%) e o resultado com desvio significativamente negativo, que foram os indicadores:

- Confirmação da existência de testamento vital em processo clínico
- Confirmação da existência de um consentimento informado digitalizado

No entanto, tem-se verificado uma melhoria, ao longo dos semestres, no Indicador Confirmação de Existência de Testamento Vital, o que reflete uma preocupação crescente dos profissionais com os direitos do doente e as diretivas antecipadas de vontade.

Limitações

Para a realização desta auditoria não existe uma forma eletrónica de recolher os dados relativos às falhas de registo clínico, o que torna o processo de auditoria árduo.

Relativamente ao registo de Consentimento Informado, a grande maioria dos doentes admitidos é de nível III de gravidade, encontram-se inconscientes e/ou há risco sério para a saúde ou vida da pessoa em se adiar o ato para a obtenção de um consentimento informado.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 1	09/2024	01/2025	4/7

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA

Processo clínico do doente

Auditoria Interna

Áreas de melhoria:

A maioria dos indicadores de qualidade encontra-se dentro dos objetivos definidos, salientando-se o facto de se ter conseguido manter um bom nível de cuidados.

No entanto, é necessário melhorar o registo das diretivas antecipadas da vontade e, por isso, foi realizada, em novembro de 2024, uma formação (presencial e via online) sobre Testamento vital para todos os médicos do SMI.

Foi proposto à equipa responsável pela plataforma PATIENTCARE ICU a introdução Checklist informatizada que aparece no registo médico diariamente. Esta Checklist serve como auxiliar de memória e permite minimizar algumas das falhas no registo clínico e ao mesmo tempo minimizar o risco de erro médico na atividade assistencial.

Relativamente ao indicador registo de Consentimento Informado digitalizado, no ano 2023 não foi aplicado, porque no SMI, a grande maioria dos doentes encontra-se em situação crítica, com falência de órgão, inconscientes e não está representada legalmente. Na grande maioria das intervenções/procedimentos realizados no SMI há risco sério para a saúde ou vida da pessoa em se adiar o ato para a obtenção do consentimento expresso. Nestas situações é aplicado o consentimento presumido, prevalecendo o dever de agir decorrente do princípio da beneficência consagrada na ética da saúde. É, no entanto, prestada toda a informação à pessoa, procurador de cuidados ou familiar de referência.

Em 2024, foi discutido no Serviço de Medicina Intensiva em que situações é que poderíamos aplicar o consentimento informado, com base no que está definido pela NORMA Nº 015/2013 da DGS. Conclui-se que as situações a aplicar seriam:

- Eletroconvulsivoterapia e intervenção psicocirúrgica, se o doente estiver capaz de compreender a informação fornecida ou tiver um representante legal;
- Videovigilância de doentes;
- Investigação em pessoas;
- Realização de atos diagnósticos ou terapêuticos invasivos major, se o doente estiver consciente e capaz de compreender a informação fornecida;
- Gravações de pessoas em fotografia ou suporte áudio ou audiovisual;
- Uso off label de medicamentos;

Edição		Próxima edição	Página
Nº 1	09/2024	01/2025	5/7

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA

Processo clínico do doente

Auditoria Interna

- Participação da pessoa em qualquer ensino clínico, e nas situações de publicação ou apresentação pública de relato de caso clínico; à exceção das situações de participação em estudos de investigação, em que o consentimento escrito pode ser dispensado sempre que fique assegurado que os dados pessoais e de saúde são irreversivelmente anonimizados e sempre que esteja garantido a não realização de procedimentos não úteis para o diagnóstico, tratamento ou prognóstico

O registo clínico é a única forma de garantir que o médico esteve presente, que observou o doente e que lhe prestou cuidados. O processo de informação e consentimento informado deve ficar registado e fundamentado no processo clínico.

Nos doentes em que o pós-operatório da atividade cirúrgica eletiva obrigue a permanência em UCI, deve ficar registado, em processo clínico, a existência ou não de um consentimento digitalizado. Não fica à responsabilidade do profissional que recebe o doente de uma cirurgia eletiva confirmar se o consentimento informado seguiu as recomendações da NORMA Nº 015/2013 da DGS.

A apresentação deste Processo Assistencial no Serviço permitiu sensibilizar os profissionais para a otimização dos registos clínicos relativamente às diretivas antecipadas da vontade.

Esta auditoria reforça a importância de haver indicadores que monitorizem e avaliem todo processo de abordagem do doente admitido em Unidade de Cuidados Intensivos. Permite identificar áreas de melhorias e contribuir para a qualidade e segurança nos cuidados prestados.

Pretende-se promover a melhoria contínua para o desenvolvimento da excelência nos cuidados clínicos através de elevados padrões de qualidade e segurança centrados no doente, e onde a excelência no cuidar seja um compromisso de todos.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 1	09/2024	01/2025	6/7

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA
Processo clínico do doente
Auditoria Interna

Próxima Auditoria

Agendamento: A próxima auditoria será agendada dentro de 6 meses, com uma periodicidade anual de 6 meses.

Método: o método utilizado será o mesmo.

Objetivos propostos: A meta será cumprir os objetivos definidos na elaboração do Processo Assistencial

Edição		Próxima edição	Página
Nº 1	09/2024	01/2025	7/7

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA**Programa de Formação em Medicina Intensiva****Programa de Formação Especializada em Medicina Intensiva**

A formação especializada em Medicina Intensiva tem a duração de 60 meses e é antecedida por uma formação genérica, partilhada por todas as especialidades, designada por Ano Comum.

Assim o seu programa de formação está adequadamente regulamentado na portaria nº103/2016.

1) Primeiro Ano:

Estágio em Medicina Interna — 12 meses — No Serviço de Medicina da ULSLO

Diretora: Professora Cândida Fonseca

Objetivos do Estágio em Medicina Interna:

(Aquisição de conhecimentos feita por integração em Serviço de Medicina Interna, sendo o estágio centrado na prestação de cuidados assistenciais em Enfermaria de Medicina Interna e Urgência de Medicina, sendo esta de frequência semanal.)

- a) Aprender a colheita de dados clínicos e a observação do doente, de forma a permitir realizar o diagnóstico diferencial, a definir orientação terapêutica e estratégia global para o doente durante o internamento;
- b) Aprender a utilidade e a hierarquização dos diferentes exames complementares de diagnóstico, selecionar os adequados a cada situação clínica e interpretar adequadamente os seus resultados;
- c) Adquirir capacidades práticas na execução das técnicas diagnósticas ou terapêuticas correntes (nomeadamente punção arterial, cateterismo venoso central e periférico, punção lombar, toracocentese e paracentese) e conhecer, diagnosticar e saber tratar as suas complicações;
- d) Otimizar oxigenoterapia por diversas técnicas;
- e) Familiarizar-se com diversas situações patológicas que habitualmente existem em ambiente de Medicina Interna, tais como:

Assinado por : **António José Pereira Pais Martins**

Num. de Identificação: 8102475691

Data: 2024.11.13 10:27:35 Hora padrão de GMT

Elaboração	Aprovação	Próxima edição
Dra. Cláudia Martins	 CHAVE MÓVEL	01/2027
		Página: 1/10

SERVIÇO DE MEDICINS INTENSIVA**Programa de Formação em Medicina Intensiva**

Patologia respiratória: insuficiência respiratória aguda e crónica, asma brônquica, doenças intersticiais pulmonares, doenças pleurais, obstrução da via aérea, patologia do sono, doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), tromboembolismo pulmonar (TEP);

Patologia cardiovascular: insuficiência cardíaca, síncope, síndrome coronário, hipertensão arterial, cor pulmonale, valvulopatias, arritmias cardíacas;

Patologia digestiva: hemorragia digestiva, doença inflamatória intestinal, patologia vascular abdominal, doenças hepatobiliares e pancreáticas;

Patologia neurológica: coma, epilepsia, acidente vascular cerebral isquémico e hemorrágico, delírio e demência, neuropatias periféricas e doenças neuromusculares;

Patologia renal: lesão renal aguda (LRA), hipertensão arterial de causa renal, doença renal crónica (DRC), alterações hidroeletrólíticas e ácido-base;

Patologia hematológica: alterações da coagulação, hemorragia aguda e política transfusional, anemia, leucocitose, leucopenia, trombocitose, trombocitopenia, terapêutica anticoagulante;

Infeções: síndrome febril, sépsis, infeções da pele e tecidos moles, do sistema nervoso central, respiratórias, endovasculares, abdominais e urinárias;

Alterações metabólicas e endocrinológicas

Intoxicações

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	12/2022	01/2027	2/10

SERVIÇO DE MEDICINS INTENSIVA**Programa de Formação em Medicina Intensiva****2) Segundo Ano:**

Estágio em Anestesiologia – 6 meses (primeiro semestre) – Serviço de Anestesiologia da ULSLO (Diretora: Dra. Paula Ribeiro)

Objetivos do Estágio em Anestesiologia:

- a) Manuseamento da via aérea (entubação de doentes com graus de dificuldade diferentes);
- b) Monitorização de doentes cirúrgicos;
- c) Abordagem/tratamento da dor aguda ou agudizada;
- d) Técnicas de anestesia geral, sedação e analgesia sistémica;
- e) Técnicas de analgesia locorregional;
- f) Acessos vasculares, cateterismos venosos centrais, periféricos e arteriais;
- g) Avaliação pré-anestésica e estratificação do risco operatório;
- h) Aspectos relacionados com as especificidades de certas valências anestésico/cirúrgicas;
- i) Cuidados pós-anestésicos.

Estágio em Medicina Intensiva – 6 meses (segundo semestre), no serviço de Medicina Intensiva da ULSLO (Diretor Dr. Pais Martins).

Objetivos do Estágio em Medicina Intensiva

Aquisição das seguintes competências básicas:

- a) Abordagem e estabilização do doente crítico;
- b) Técnicas de manuseamento da via aérea (entubação clássica e difícil);
- c) Técnicas de monitorização de funções vitais e fisiológicas;
- d) familiarização com o equipamento técnico existente;

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	12/2022	01/2027	3/10

SERVIÇO DE MEDICINS INTENSIVA**Programa de Formação em Medicina Intensiva**

- e) Técnicas de sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular;
- f) Conhecer fundamentos e cálculo de índices de gravidade;
- g) Conhecer os critérios de admissão e alta;
- h) Aprender noções de ética relacionadas com a especificidade do doente crítico, nomeadamente participação em discussões de limitação de esforço terapêutico e decisões de fim de vida;
- i) Identificar, monitorizar e tratar os diferentes tipos de choque;
- j) Adquirir competências na metodologia de suporte orgânico, com ênfase na instituição e manipulação de ventilação mecânica invasiva, ventilação não invasiva, prescrição e gestão de suporte vasopressor e inotrópico, técnicas de depuração renal (contínuas, intermitentes e diversos tipos de anticoagulação);
- k) Aprender a abordar as infeções no contexto epidemiológico, diagnóstico, terapêutico e de prevenção;
- l) Abordagem de doentes em insuficiência respiratória; contacto com técnicas de suporte ventilatório específicas como mistura de hélio e oxigénio (Heliox®), óxido nítrico (iNO), remoção extracorporeal de CO₂ (ECCO₂-R) e referenciação de doentes para ECMO.
- m) Adquirir conceitos de avaliação, prescrição e monitorização nutricional;
- n) Conhecer o circuito do doente crítico, participando nos processos de triagem e estabilização dos doentes da sala de emergência do Serviço de Urgência e dos doentes abordados pela equipa de emergência intra-hospitalar.

A partir do 2º ano os internos passarão a fazer o serviço de urgência para a sua formação e a que estão obrigados, integrando o *staff* de urgência como segundo elemento.

Embora seja admissível uma reorganização temporal dos estágios previstos para o primeiro e segundo ano, de acordo com a logística local, é obrigatório que o interno tenha completado os estágios de Medicina Interna e de Anestesiologia nos primeiros 18 meses do internato de formação especializada.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	12/2022	01/2027	4/10

SERVIÇO DE MEDICINS INTENSIVA**Programa de Formação em Medicina Intensiva****3) Terceiro e quarto ano – 24 meses**

Estágio em Medicina Intensiva - 12 meses.

Aprendizagem realizada com base num modelo de aprendizagem testado, atingindo o padrão obrigatório para um Intensivista, mediante a aquisição de diversas competências clínicas distribuídas por vários domínios. Autonomia progressiva para o exercício de medicina intensiva tutelada.

Realizado em Serviço de Medicina Intensiva com idoneidade formativa total, aprofundando as competências e capacidades já adquiridas.

Objetivos:

- a) Ressuscitação e orientação inicial do doente crítico;
- b) Diagnóstico, avaliação, investigação e interpretação de resultados de doentes médicos, pós-operatórios e traumáticos internados em Medicina Intensiva;
- c) Orientação de doentes com afeções agudas ou crónicas e de doentes em falência orgânica;
- d) Reconhecimento e orientação de doentes em falência hemodinâmica;
- e) Reconhecimento e orientação de doentes em falência respiratória aguda;
- f) Reconhecimento e orientação de doentes em falência ou pré-falência renal aguda;
- g) Reconhecimento e orientação de doentes em falência hepática ou gastrointestinal;
- h) Reconhecimento e orientação de doentes em falência neurológica;
- i) Reconhecimento e orientação de doentes com alterações graves da coagulação ou da hemostase;
- j) Reconhecimento e orientação de doentes em sépsis e choque séptico;
- k) Reconhecimento das causas e os diversos tipos de falência múltipla de órgãos, familiarizando-se com as diversas atitudes de suporte multiórgão;
- l) Reconhecimento e orientação das complicações peri e pós-parto que põem em risco a vida materna e fetal;
- m) Monitorização intensiva do doente crítico, em particular hemodinâmica, respiratória e renal;
- n) Aprendizagem de procedimentos vários em Medicina Intensiva como:

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	12/2022	01/2027	5/10

SERVIÇO DE MEDICINS INTENSIVA**Programa de Formação em Medicina Intensiva**

- entubação difícil;
- traqueotomia percutânea;
- cricotiroidotomia;
- toracocentese e colocação/manutenção de drenos torácicos;
- cateterização venosa e arterial;
- desfibrilhação e cardioversão, pace externo e pacemaker transcutâneo;
- pericardiocentese;
- técnicas de monitorização hemodinâmica invasivas e minimamente invasivas;
- paracentese;
- sonda naso-gástrica

o) Avaliação, estabilização e terapêutica de doentes cirúrgicos;

p) Avaliação, estabilização e terapêutica de doentes traumatizados;

q) Avaliação, estabilização e terapêutica de intoxicados;

r) Terapêutica metabólica e nutricional;

s) Terapêutica analgésica e sedativa;

t) Suporte de doentes em morte cerebral e observação de provas de morte cerebral;

u) Apoio às equipas de emergência médica interna e à equipa de urgência;

v) Transporte de doentes críticos;

w) Aplicação dos princípios éticos da prática da Medicina Intensiva;

x) Aprendizagem de técnicas de comunicação com colegas, doentes e familiares;

y) Aplicação dos conceitos de gestão de camas críticas hospitalares;

z) Avaliação de doentes neurocríticos: diagnóstico, monitorização multimodal, orientação, terapêutica e prevenção de complicações;

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	12/2022	01/2027	6/10

SERVIÇO DE MEDICINS INTENSIVA**Programa de Formação em Medicina Intensiva**

aa) Integrar equipas de serviço aos doentes internados em camas de Nível II, familiarizando-se com critérios de diagnóstico, monitorização, tratamento de suporte de insuficiências e falências orgânicas destes doentes;

ab) Integrar conceito de indicadores de gravidade que permitam escalação para camas de Nível III ou deslocação para outras enfermarias do hospital.

Estágio em Ecocardiografia - 3 meses – a realizar preferencialmente na Unidade de Ecocardiografia do serviço de Cardiologia do Hospital de Santa Cruz (Coordenador Dra. Regina Ribeiras. Diretor – Professor Doutor Pedro Pulido Adragão)

Objetivos:

Aquisição de competência básica no uso de ecocardiografia transtorácica para avaliação e diagnóstico de patologia cardíaca frequente no doente crítico, com realização de um número ideal de 50 exames (com um mínimo de 30) e exposição a, pelo menos, 25 exames de ecocardiografia transesofágica.

Estágio em Broncofibroscopia - 2 meses - a realizar em Unidade de Técnicas Pneumológicas preferencialmente no Serviço de Pneumologia do Hospital Prof. Fernando da Fonseca (Diretor – Dr. Fernando Rodrigues). Em alternativa e dependendo da capacidade formativa deste serviço pode ser equacionada a Unidade de Técnicas de Pneumologia do Hospital de Vila Franca de Xira.

Objetivos:

Aquisição de competência básica na realização de broncofibroscopia, com a realização de um número mínimo de 50 exames, com ênfase na realização de técnicas de colheita para estudo microbiológico, particularmente realização de lavado broncoalveolar, controlo de hemorragia e entubação guiada por broncofibroscopia.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	12/2022	01/2027	7/10

SERVIÇO DE MEDICINS INTENSIVA**Programa de Formação em Medicina Intensiva**

Estágio em Unidade Neurocrítica - 3 meses - a realizar em UCI a designar

Objetivos:

Aquisição de competências no diagnóstico, monitorização multimodal, procedimentos e terapêutica de doentes neurocríticos, em particular no trauma cranioencefálico, no acidente vascular cerebral isquémico ou hemorrágico e na hemorragia subaracnoídea.

Estágio em Sala de Emergência - 1 mês – em local a designar, estando em curso a organização da Sala de Reanimação do Serviço de Urgência Geral da ULSLO, para que seja possível o estágio na nossa Unidade de Saúde.

Objetivos:

- a) Formação avançada na área de emergência hospitalar, com prática integralmente dedicada às atividades da Sala de Emergência do Serviço de Urgência;
- b) Aquisição de competências na avaliação inicial, estabilização, definição de estratégia de diagnóstico e triagem de nível de internamento em doente agudo ou agudizado crítico;
- c) Treino do raciocínio ético, da interação multidisciplinar e da comunicação e decisão em ambiente de emergência.

Estágio opcional — 3 meses.

Aquisição de competências em áreas específicas da Medicina Intensiva ou com utilidade para a prática da Medicina Intensiva, acordadas entre o interno, o orientador de formação e a direção de Serviço de Medicina Intensiva.

A sequência dos estágios a realizar durante o 3.º e 4.º ano do internato pode ser diferente da expressa, de acordo com a logística disponível nos diversos locais de formação. Preconiza-se que o Estágio em Medicina Intensiva em Serviço com idoneidade total seja o mais continuado possível, idealmente durante 12 meses ininterruptos.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	12/2022	01/2027	8/10

SERVIÇO DE MEDICINS INTENSIVA**Programa de Formação em Medicina Intensiva****Competências complementares a adquirir até ao 4º ano:**

é recomendado a frequência em diferentes formações pós-graduadas nomeadamente as organizadas pela SPCI, ESICM, Reanima, em particular na área da infeção e sépsis, ventilação, ecografia (nomeadamente FAST ou idealmente eFAST), SAV, ATLS ou ETC, entre outros.

Durante os 3º e 4º anos os internos continuarão a fazer os serviços de urgência em coordenação com os seus diferentes locais de estágio. O tempo de permanência em cada uma das UCIs é feito de forma a ser distribuído de forma equitativa.

4) Quinto ano – 12 meses

A realizar na UCI 1, UCI 3 ou 4, do CHLO (Diretor Dr. Pais Martins), de acordo com o plano de formação previamente estabelecido.

Estágio em Medicina Intensiva

Objetivos:

- a) Continuação da aprendizagem desenvolvida nos estágios anteriores, dando sequência, em termos de diagnóstico, gestos e atitudes, aos objetivos adquiridos durante a formação específica do terceiro ano;
- b) Aquisição de competência para o exercício autónomo da medicina intensiva nas suas diversas dimensões;
- c) Durante os últimos anos da formação, particularmente no último, em que exercerá a sua atividade sob tutela, mas já com apreciável grau de autonomia, o interno participará nas atividades de formação de médicos internos mais jovens.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	12/2022	01/2027	9/10

SERVIÇO DE MEDICINS INTENSIVA**Programa de Formação em Medicina Intensiva****Atividades Complementares**

1. Congressos e Simpósios – Será fomentada a participação em congressos/simpósios nacionais e internacionais, nomeadamente os organizados no âmbito da SPCI e ESICM
2. Apresentação de casos clínicos e estudos – apoio na realização e apresentação sob a forma de abstract de trabalhos científicos (sejam casos clínicos ou estudos clínicos) nos acima referidos congressos/simpósios.
3. Publicações – fomentar a publicação de trabalhos em revistas indexadas.
4. Fomentar a participação em sessões clínicas (incluindo análises de mortalidade) e *Journal Club*
5. Incentivar a elaboração e revisão de protocolos com interesse para a Medicina Intensiva
6. Estimular a participação em equipas de emergência intra-hospitalar e pré-hospitalar (curso de VMER), consoante as preferências individuais de cada interno

Avaliação

Sem prejuízo da avaliação contínua e a efetuada no final de cada estágio, o interno será submetido a avaliação, no final de cada ano do PFMI. Essa avaliação consiste em 3 partes:

1. Relatório anual, que deve ser apresentado até dia 31 de janeiro, e sua discussão
2. Prova prática (realização de uma história clínica e sua discussão)
3. Prova teórica (sobre temas abrangentes da Medicina Intensiva de acordo com o COBATRICE)

A realização da avaliação anual deve ser realizada preferencialmente durante o mês de março.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	12/2022	01/2027	10/10



SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA

Formação em Cuidados Intensivos dos Internos com formação Específica

Internos de Formação Especializada de Outras Especialidades

(Objetivos e avaliação do Estágio em Medicina Intensiva)

1. Medicina Interna (Portaria n.º 614/2010 de 3 de agosto)

Estágio em Medicina Intensiva — estágio obrigatório de seis meses em Unidade de Cuidados Intensivos polivalente.

Objetivos de desempenho — execução de técnicas de diagnóstico e terapêutica em doentes em cuidados intensivos, nomeadamente:

- monitorização hemodinâmica invasiva e não-invasiva,
- monitorização clínica e laboratorial da função respiratória,
- cateterismo venoso central percutâneo;
- cateterismo venoso e arterial;
- entubação endotraqueal e manutenção da via aérea;
- suporte ventilatório mecânico e suas diferentes modalidades;
- suporte nutricional entérico e parentérico;
- instalação de estimulador cardíaco transvenoso provisório;
- pericardiocentese;
- drenagem pleural;
- técnicas de substituição da função renal
- treino em ecografia point-of-care no contexto do doente crítico.

Objetivos de conhecimento:

- a) Conhecimento de critérios de admissão e alta das unidades de cuidados intensivos;
- b) Vigilância e monitorização (invasiva / não invasiva) de doentes em estado crítico;
- c) Diagnóstico, abordagem inicial e terapêutica do doente em choque;
- d) Reanimação cardiorrespiratória;
- e) Alterações do equilíbrio hidro-electrolítico e ácido-base;

Assinado por : **António José Pereira Pais Martins**

Num. de Identificação: BI04475691

Data: 2024.11.13 10:28:37 Hora padrão de GMT

Elaboração	Aprovação	Próxima edição
Dra. Cláudia Martins	Dr. Pais Martins	01/2027
	122	Página: 1/13





SERVIÇO DE MEDICINS INTENSIVA

Programa de Formação em Medicina Intensiva

- f) Suporte transfusional no doente crítico;
- g) Fisiopatologia e terapêutica das alterações agudas da coagulação;
- h) Insuficiência respiratória: fisiopatologia e instituição de ventilação mecânica invasiva e não-invasiva.
- i) Fisiopatologia da lesão renal aguda, e indicações para terapêutica substitutiva da função renal.
- j) Síndromes coronárias agudas.
- k) Insuficiência Cardíaca - fisiopatologia e abordagem terapêutica.
- l) Fisiopatologia e terapêutica da insuficiência hepática;
- m) Hemorragia Digestiva – abordagem e terapêutica;
- n) Fisiopatologia e terapêutica das crises endócrinas agudas;
- o) Sépsis e Choque Séptico;
- p) Avaliação e tratamento em pós-operatório;
- q) Abordagem do grande politraumatizado;
- r) Abordagem das principais intoxicações;
- s) Nutrição entérica e parentérica;
- t) Analgesia e sedação;
- u) Diagnóstico de morte cerebral e manutenção do potencial dador;
- v) Cuidados paliativos em cuidados intensivos. Decisões de fim-de-vida.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	12/2022	01/2027	2/13

SERVIÇO DE MEDICINS INTENSIVA**Programa de Formação em Medicina Intensiva****2. Infeciologia (Portaria n.º 28/2011 de 10 de janeiro)**

Estágio em Medicina intensiva — duração de 3 a 6 meses (opcional)

Objetivos do desempenho: treino das técnicas de medicina intensiva em geral e particularmente das inerentes à manutenção e suporte de funções orgânicas, nomeadamente:

- Entubação endotraqueal
- Traqueostomia
- Ventilação mecânica invasiva e não-invasiva
- Colocação de cateteres venosos centrais
- Colocação de linhas arteriais
- Colocação de drenos torácicos
- Monitorização hemodinâmica minimamente invasiva
- Técnicas de substituição da função renal
- Treino em ecografia *point-of-care* no contexto do doente crítico.

Objetivos do conhecimento: conhecimento da fisiopatologia, do quadro clínico e laboratorial, da monitorização e do tratamento da insuficiência respiratória aguda, das diferentes formas de choque (com particular relevo da sépsis grave e choque séptico) e das infeções graves do sistema nervoso. São também objetivos específicos do estágio em Medicina Intensiva, os seguintes:

1. Avaliação do doente crítico. Prioridades no suporte de vida (A, B, C, D, E);
2. Conhecimento de critérios de admissão e alta das unidades de cuidados intensivos;
3. Vigilância e monitorização (invasiva / não invasiva) de doentes em estado crítico;
4. Reanimação cardiorrespiratória;
5. Diagnóstico, abordagem inicial e terapêutica do doente em choque;
6. Insuficiência respiratória: fisiopatologia e instituição de ventilação mecânica invasiva e não-invasiva.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	12/2022	01/2027	3/13



SERVIÇO DE MEDICINS INTENSIVA

Programa de Formação em Medicina Intensiva

7. Fisiopatologia da lesão renal aguda, e indicações para terapêutica substitutiva da função renal.
8. Sépsis e Choque Séptico
9. Desequilíbrios hidro-electrolíticos e ácido-base.
10. Outros temas: alimentação entérica e parentérica; analgesia e sedação.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	12/2022	01/2027	4/13

SERVIÇO DE MEDICINS INTENSIVA**Programa de Formação em Medicina Intensiva****3. Nefrologia (Portaria n.º 300/2013 de 11 de outubro)**

Estágio de Medicina Intensiva – 3 a 6 meses.

Objetivos de desempenho e conhecimento:

- a) Reanimação Cardiorrespiratória (RCR);
- b) Técnicas de suporte avançado de vida;
- c) Contacto com doentes com falência múltipla de órgãos, sua avaliação e seu tratamento;
- d) Avaliação, prevenção e tratamento das situações de insuficiência renal aguda em doentes com instabilidade hemodinâmica. Seleção, prescrição e execução das técnicas de substituição da função renal nesses doentes;
- e) Treino nas técnicas invasivas habitualmente realizadas em unidades de cuidados intensivos, designadamente entubação oro-traqueal, cateterismo vascular, com realce para o cateterismo das veias subclávias.

4. Cardiologia (Portaria n.º 46/2011 de 26 de janeiro)

Estágio em UCI Polivalente incluído no Estágio de Medicina Interna (1º ano, 11 meses, 3 dos quais em UCI polivalente).

Objetivos de conhecimento:

- a) Aperfeiçoamento da colheita de dados anamnéticos;
- b) Conhecimento da fisiopatologia e etiologia das síndromes mais frequentes;
- c) Estabelecimento de raciocínio lógico e sequência diagnóstica na abordagem de situações clínicas diversas;
- d) Aprofundamento da indicação e interpretação dos meios complementares de diagnóstico mais frequentemente solicitados pela medicina interna;
- e) Consolidação de normas terapêuticas e aprofundamento dos conhecimentos de farmacologia clínica;
- f) Correlação dos conhecimentos adquiridos com as síndromes cardiológicas mais frequentes.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	12/2022	01/2027	5/13

SERVIÇO DE MEDICINS INTENSIVA**Programa de Formação em Medicina Intensiva****Objetivos de desempenho:**

- a) Colheita de histórias clínicas, com elaboração dos respectivos relatórios;
- b) Vivência das grandes síndromes médicas da urgência;
- c) Aprendizagem de técnicas de monitorização dos parâmetros vitais;
- d) Aplicação de técnicas de reanimação cardiorespiratória.

Descrição do desempenho: Actividade a desenvolver na enfermaria, consulta e urgência geral; e permanência efectiva de três meses em unidade de cuidados intensivos polivalente.

5. Pneumologia (Portaria n.º 342/2016 de 29 de dezembro)**Estágio em Medicina Intensiva — 4 meses****Objetivos de desempenho:**

- a) Monitorização clínica e laboratorial da função respiratória;
- b) Cateterismo arterial percutâneo e cateterismo venoso central;
- c) Entubação orotraqueal, manutenção da via aérea e suporte ventilatório mecânico; ventilação não invasiva;
- d) Suporte nutricional entérico e parentérico;
- e) Técnicas de analgesia e sedação;
- f) Drenagens torácicas
- g) Broncofibroscopia.

Objetivos de conhecimento

- a) Vigilância e monitorização (invasiva e não invasiva) de doentes críticos;
- b) Reanimação cardiorrespiratória;
- c) Equilíbrio hidro-electrolítico e ácido-base;
- d) Quadros fisiopatológicos, clínicos e laboratoriais da insuficiência respiratória e da insuficiência de outros órgãos

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	12/2022	01/2027	6/13

SERVIÇO DE MEDICINS INTENSIVA**Programa de Formação em Medicina Intensiva****6. Hematologia Clínica (Portaria n.º 7/2020 de 16 de janeiro)**

A formação Especializada em Hematologia Clínica compõe-se de um período de formação básica em Medicina Interna e em Cuidados Intensivos e de um período de formação específica em Hematologia Clínica.

Formação básica — 12 meses, incluindo Medicina Interna (6 a 9 meses) e Cuidados Intensivos (3 a 6 meses).

Estágio em Cuidados Intensivos Polivalentes:**Objetivos de desempenho:**

- a) Adquirir treino no âmbito do diagnóstico, avaliação e monitorização de doentes em situação crítica;
- b) Aprofundar a capacidade de obtenção da história clínica, hierarquização dos problemas e elaboração de propostas terapêuticas no doente crítico;
- c) Aquisição da capacidade de executar procedimentos invasivos e técnicas de suporte inerentes ao doente crítico.

Objetivos de conhecimento:

- a) Aprofundar conhecimentos sobre as complicações hematológicas associadas ao doente crítico;
- b) Aprofundar conhecimentos nas situações de falência multiorgânica e choque.

7. Oncologia Médica (Portaria n.º 84/2010 de 10 de fevereiro)

A formação básica (24 meses) inclui estágio em Medicina Interna (21 meses) e estágio em cuidados intensivos polivalentes (3 meses).

Estágio em Cuidados Intensivos:**Objetivos de desempenho:**

- a) Aquisição da capacidade de avaliar, monitorizar e tratar doentes em situações críticas, necessitando de uma intervenção rápida e eficaz;

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	12/2022	01/2027	7/13

SERVIÇO DE MEDICINS INTENSIVA**Programa de Formação em Medicina Intensiva**

b) Desenvolvimento da capacidade de obtenção da história clínica, hierarquização dos problemas e elaboração das estratégias de diagnóstico e de terapêutica nos doentes com alterações graves da homeostasia;

c) Aquisição da capacidade de executar as técnicas e os procedimentos invasivos inerentes ao doente crítico e ser capaz de efetuar a monitorização contínua dos parâmetros vitais com auxílio de equipamento adequado e meios de suporte avançado de vida

Objetivos de conhecimento:

a) Aprofundar os conhecimentos obtidos no estágio de medicina interna, com especial atenção para as técnicas de abordagem e suporte do doente crítico;

b) Desenvolver os conhecimentos já adquiridos, particularmente na área das alterações hidro- eletrolíticas e metabólicas dos estados de choque e da falência multiorgânica.

8. Gastroenterologia (Portaria n.º 317/2012 de 11 de outubro)**Estágio em Medicina Intensiva — 3 meses.****Objetivos de desempenho:**

- a) Capacidade de orientação de doentes críticos e treino das técnicas de medicina intensiva elementares;
- b) Contacto com técnicas específicas realizadas em unidades de cuidados intensivos, nomeadamente entubação endotraqueal, ventilação mecânica e cateterização central.

Objetivos de conhecimento:

i. Aquisição de conhecimentos de Medicina Intensiva, particularmente as situações que frequentemente acompanham as doenças do foro digestivo, nomeadamente instabilidade hemodinâmica, insuficiência cardíaca, respiratória e renal, e sépsis.

ii. Hemorragia digestiva.

iii. Síndrome hepato-renal.

iv. Doença hepática crónica.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	12/2022	01/2027	8/13

SERVIÇO DE MEDICINS INTENSIVA**Programa de Formação em Medicina Intensiva****9. Imunohemoterapia (Portaria n.º 191/2018 de 3 de julho)**

Estágio em cuidados intensivos polivalentes:

Objetivos de desempenho:

- a) Diagnóstico e tratamento de emergências médico-cirúrgicas, nomeadamente as situações de transfusão maciça;
- b) Terapêutica substitutiva nas hemorragias clinicamente relevantes.

Objetivos de conhecimento:

Noções de suporte imediato e avançado de vida.

Neste estágio é dado relevo à integração nos cuidados médico-cirúrgicos prestados no âmbito da sala de emergência médica do serviço de urgência, bem como à participação nos cuidados prestados no contexto do bloco cirúrgico, nomeadamente em cirurgias de elevado consumo de componentes e derivados do sangue, nomeadamente cirurgia ortopédica, vascular ou cardiotorácica, bem como em contexto de transplante hepático.

10. Imunoalergologia (Portaria n.º 28/2011 de 10 de janeiro)

Estágios opcionais — 4 meses.

Medicina intensiva (incluído na duração global do estágio de medicina interna) — 2 meses.

Objetivos de desempenho:

- a) Capacidade de identificar e resolver situações graves de obstrução das vias aéreas e paragem respiratória, nomeadamente casos de atingimento pulmonar por:
 - Inalação de fumo e ou calor;
 - Edema pulmonar;
 - Síndrome de dificuldade respiratória do adulto;
 - Asma grave ou outras patologias associadas a insuficiência respiratória;
 - Agudização de doenças respiratórias crónicas;
 - Infecções respiratórias;

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	12/2022	01/2027	9/13



SERVIÇO DE MEDICINS INTENSIVA

Programa de Formação em Medicina Intensiva

- Doenças neuromusculares com compromisso da ventilação;
 - Obstrução da via aérea por edema laríngeo;
- b) Capacidade de identificar e resolver situações de instabilidade hemodinâmica e choque, incluindo a aquisição de competência para reanimar situações de paragem cardíaca, nomeadamente em casos de:
- Enfarte agudo do miocárdio, angina instável ou insuficiência cardíaca grave;
 - Arritmias e perturbações da condução;
 - Tamponamento;
 - Embolia pulmonar;
 - Dissecção da aorta;
 - Crise hipertensiva;
- c) Capacidade de diagnosticar e tratar:
- Alterações do equilíbrio hidro-electrolítico e ácido-base;
 - Agudização de diabetes;
 - Alterações da coagulação;
 - Sépsis nas suas várias formas de apresentação;
 - Infecções graves causadas por microrganismos de origem comunitária ou nosocomial, utilizando regras de boa prática na utilização de terapêutica antimicrobiana e imunoterapia;
 - Reações medicamentosas adversas graves;
 - Anafilaxia;

Capacidade de execução autónoma de:

- 1) Entubação endotraqueal;
- 2) Traqueostomias;
- 3) Controlo de ventilação mecânica;
- 4) Colocação de cateteres venosos centrais e linhas arteriais.

Objetivos de conhecimento:

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	12/2022	01/2027	10/13

SERVIÇO DE MEDICINS INTENSIVA**Programa de Formação em Medicina Intensiva**

- a) Reconhecer, priorizar as necessidades e formular planos de procedimentos quando em presença de patologia variada do foro médico, designadamente nas seguintes situações:
- 1) Prioridades no suporte de vida;
 - 2) Disfunção/falência respiratória;
 - 3) Disfunção/falência cardio-circulatória;
 - 4) Diagnóstico e terapêutica de desequilíbrios hidro-electrolíticos e ácido-base
 - 5) Sépsis e choque séptico;
 - 6) Estratégias de utilização de oxigénio, prevenção de tromboembolismo venoso, fármacos vasoativos, princípios de antibioterapia, hemoderivados, nutrição entérica e parentérica.

11. Cirurgia Geral (Portaria n.º 48/2011 de 26 de Janeiro)

Estágio opcional com duração de 3 meses, preferencialmente no 2º ou 3º ano de formação em Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente.

Objetivos do desempenho: contacto, participação e execução de técnicas próprias da medicina intensiva e necessárias à prática de cirurgia geral;

Objetivos de conhecimento: aquisição de conhecimentos fisiopatológicos, semiológicos e clínicos na área da medicina intensiva necessários à prática de cirurgia geral;

12. Anestesiologia (Portaria n.º 92-A/2016 de 15 de abril)

O estágio em Medicina Intensiva deve ser realizado, por um período de tempo de 6 meses consecutivos, em Unidades/Serviços de Medicina Intensiva Polivalentes, podendo o restante tempo ser realizado em Unidades especializadas (Unidades de Cuidados Intensivos de Neurocirurgia, Unidades de Queimados, Unidades de Cuidados Intensivos de Doenças Infeciosas, Unidades de Cuidados Intensivos de Pediatria, Unidade de Cuidados Intensivos de Neonatologia, Unidade de Cuidados Intensivos de Cirurgia Cardiotorácica). O período de urgência é realizado obrigatoriamente na Unidade de Cuidados Intensivos.

Objetivos de desempenho e conhecimento:

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	12/2022	01/2027	11/13

SERVIÇO DE MEDICINS INTENSIVA**Programa de Formação em Medicina Intensiva**

- Aquisição de experiência clínica na abordagem e manuseamento do doente crítico, nomeadamente com falência multiorgânica;
- Aquisição de conhecimentos em suporte de funções vitais, nomeadamente na abordagem do doente em falência hemodinâmica e desequilíbrios hídricos e eletrolíticos;
- Conhecer normas básicas de alimentação entérica e parentérica;
- Abordagem do doente em insuficiência respiratória aguda e/ou crónica agudizada;
- Conceitos avançados de ventilação invasiva;
- Ventilação não invasiva, suas indicações e contraindicações;
- Aplicação e interpretação de monitorização invasiva e minimamente invasiva;
- Conhecimento na área das técnicas de substituição renal;
- Princípios de antibioterapia;
- Experiência na terapêutica de pós-operatórios complicados;
- Abordagem e tratamento do doente politraumatizado;
- Treino em ecografia *point-of-care* no contexto do doente crítico.
- Conceito de morte cerebral e manutenção de dadores de órgãos;
- Conhecer a problemática da colheita de órgãos e transplantação;
- Executar de forma segura o transporte do doente crítico;
- Organização, custos e avaliação de qualidade nesta área;
- Aprender a utilidade de índices de gravidade;
- Abordagem clínica das situações sem indicação para investimento terapêutico;
- Conhecer os problemas éticos e deontológicos relacionados com o doente intensivo;
- Fomentar a necessidade do trabalho de equipa multidisciplinar e multiprofissional;
- Aquisição de experiência na transmissão da informação aos familiares do doente crítico

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	12/2022	01/2027	12/13

SERVIÇO DE MEDICINS INTENSIVA**Programa de Formação em Medicina Intensiva****Avaliação**

Relativamente à avaliação:

Se o estágio for inferior a 3 meses a avaliação será contínua, e a nota atribuída pela unidade onde está colocado o interno.

Se a duração for de 3 meses a 6 meses, a avaliação será contínua, mas constará também de um momento formal de avaliação, com discussão de um relatório de atividades e discussão de um caso clínico, previamente sorteado.

Se o estágio for igual ou superior a 6 meses a avaliação será também contínua, e terá um momento formal de avaliação com discussão de relatório de atividades e prova teórico-prática.

Questionário

Será solicitado no final do estágio de Medicina Intensiva, que seja preenchido um questionário anónimo, sobre a sua satisfação com a aprendizagem na Medicina Intensiva.

Edição		Próxima edição	Página
Nº 01	12/2022	01/2027	13/13